BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

MÃ LƯU TRỮ

MÃ NGƯỜI BỆNH
2610036327

MÃ HỒ SƠ
2610163961

THÔNG QUA MỔ CẤP CỨU: 16/10/2026

BỆNH ÁN

NĂM 2026

HỌ TÊN: LÊ DOÃN CẦN **TUỔI: 70**

ĐỊA CHỈ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

NHẬP KHOA:
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Ngày: 16/10/2026
Giường/phòng: H027/ Cấp cứu lưu 141

CHUYỂN VIỆN/ KHOA:
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Ngày: 16/10/2026
Giường/phòng: H004/ Phòng hồi tỉnh P214
Khoa Ngoại tổng hợp
Ngày: 19/10/2026
Giường/phòng: H053/ Phòng 302

XUẤT VIỆN:
Khoa Ngoại tổng hợp
Ngày: .../.../...
Giường/phòng: H053/ Phòng 302

MÃ BỆNH: K81.8
MÃ BỆNH KÈM THEO : I50.9;J18.9;J44.1

A - BỆNH ÁN

I. Lý do vào viện: đau bụng mạn sườn trái Ngày thứ của bệnh

II. Hỏi bệnh:

1. Quá trình bệnh lý: *(khởi phát, diễn biến, chẩn đoán, điều trị tuyến dưới v.v...)*

Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà,khoảng 19h ngày 15/10/2026, bệnh nhân xuấthiện đau bụng mạn sườn trái lan lên ngực sauxương ức. Ngày nay đau tăng --> CC ĐHY

2. Tiền sử bệnh:

+ Bản thân:*(phát triển thể lực từ nhỏ tới lớn, những bệnh đã mắc, phương pháp ĐTr, tiêm phòng, ăn uống, sinh hoạt v.v)*

tiền sử viêm phếquản mạn tính, sỏi túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Đặc điểm liên quan đến bệnh:

TT	*Ký hiệu*	Thời gian (tính theo tháng)	TT	*Ký hiệu*	Thời gian (tính theo tháng)
01	- Dị ứng ☐		04	- Thuốc lá ☐	
02	- Ma túy ☐		05	- Thuốc lào ☐	
03	- Rượu bia ☐		06	Khác ☐	

+ Gia đình: *(Những người trong gia đình: bệnh đã mắc, đời sống, tinh thần, vật chất v.v..)*

chưa phát hiện bất thường

(Người bệnh/ Người nhà người bệnh đọc kỹ các thông tin trên trước khi ký)

Họ tên bệnh nhân: LÊ DOÃN CẦN Ký tên[1]



III. Khám bệnh:

1. Toàn thân: *(ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động v.v...)*

Bệnh nhân tỉnh

Niêm mạc hồng

Mạch	98	*lần/phút*
Nhiệt độ	36.9	*°C*
Huyết áp	152/86	*mmHg*
Nhịp thở	16	*lần/ph*
Cân nặng	66	*kg*

2.Bệnh ngoại khoa:

3. Các cơ quan:

+ Tuần hoàn: Tim đều

T1, T2 rõ

+Hô hấp: Tự thở khí phòng SpO2 95%
RRPN giảm vùng đáy phổi 2 bên

+Tiêu hoá: Bụng mềm, chướng hơi nhẹ
Điểm đau McBurney (+)
PUTB(+), CUPM (-)
+ Thận- Tiết niệu- Sinh dục: Bập bềnh thận: âm tính
Vỗ hông lưng: âm tính

+ Thần kinh: Bệnh nhân tỉnh G 15 điểm
Không có dấu hiện thần kinh khu trú
Gáy mềm
Dấu hiệu màng não: âm tính
+ Cơ- Xương- Khớp: Không đau hay hạn chế vận động khớp

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

+ Tai- Mũi - Họng: chưa phát hiện bất thường

+ Răng- Hàm- Mặt: chưa phát hiện bất thường

+ Mắt: chưa phát hiện bất thường

+ Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác: chưa phát hiện bất thường

4. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm: Xét nghiệm cơ bản

5. Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 70 tuổi, tiền sử viêm phếquản mạn tính, sỏi túi mậtTheo lời kể của bệnh nhân và người nhà,khoảng 19h ngày 15/10/2026, bệnh nhân xuấthiện đau bụng mạn sườn trái lan lên ngực sauxương ức. Ngày nay đau tăng --> CC ĐHYKhám: Bệnh nhân tỉnh, mệt GCS 15 điểmDa, niêm mạc hồngKhông phù, không xuất huyết dưới daHiện không sốtTự thở khí phòng SpO2 95%RRPN giảm vùng đáy phổi 2 bênTim đều M: 98 ck/phútHA: 152/86mmHgBụng mềm, chướng hơi nhẹĐiểm đau McBurney (+)PUTB(+), CUPM (-)Cơ tròn tự chủ

IV. Chẩn đoán khi vào khoa điều trị:

+ Bệnh chính: R10.0 - Đau bụng cấp tính
+ Bệnh kèm theo (*nếu có*):
+ Phân biệt:

V. Tiên lượng: Dè dặt

VI. Hướng điều trị: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

BÁC SĨ LÀM BỆNH ÁN(2)

Ký số bởi: **ĐỖ ĐỨC MINH**
Ngày ký: **10:14:46 20/10/2026**

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã số: 40/BV - 01
Số vào viện:

PHIẾU KHÁM BỆNH VÀO VIỆN

BUỒNG KHÁM BỆNH :

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** 2. Sinh ngày: 13/06/1956 3. Tuổi: 70
4. Số điện thoại: 0986 410 715 5. Giới tính: Nam 6. Nghề nghiệp:
7. Dân tộc: Kinh 8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
10. Nơi làm việc: 11. Đối tượng: Dịch vụ
12. Nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu:
13. BHYT giá trị đến ngày: Số thẻ BHYT:
14. Họ tên, địa chỉ người nhà cần báo tin: con: Lê Doãn Thái Bình
Điện thoại số: 0332 482 350
15. Đến khám lúc: 08 : 17 ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

II. CHẨN ĐOÁN:

1. Chẩn đoán của nơi giới thiệu: đau bụng
2. Chẩn đoán vào viện: R10.0 - Đau bụng cấp tính

III. TÌNH TRẠNG VÀO VIỆN: 1. Cấp cứu ☐ 2. Không cấp cứu ☒

IV. CHO VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA

Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Đơn vị trực thuộc:

V. CHÚ Ý

08 : 19 Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Mã hồ sơ
2610163961

Mã bệnh nhân
2610036327

BS Nguyễn Thành Trung

Ký số bởi: **Nguyễn Thành Trung**
Ngày ký: **08:19:27 16/10/2026**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Sổ vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BSCK ngoại tiêu hóa

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Buồng: Khoa Cấp cứu Giường: K011
Chẩn đoán: TD viêm túi mật do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B - Khoa Ngoại tổng hợp

NGUYỄN ĐẠI HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

BS Nguyễn Thành Trung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BSCK ngoại tiêu hóa

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Buồng: Khoa Cấp cứu Giường: K011
Chẩn đoán: TD viêm túi mật do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B - Khoa Ngoại tổng hợp

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Bệnh nhân nam 70 tuổi,
Tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật
Vào viện vì đau bụng HSP 1 ngày nay, đau âm ỉ liên tục, không sốt
Khám:
Bệnh nhân tỉnh
Da, niêm mạc hồng
Không phù, không xuất huyết dưới da
Không sốt
BỤng ấn đau HSP
Putb (+)
Siêu âm: Túi mật: căng nhẹ, kích thước 94x38mm, thành dày quanh chu vi 5mm, lắng đọng cholesterol thànhtúi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi lớn nhất đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhấtđường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quan
XN máu: Crp 9
-> Chẩn đoán: Theo dõi viêm túi mật cấp do sỏi
-> Về Ck ngoại tiêu hóa có chỉ định chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc, hoàn thiện bilan mổ
-> Dặn nhịn ăn, giải thích gia đình
-> Hội chẩn lại khi có kết quả

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BSCK ngoại tiêu hóa

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Buồng: Khoa Cấp cứu Giường: K011
Chẩn đoán: K80.0 - Sỏi túi mật kèm viêm túi mật cấp tính//Viêm túi mật cấp do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B - Khoa Ngoại tổng hợp

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Bệnh nhân nam 70 tuổi,
Tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật
Vào viện vì đau bụng HSP 1 ngày nay, đau âm ỉ liên tục, không sốt
Khám:
Bệnh nhân tỉnh
Da, niêm mạc hồng
Không phù, không xuất huyết dưới da
Không sốt
BỤng ấn đau HSP
Putb (+)
Siêu âm: Túi mật: căng nhẹ, kích thước 94x38mm, thành dày quanh chu vi 5mm, lắng đọng cholesterol thànhtúi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi lớn nhất đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhấtđường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quan
XN máu: Crp 9
-> Chẩn đoán: Theo dõi viêm túi mật cấp do sỏi
-> Về Ck ngoại tiêu hóa có chỉ định chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc, hoàn thiện bilan mổ
-> Dặn nhịn ăn, giải thích gia đình
-> Hội chẩn lại khi có kết quả

==========

CLVT: Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại trángngang đoạn góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọcrãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung
-> Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp do sỏi
-> Về Ck ngoại tiêu hóa có chỉ định mổ cấp cứu
-> Hoàn thiện bilan, dặn nhịn ăn, giải thích gia đình
-> Báo BS cọc I

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

BÁC SĨ KHÁM BỆNH



BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BSCK ngoại tiêu hóa

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Buồng: Khoa Cấp cứu Giường: K011
Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp
Nơi thực hiện: Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B - Khoa Ngoại tổng hợp

NGUYỄN ĐẶNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] Xin ý kiến chẩn đoán và điều trị

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

BS. Nguyễn Tiến Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Sổ vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS Khoa Nội tim mạch

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Buồng: Phòng hồi tỉnh Giường: H004
Chẩn đoán: Rối loạn nhịp tim/Sau mổ cắt túi mật
Nơi thực hiện: Phòng 5067 - Trung tâm Tim mạch

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Sổ vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS Khoa Nội tim mạch

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Buồng: Phòng hồi tỉnh Giường: H004
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính//Rối loạn nhịp tim/Sau mổ cắt túi mật
Nơi thực hiện: Phòng 5067 - Trung tâm Tim mạch

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Hội chẩn tim mạch
Chẩn đoán: Suy tim EF 36% - Block nhánh trái hoàn toàn - theo dõi hội chứng vành cấp
Về tim mạch xin làm thêm troponin T lần 3 + proBNP + làm lại ECG
Hạn chế dịch truyền
Thêm Furosemid 20mg x 2 ống TMC sáng - chiều
Có kết quả xin hội chẩn lại

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

ThS.BSNT. Lê Minh Ngọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Sổ vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS Khoa Nội hô hấp

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Buồng: Phòng hồi tỉnh Giường: H004
Chẩn đoán: Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật
Nơi thực hiện: Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A - Khoa Hô hấp

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS Khoa Nội hô hấp

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Buồng: Phòng hồi tỉnh Giường: H004
Chẩn đoán: J47 - Giãn phế quản//Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật
Nơi thực hiện: Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A - Khoa Hô hấp

NGUYỄN ĐÀNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú]

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Hội chẩn Hô hấp - GMHS
Bệnh nhân nam 70 tuổi
Tiền sử: Hay ho khạc đờm, kèm thi thoảng khó thở khò khè nhiều năm nay, chưa có đợt cấp nhập viện.
Không hút thuốc
Khám hiện tại:
BN tỉnh
Thở khí phòng, nói câu dài
Ho khạc đờm xanh
Còn sốt nhẹ 37.8 độ C
Phổi ran ẩm nổ hay đáy
XN: BC 16.56 -> 17.25, CRPhs 9.48
KMĐM: pH 7.319, pCO2/pO2 47.8/104.2, HCO3- 22.2
CLVT ngực (16/10): Hình ảnh theo dõi giãn phế quản bội nhiễm phổi hai bên. Vài đám đông đặc - xẹp phổi, vài nốt đặc, kính mờ rải rác hai phổi (theo dõi viêm). Nốt vôi hóa thùy trên phổi trái. Vài dải xơ - xẹp rải rác hai phổi, co kéo nhẹ nhu mô lân cận. Giảm nhẹ thể tích phổi trái. Dịch khoang màng phổi trái. Dày kèm vôi hóa màng phổi trái. Vôi hóa rải rác LAD và động mạch chủ ngực. Vài hạch trung thất.
Chẩn đoán: Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi COPD - Sau mổ cắt túi mật
Điều trị hiện tại: kháng sinh Meropenem NT2
Về Hô hấp:
- Đồng ý với điều trị của quý khoa
- Thêm thuốc:
+ Anroro Ellipta 62.5/25mcg x 01 hộp, hít qua đường miệng ngày 01 liều, sáng
+ Ventolin 200 dose x 01 bình, xịt hít qua đường miệng 02 nhát khi khó thở, tối đa 08 nhát xịt/ngày
- Xét nghiệm lại KMĐM, xét chỉnh máy thở
- Lấy đờm làm xét nghiệm AFB 2 lần, Xpert MTB, VK nuôi cấy
- Cấy máu hai tay khi sốt
- Tập PHCN hô hấp tích cực
- Có bất thường xin hội chẩn lại
BS Việt - BS Dương

Ngày 17 tháng 10 năm 2026

BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths.BSNT. Nguyễn Đông Dương

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS CK Nội tim mạch

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Buồng: Phòng 302 Giường: H053
Chẩn đoán: Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng 5067 - Trung tâm Tim mạch

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] Về tình trạng tiêu hóa ổn định, BỆNH NHÂN có chỉ định ra viện -> Xin ý kiến điều trị hoặc xin đơn thuốc ra viện

Ngày 20 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS CK Nội tim mạch

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Buồng: Phòng 302 Giường: H053
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính//Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng 5067 - Trung tâm Tim mạch

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] Về tình trạng tiêu hóa ổn định, BỆNH NHÂN có chỉ định ra viện -> Xin ý kiến điều trị hoặc xin đơn thuốc ra viện

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Hội chẩn Tim mạch
BN nam 70 tuổi
Chẩn đoán: Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Hiện tại lâm sàng NYHA 2, không đau ngực
HA 120/70 mmHg
Ý kiến Tim mạch: xin thêm thuốc
- Uperio 50 mg x 1 viên/ngày, chia 2 lần, mỗi lần 1/2 viên sáng-chiều
- Jardiance 10mg x 1 viên/ngày
- Spirolacton 25mg x 1 viên/ngày
- Furosemid 40 mg x 1 viên/ngày

Theo dõi số lượng nước tiểu, cân bằng dịch vào- dịch ra

Ngày 20 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

ThS.BSNT. Trần Tiến Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS CK Nội hô hấp

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Buồng: Phòng 302 Giường: H053
Chẩn đoán: Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A - Khoa Hô hấp

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] Về tình trạng tiêu hóa ổn định, BỆNH NHÂN có chỉ định ra viện -> Xin ý kiến điều trị hoặc xin đơn thuốc ra viện

NGUYỄN ĐẠI HƯNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

2610163961

MS: 12/BV-01
Số vào viện: 2610163961

PHIẾU KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

Kính gửi: BS CK Nội hô hấp

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Buồng: Phòng 302 Giường: H053
Chẩn đoán: J47 - Giãn phế quản//Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - Suy tim EF 36% - Sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Nơi thực hiện: Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A - Khoa Hô hấp

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

YÊU CẦU KHÁM CHUYÊN KHOA

Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] Về tình trạng tiêu hóa ổn định, BỆNH NHÂN có chỉ định ra viện -> Xin ý kiến điều trị hoặc xin đơn thuốc ra viện

KẾT QUẢ KHÁM CHUYÊN KHOA

HỘI CHẨN HÔ HẤP - NGOẠI TIÊU HÓA LẦN 02 (Xin xem thêm ý kiến HC lần 01)
Bệnh nhân nam, 70 tuổi
Khám hiện tại Bệnh nhân tỉnh, ho đờm xanh, không sốt, không đau ngực, nói câu dài, không co kéo cơ hô hấp phụ, phổi thông khí đều, rale nổ, còn sonde tiểu, dẫn lưu ổ bụng
Xét nghiệm: BC 9.8 G/L, CRPhs 9.4>> 10.8
Khí máu động mạch: pH 7.45, pCO2 45.6, pO2 73.3
CLVT ngực: Hình ảnh theo dõi giãn phế quản bội nhiễm phổi hai bên. Vài đám đông đặc - xẹp phổi, vài nốt đặc, kính mờ rải rác hai phổi (theo dõi viêm). Nốt vôi hóa thùy trên phổi trái. Vài dải xơ - xẹp rải rác hai phổi, co kéo nhẹ nhu mô lân cận. Giảm nhẹ thể tích phổi trái. Dịch khoang màng phổi trái. Dày kèm vôi hóa màng phổi trái. Vôi hóa rải rác LAD và động mạch chủ ngực. Vài hạch trung thất.
Xquang ngực 19/10: Các đám mờ rải rác 1/2 dưới hai phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản hai phổi. Góc sườnhoành hai bên mờ. Vòm hoành trái lên cao. Hình tim to. Quai động mạch chủ vồng
Điện tim QTc 453ms
Creatinin 64

VỀ HÔ HẤP
Đề nghị hội chẩn chuyên khoa DƯỢC LÂM SÀNG xét thêm kháng sinh amikacin
Duy trì thuốc giãn phế quản theo HC lần trước: Anoro Ellipta x 01 lọ. Hít qua đường miệng ngày 01 liều, sáng và Ventolin 100mcg x 01 lọ. Dùng khi KHÓ THỞ, xịt hít qua đường miệng mỗi lần 02 nhát xịt, xịt hít thêm 02 nhát nếu còn KHÓ THỞ, tối đa 08 nhát xịt/ngày
Tập PHCN hô hấp
Lấy đờm xét nghiệm AFB, genexpert, vi khuẩn nuôi cấy
Xét nghiệm lại khí máu động mạch khí trời
Đánh giá lâm sàng, bilan viêm, Xquang ngực thẳng nghiêng sau 48 giờ thêm kháng sinh
Có kết quả xin HC lại hoặc khi có bất thường

BS Việt - BS Huyền A

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

BÁC SĨ KHÁM BỆNH



Nguyễn Vũ Hoàng Việt

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Giải phẫu bệnh

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Phòng: Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm: Túi mật
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Đăng Hưng
Nơi lấy bệnh phẩm: N
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng 7083, K.Giải Phẫu Bệnh, Tầng 7, Nhà A2 mở rộng**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Giải phẫu bệnh			
1	Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin	423.000	**X**

Ghi chú: **Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Khoa Giải phẫu bệnh thực hiện.**

LIS: 31939486

21:14 Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

Ký số bởi: NGUYỄN ĐĂNG HƯNG
Ngày ký: 21:13:43 16/10/2026

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH CẮT LỚP VI TÍNH

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: Không thẻ BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Phòng: Khoa Cấp cứu
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính/ TD viêm túi mật do sỏi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
CLVT			
1	Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)	**965.000**	**31931862**
2	Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)[Có tiêm thuốc, chưa bao gồm thuốc cản quang]	**1.293.000**	**31931862**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

BS Nguyễn Thành Trung
Ký số bởi: **Nguyễn Thành Trung**
Ngày ký: **10:47:16 16/10/2026**

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH DV

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: Không thẻ BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Phòng: Khoa Cấp cứu
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính/ TD viêm túi mật do sỏi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Kháng sinh			
1	Kháng sinh ưu tiên quản lý	**0**	**31929510**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

BS Nguyễn Thành Trung

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH THỦ THUẬT

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: Không thẻ BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Phòng: Khoa Cấp cứu
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính/ TD viêm túi mật do sỏi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Thủ thuật			
1	Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ	**64.000**	**31925538**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

BS Nguyễn Thành Trung

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Trần Việt Đức
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31939777

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

ThS. BS. Trần Việt Đức
Ký số bởi: **TRẦN VIỆT ĐỨC**
Ngày ký: **23:47:00 16/10/2026**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH X - QUANG

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật cấp do sỏi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
X - quang			
1	Chụp X-quang tại giường	**126.000**	**31939732**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 16 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

ThS. BS. Trần Việt Đức

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm phổi sau mổ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Văn Sự
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31945457

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự
Ký số bởi: **NGUYỄN VĂN SỰ**
Ngày ký: **08:05:10 17/10/2026**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm phổi sau mổ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Văn Sự
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31945458

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm phổi sau mổ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Văn Sự
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31945459

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm phổi sau mổ Viêm túi mật cấp do sỏi

Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Văn Sự
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31945460

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi tỉnh P214
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm phổi sau mổ Viêm túi mật cấp do sỏi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Siêu âm			
1	Siêu âm tim cấp cứu tại giường	**348.000**	**31945519**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 17 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự

Chú ý khi siêu âm:
- Người bệnh siêu âm bàng quang, tiền liệt tuyến (nam), tử cung phần phụ và thai dưới 12 tuần (nữ) phải nhịn căng tiểu.
- Người bệnh đánh giá túi mật nhịn ăn 4-6 tiếng, đánh giá chức năng túi mật nhịn ăn 12 tiếng trước khi siêu âm.
- Người bệnh siêu âm động mạch thận, siêu âm đàn hồi mô gan và định lượng gan nhiễm mỡ phải nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước khi siêu âm (không uống nước có ga trước khi siêu âm).
*- Người bệnh siêu âm đầu dò qua đường âm đạo phải đi tiểu hết và **chỉ thực hiện kỹ thuật này ở người bệnh đã quan hệ tình dục**.*

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS: Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Thị Liễu
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31972838

Ngày 19 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

Ký số bởi: **Nguyễn Thị Liễu**
Ngày ký: **08:55:46 19/10/2026**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã hồ sơ: 2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

XN Cấp cứu
x XN Thường Mã Bệnh án:

Họ tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986 410 715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Bệnh phẩm:
Bệnh phẩm VS:
Bác sỹ chỉ định: Nguyễn Thị Liễu
Nơi lấy bệnh phẩm:
Thời gian lấy mẫu: Loại mẫu: Người lấy mẫu:
Thời gian nhận mẫu: Tình trạng mẫu: Người nhận mẫu:
Địa điểm: **Phòng lấy mẫu máu khoa Gây mê**

STT	Dịch vụ	Đơn giá DV	BH
Dịch vụ độc lập			
1	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	27.000	**X**

Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phương pháp xét nghiệm do Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau thực hiện.

LIS: 31972840

Ngày 19 tháng 10 năm 2026
BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Siêu âm			
1	Siêu âm tim cấp cứu tại giường	**348.000**	**31972846**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 19 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

Chú ý khi siêu âm:
- Người bệnh siêu âm bàng quang, tiền liệt tuyến (nam), tử cung phần phụ và thai dưới 12 tuần (nữ) phải nhịn căng tiểu.
- Người bệnh đánh giá túi mật nhịn ăn 4-6 tiếng, đánh giá chức năng túi mật nhịn ăn 12 tiếng trước khi siêu âm.
- Người bệnh siêu âm động mạch thận, siêu âm đàn hồi mô gan và định lượng gan nhiễm mỡ phải nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước khi siêu âm (không uống nước có ga trước khi siêu âm).
*- Người bệnh siêu âm đầu dò qua đường âm đạo phải đi tiểu hết và **chỉ thực hiện kỹ thuật này ở người bệnh đã quan hệ tình dục**.*

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH X - QUANG

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
X - quang			
1	Chụp X-quang tại giường	**126.000**	**31973209**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 19 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH THỦ THUẬT

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi
Chẩn đoán đi kèm:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Thủ thuật			
1	Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] [Thở máy 01 ngày điều trị, Chưa bao gồm bộ dây máy thở cao tần các loại, các cỡ]	**1.066.000**	**31972892**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 19 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH THỦ THUẬT

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp
Phòng: Phòng 307
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật hoại tử/ Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi bệnh phổi
Chẩn đoán đi kèm: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Thủ thuật			
1	Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [vết loét/vết thương phần mềm dài ≤ 15cm]	**270.000**	**32001276**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 20 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

Ký số bởi: NGUYỄN ĐĂNG HƯNG
Ngày ký: 11:26:14 20/10/2026

Ghi chú: .....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

2610163961

PHIẾU CHỈ ĐỊNH SIÊU ÂM

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Năm sinh: 1956 Giới tính:Nam
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: BHYT
Điện thoại: 0986 410 715

Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp
Phòng: Phòng 307
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi
Chẩn đoán đi kèm: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc

NGUYỄN TĂNG HƯNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn giá DV	Mã kết nối
Siêu âm			
1	Siêu âm ổ bụng	**145.000**	**31986894**

Mã BN: 2610036327

2610036327

Ngày 20 tháng 10 năm 2026
BÁC SĨ CHỈ ĐỊNH
(Kí và ghi rõ họ tên)

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

Ký số bởi: **ĐỖ ĐỨC MINH**
Ngày ký: **06:55:40 20/10/2026**

Chú ý khi siêu âm:
- Người bệnh siêu âm bàng quang, tiền liệt tuyến (nam), tử cung phần phụ và thai dưới 12 tuần (nữ) phải nhịn căng tiểu.
- Người bệnh đánh giá túi mật nhịn ăn 4-6 tiếng, đánh giá chức năng túi mật nhịn ăn 12 tiếng trước khi siêu âm.
- Người bệnh siêu âm động mạch thận, siêu âm đàn hồi mô gan và định lượng gan nhiễm mỡ phải nhịn ăn ít nhất 4 tiếng trước khi siêu âm (không uống nước có ga trước khi siêu âm).
*- Người bệnh siêu âm đầu dò qua đường âm đạo phải đi tiểu hết và **chỉ thực hiện kỹ thuật này ở người bệnh đã quan hệ tình dục**.*

Ghi chú: .....

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31961767**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thanh Hiền
Thời gian lấy mẫu: 04:30 19/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Chu Thị Thủy
Thời gian nhận mẫu: 05:21 19/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: ThS. Lê Hoàng Anh

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
MIỄN DỊCH				
Định lượng Troponin T [Máu](Suy tim EF 36%, ST chênh xuống)	12.1	ng/L	(< 14)	A2_C8K_E801.4.2
Định lượng ProBNP (NTproBNP) [Máu](suy tim EF 36%, proBNP gần nhất 1004)	**1783.00**	pg/mL	(< 125)	A2_C8K_E801.4.2
HÓA SINH				
Định lượng Glucose [Máu]	**6.6**	mmol/L	(4.56 - 5.6)	A2_C8K_C702.1.2
Định lượng Creatinin [Máu]	64	µmol/L	(62 - 106)	A2_C8K_C702.1.2
Định lượng CRP hs (CRP high sesitive) [Máu]	**10.83**	mg/dL	(< 0.5)	A2_C8K_C702.1.2
Điện giải đồ (Na+,K+,Cl-)				
Ion Natri	136	mmol/L	(136 - 145)	A2_C8K_ISE1.1
ion Kali	3.6	mmol/L	(3.4 - 4.5)	A2_C8K_ISE1.1
Ion Clorua	101	mmol/L	(98 - 107)	A2_C8K_ISE1.1

Nhận xét: Định lượng Troponin T [Máu](Suy tim EF 36%, ST chênh xuống): Theo dõi thêm

Lần in: 1, 05 giờ 56, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:55 19/10/2026, CKI. Nguyễn Ích Việt

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

CKI. Nguyễn Ích Việt

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31961767**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thanh Hiền
Thời gian lấy mẫu: 04:30 19/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Chu Thị Thủy
Thời gian nhận mẫu: 04:55 19/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
KHÍ MÁU				
Khí máu động mạch(+lactate)				
Nhiệt độ	36.7	°C		A2_B221_GMHS
FiO2	0.21			A2_B221_GMHS
pH động mạch	7.450		(7.35 - 7.45)	A2_B221_GMHS
pCO2	**45.60**	mmHg	(35 - 45)	A2_B221_GMHS
pO2	73.3	mmHg	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
HCO3	**31.10**	mmol/L	(21 - 29.5)	A2_B221_GMHS
HCO3 chuẩn	**29.2**	mmol/L	(21 - 26)	A2_B221_GMHS
BB	**53.8**	mmol/L	(45 - 52)	A2_B221_GMHS
BE	**6.50**	mmol/L	(-2 - 2)	A2_B221_GMHS
SO2	96.0	%	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
Lactat (Khí máu)	**0.5**	mmol/L	(0.6 - 1.4)	A2_B221_GMHS
MetHb	0.5	%	(0.04 - 1.52)	A2_B221_GMHS

Lần in: 1, 05 giờ 12, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:09 19/10/2026,

PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31958755**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thanh Hiền
Thời gian lấy mẫu: 09:47 18/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Chu Thị Thủy
Thời gian nhận mẫu: 09:54 18/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: ThS. Đỗ Đức Thắng

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
MIỄN DỊCH				
Định lượng Troponin T [Máu]	11.4	ng/L	(< 14)	Pro-3-A2-e801-3-2

Nhận xét: Định lượng Troponin T [Máu]: Theo dõi thêm

Lần in: 1, 10 giờ 40, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
10:38 18/10/2026, ThS. Đỗ Đức Thắng

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

ThS. Đỗ Đức Thắng

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31957107**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

VILAS MED 068

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Trần Xuân Bách
Thời gian lấy mẫu: 04:50 18/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương
Thời gian nhận mẫu: 05:42 18/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: ThS. Đàm Đình Tranh

NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
HÓA SINH				
Định lượng Glucose [Máu]	5.3	mmol/L	(4.56 - 5.6)	Pro-3-A2-c503-2 QTKT.177.XN (*)
Điện giải đồ (Na+,K+,Cl-)				
Ion Natri	138	mmol/L	(136 - 145)	Pro-3-A2-ISE-2
ion Kali	3.7	mmol/L	(3.4 - 4.5)	Pro-3-A2-ISE-2
Ion Clorua	104	mmol/L	(98 - 107)	Pro-3-A2-ISE-2

Lần in: 1, 06 giờ 03, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
06:02 18/10/2026, ThS. Đàm Đình Tranh

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

ThS. Đàm Đình Tranh

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31957107**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Trần Xuân Bách
Thời gian lấy mẫu: 04:50 18/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương
Thời gian nhận mẫu: 04:50 18/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
KHÍ MÁU				
Khí máu động mạch(thêm lactat)				
Nhiệt độ	37.4	°C		A2_B221_GMHS
FiO2	0.21			A2_B221_GMHS
pH động mạch	**7.451**		(7.35 - 7.45)	A2_B221_GMHS
pCO2	38.30	mmHg	(35 - 45)	A2_B221_GMHS
pO2	70.5	mmHg	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
HCO3	26.00	mmol/L	(21 - 29.5)	A2_B221_GMHS
HCO3 chuẩn	**26.2**	mmol/L	(21 - 26)	A2_B221_GMHS
BB	49.6	mmol/L	(45 - 52)	A2_B221_GMHS
BE	**2.80**	mmol/L	(-2 - 2)	A2_B221_GMHS
SO2	95.4	%	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
Lactat (Khí máu)	0.6	mmol/L	(0.6 - 1.4)	A2_B221_GMHS
MetHb	0.5	%	(0.04 - 1.52)	A2_B221_GMHS

Lần in: 1, 05 giờ 41, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:16 18/10/2026,

PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

Mã số bệnh phẩm: **31945457**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Lê Văn Tiến
Thời gian lấy mẫu: 15:51 17/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Trần Thị Cúc
Thời gian nhận mẫu: 16:11 17/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: CN. Lê Hữu Lộc

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
MIỄN DỊCH				
Định lượng Troponin T [Máu]	**19.3**	ng/L	(< 14)	Pro-3-A2-e801-3-2
Định lượng ProBNP (NTproBNP) [Máu]	**1004.00**	pg/mL	(< 125)	Pro-3-A2-e801-3-1

Nhận xét: Định lượng Troponin T [Máu]: Theo dõi thêm

Lần in: 1, 17 giờ 12, ngày 17 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
17:12 17/10/2026, CN. Lê Hữu Lộc

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

CN. Lê Hữu Lộc

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

Mã số bệnh phẩm: **31939779**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: ThS.BS Trần Việt Đức
Thời gian lấy mẫu: 04:54 17/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Phạm Thị Khương
Thời gian nhận mẫu: 05:17 17/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: CN. Chu Quang Huy

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
MIỄN DỊCH				
Định lượng Troponin T [Máu]	11.3	ng/L	(< 14)	A2_C8K_E801.4.2
HÓA SINH				
Định lượng Glucose [Máu]	**8.6**	mmol/L	(4.56 - 5.6)	A2_C8K_C702.1.2
Điện giải đồ (Na+,K+,Cl-)				
Ion Natri	138	mmol/L	(136 - 145)	A2_C8K_ISE1.1
ion Kali	4.1	mmol/L	(3.4 - 4.5)	A2_C8K_ISE1.1
Ion Clorua	103	mmol/L	(98 - 107)	A2_C8K_ISE1.1

Nhận xét: Định lượng Troponin T [Máu]: Theo dõi thêm

Lần in: 1, 06 giờ 16, ngày 17 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
06:15 17/10/2026, CN. Chu Quang Huy

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

CN. Chu Quang Huy

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31939777**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: ThS.BS Trần Việt Đức
Thời gian lấy mẫu: 00:03 17/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Lê Thị Yến
Thời gian nhận mẫu: 00:04 17/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
KHÍ MÁU				
Khí máu động mạch				
Nhiệt độ	37.5	°C		A2_B221_GMHS
FiO2	0.40			A2_B221_GMHS
pH động mạch	**7.319**		(7.35 - 7.45)	A2_B221_GMHS
pCO2	**47.80**	mmHg	(35 - 45)	A2_B221_GMHS
pO2	**104.2**	mmHg	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
HCO3	23.90	mmol/L	(21 - 29.5)	A2_B221_GMHS
HCO3 chuẩn	22.2	mmol/L	(21 - 26)	A2_B221_GMHS
BB	45	mmol/L	(45 - 52)	A2_B221_GMHS
BE	**-2.20**	mmol/L	(-2 - 2)	A2_B221_GMHS
SO2	97.5	%	(70 - 99)	A2_B221_GMHS
Lactat (Khí máu)	1.4	mmol/L	(0.6 - 1.4)	A2_B221_GMHS
MetHb	0.6	%	(0.04 - 1.52)	A2_B221_GMHS

Lần in: 1, 00 giờ 27, ngày 17 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
00:20 17/10/2026,

PGS.TS. Vũ Hoàng Phương

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TẠI CHỖ

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

Mã số bệnh phẩm: **31924908**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT:

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thành Trung
Thời gian lấy mẫu: 08:26 16/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc
Thời gian nhận mẫu: 16:05 16/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
POCT ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH				
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	**10.5**	mmol/L	5.6 - 6.9	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Lần in: 1, 16 giờ 06, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
16:05 16/10/2026, BS. Đỗ Giang Phúc

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

BS. Đỗ Giang Phúc

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

Mã số bệnh phẩm: **31929027**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT:

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thành Trung
Thời gian lấy mẫu: 09:34 16/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc
Thời gian nhận mẫu: 09:34 16/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
KHÍ MÁU				
Khí máu động mạch				
Nhiệt độ	37.0	°C		A2_B221_CC
FiO2	0.21			A2_B221_CC
pH động mạch	7.422		(7.35 - 7.45)	A2_B221_CC
pCO2	40.80	mmHg	(35 - 45)	A2_B221_CC
pO2	**59.1**	mmHg	(70 - 99)	A2_B221_CC
HCO3	25.90	mmol/L	(21 - 29.5)	A2_B221_CC
HCO3 chuẩn	25.4	mmol/L	(21 - 26)	A2_B221_CC
BB	49	mmol/L	(45 - 52)	A2_B221_CC
BE	1.70	mmol/L	(-2 - 2)	A2_B221_CC
SO2	93.7	%	(70 - 99)	A2_B221_CC
Lactat (Khí máu)	0.6	mmol/L	(0.6 - 1.4)	A2_B221_CC
MetHb	0.5	%	(0.04 - 1.52)	A2_B221_CC

Lần in: 1, 09 giờ 48, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
09:47 16/10/2026,

TL.Trưởng khoa

BS. Đỗ Giang Phúc

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Xét nghiệm
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31924908**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT:

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thành Trung
Thời gian lấy mẫu: 08:26 16/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc
Thời gian nhận mẫu: 08:46 16/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: Nguyễn Thị Ngát

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
MIỄN DỊCH				
Định lượng Troponin T [Máu]	10.9	ng/L	(< 14)	Pro-2-A2-e801-3-1
HÓA SINH				
Định lượng Ure [Máu]	5.1	mmol/L	(2.76 - 8.07)	Pro-2-A2-c503-1
Định lượng Creatinin [Máu]	65	µmol/L	(59 - 104)	Pro-2-A2-c503-1
Mức lọc cầu thận ước tính (CKD-EPI Creatinine 2021)	97.5	mL/phút/ 1.73 m²		A2
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]	9.9	µmol/L	(< 24)	Pro-3-A2-c503-2
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]	**5.6**	µmol/L	(< 3.4)	Pro-2-A2-c503-2
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	46	U/L	(10 - 50)	Pro-2-A2-c503-1
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	34	U/L	(10 - 50)	Pro-2-A2-c503-1
Đo hoạt độ Lipase [Máu]	26.7	U/L	(13 - 60)	Pro-3-A2-c503-1
Định lượng CRP hs (CRP high sesitive) [Máu]	**9.48**	mg/dL	(< 0.5)	Pro-2-A2-c503-1
Điện giải đồ (Na+,K+,Cl-)				
Ion Natri	139	mmol/L	(136 - 145)	Pro-2-A2-ISE-1
ion Kali	4.0	mmol/L	(3.4 - 4.5)	Pro-2-A2-ISE-1
Ion Clorua	100	mmol/L	(98 - 107)	Pro-2-A2-ISE-1

Nhận xét: Mức lọc cầu thận ước tính (CKD-EPI Creatinine 2021): Điều kiện áp dụng: Bệnh nhân trên 18 tuổi, không béo phì, nồng độ creatinine máu ổn định
Định lượng Troponin T [Máu]: Theo dõi thêm

Lần in: 1, 09 giờ 34, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
09:33 16/10/2026, ThS. Lê Hoàng Anh

TL. Trưởng Khoa Xét Nghiệm

ThS. Đỗ Đức Thắng

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2022; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Huyết học - Truyền máu
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31961767**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thanh Hiền
Thời gian lấy mẫu: 04:30 19/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Chu Thị Thủy
Thời gian nhận mẫu: 05:10 19/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: CN. Dương Thu Phương

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser)				
Số lượng hồng cầu (RBC)	4.70	T/L	(4 - 5.9)	A2_ADVIA2120.4
Huyết sắc tố (Hemoglobin)	142	g/L	(125 - 175)	A2_ADVIA2120.4
Hematocrit (HCT)	0.44	L/L	(0.4 - 0.53)	A2_ADVIA2120.4
Thể tích trung bình Hồng cầu (MCV)	93.5	fL	(80 - 100)	A2_ADVIA2120.4
Huyết sắc tố trung bình Hồng cầu (MCH)	30	pg	(26 - 34)	A2_ADVIA2120.4
Nồng độ huyết sắc tố trung bình Hồng Cầu (MCHC)	323	g/L	(315 - 363)	A2_ADVIA2120.4
Dải phân bố Hồng cầu- Hệ số biến thiên (RDW-CV)	12.3	%	(11 - 17)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng Bạch cầu (WBC)	9.86	G/L	(4 - 10)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn trung tính (NEUT%)	72.1	%	(45 - 75)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu Lympho (LYM%)	**16.4**	%	(20 - 45)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu MONO%	6.40	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS%)	3.0	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Basơ (BASO%)	0.30	%	(0 - 2)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn trung tính (NEUT)	7.1	G/L	(1.8 - 7.5)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu Lympho (LYMPT)	1.62	G/L	(0.8 - 4.5)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu Mono (MONO)	0.63	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS)	0.30	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Base (BASO)	0.03	G/L	(0 - 0.1)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng Tiểu cầu (PLT)	318	G/L	(150 - 450)	A2_ADVIA2120.4
Thể tích trung bình Tiểu cầu (MPV)	7.70	fL	(5 - 20)	A2_ADVIA2120.4

Lần in: 1, 05 giờ 17, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:17 19/10/2026, Nguyễn Phúc Minh Hoàng

Nguyễn Phúc Minh Hoàng

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2012; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

Ký số bởi: NGUYỄN PHÚC MINH HOÀNG
Ngày ký: 05:17:54 19/10/2026

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Huyết học - Truyền máu
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31957107**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

VILAS MED 162

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Trần Xuân Bách
Thời gian lấy mẫu: 04:50 18/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: PGS.TS. Vũ Hoàng Phương
Thời gian nhận mẫu: 05:32 18/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: CN. Trương Bảo Ngọc

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser)				
Số lượng hồng cầu (RBC)	4.38	T/L	(4 - 5.9)	QTKT.01 (*)
Huyết sắc tố (Hemoglobin)	135	g/L	(125 - 175)	QTKT.02 (*)
Hematocrit (HCT)	0.42	L/L	(0.4 - 0.53)	A2_ADVIA2120.3
Thể tích trung bình Hồng cầu (MCV)	94.6	fL	(80 - 100)	A2_ADVIA2120.3
Huyết sắc tố trung bình Hồng cầu (MCH)	31	pg	(26 - 34)	A2_ADVIA2120.3
Nồng độ huyết sắc tố trung bình Hồng Cầu (MCHC)	325	g/L	(315 - 363)	A2_ADVIA2120.3
Dải phân bố Hồng cầu- Hệ số biến thiên (RDW-CV)	12.9	%	(11 - 17)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng Bạch cầu (WBC)	**13.59**	G/L	(4 - 10)	QTKT.03 (*)
Tỷ lệ bạch cầu đoạn trung tính (NEUT%)	**78.8**	%	(45 - 75)	A2_ADVIA2120.3
Tỷ lệ bạch cầu Lympho (LYM%)	**13.1**	%	(20 - 45)	A2_ADVIA2120.3
Tỷ lệ bạch cầu MONO%	6.00	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.3
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS%)	0.5	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.3
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Basơ (BASO%)	0.20	%	(0 - 2)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng bạch cầu đoạn trung tính (NEUT)	**10.7**	G/L	(1.8 - 7.5)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng bạch cầu Lympho (LYMPT)	1.78	G/L	(0.8 - 4.5)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng bạch cầu Mono (MONO)	**0.82**	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS)	0.07	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Base (BASO)	0.02	G/L	(0 - 0.1)	A2_ADVIA2120.3
Số lượng Tiểu cầu (PLT)	299	G/L	(150 - 450)	QTKT.04 (*)
Thể tích trung bình Tiểu cầu (MPV)	8.40	fL	(5 - 20)	A2_ADVIA2120.3

Lần in: 1, 05 giờ 37, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:37 18/10/2026, CN. Trương Bảo Ngọc

TL. Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu



CN. Trương Bảo Ngọc

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2012; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

Ký số bởi: Trương Bảo Ngọc
Ngày ký: 05:37:25 18/10/2026

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Huyết học - Truyền máu
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31939779**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT: GD4010128348609

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính BS Chỉ định: ThS.BS Trần Việt Đức
Thời gian lấy mẫu: 04:54 17/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: Phạm Thị Khương
Thời gian nhận mẫu: 05:17 17/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: CN. Mai Thị Thu Phương

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser)				
Số lượng hồng cầu (RBC)	4.26	T/L	(4 - 5.9)	A2_ADVIA2120.4
Huyết sắc tố (Hemoglobin)	129	g/L	(125 - 175)	A2_ADVIA2120.4
Hematocrit (HCT)	0.40	L/L	(0.4 - 0.53)	A2_ADVIA2120.4
Thể tích trung bình Hồng cầu (MCV)	93.8	fL	(80 - 100)	A2_ADVIA2120.4
Huyết sắc tố trung bình Hồng cầu (MCH)	30	pg	(26 - 34)	A2_ADVIA2120.4
Nồng độ huyết sắc tố trung bình Hồng Cầu (MCHC)	324	g/L	(315 - 363)	A2_ADVIA2120.4
Dải phân bố Hồng cầu- Hệ số biến thiên (RDW-CV)	12.5	%	(11 - 17)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng Bạch cầu (WBC)	**17.25**	G/L	(4 - 10)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn trung tính (NEUT%)	**88.0**	%	(45 - 75)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu Lympho (LYM%)	**4.9**	%	(20 - 45)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu MONO%	5.50	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS%)	0.1	%	(0 - 8)	A2_ADVIA2120.4
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Basơ (BASO%)	0.10	%	(0 - 2)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn trung tính (NEUT)	**15.2**	G/L	(1.8 - 7.5)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu Lympho (LYMPT)	0.85	G/L	(0.8 - 4.5)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu Mono (MONO)	**0.95**	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS)	0.01	G/L	(0 - 0.8)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Base (BASO)	0.01	G/L	(0 - 0.1)	A2_ADVIA2120.4
Số lượng Tiểu cầu (PLT)	274	G/L	(150 - 450)	A2_ADVIA2120.4
Thể tích trung bình Tiểu cầu (MPV)	7.60	fL	(5 - 20)	A2_ADVIA2120.4

Lần in: 1, 05 giờ 43, ngày 17 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
05:42 17/10/2026, CN. Hoàng Tiến Lộc

TL. Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu

CN. Hoàng Tiến Lộc

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2012; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

Ký số bởi: Hoàng Tiến Lộc
Ngày ký: 05:43:31 17/10/2026

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Huyết học - Truyền máu
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31924908**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT:

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thành Trung
Thời gian lấy mẫu: 08:26 16/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc
Thời gian nhận mẫu: 08:45 16/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: Trần Thiện Chiến

HUỲNH ĐĂNG HƯNG

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
TRUYỀN MÁU				
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)	**O/+**			A2_ORTHO_VISION_3
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm Laser)				
Số lượng hồng cầu (RBC)	5.04	T/L	(4 - 5.9)	A2_XN-1000.41747
Huyết sắc tố (Hemoglobin)	149	g/L	(125 - 175)	A2_XN-1000.41747
Hematocrit (HCT)	0.46	L/L	(0.4 - 0.53)	A2_XN-1000.41747
Thể tích trung bình Hồng cầu (MCV)	91.9	fL	(80 - 100)	A2_XN-1000.41747
Huyết sắc tố trung bình Hồng cầu (MCH)	30	pg	(26 - 34)	A2_XN-1000.41747
Nồng độ huyết sắc tố trung bình Hồng Cầu (MCHC)	322	g/L	(315 - 363)	A2_XN-1000.41747
Dải phân bố Hồng cầu- Hệ số biến thiên (RDW-CV)	12.8	%	(11 - 17)	A2_XN-1000.41747
Số lượng Bạch cầu (WBC)	**16.56**	G/L	(4 - 10)	A2_XN-1000.41747
Tỷ lệ bạch cầu đoạn trung tính (NEUT%)	**87.9**	%	(45 - 75)	A2_XN-1000.41747
Tỷ lệ bạch cầu Lympho (LYM%)	**4.1**	%	(20 - 45)	A2_XN-1000.41747
Tỷ lệ bạch cầu MONO%	7.10	%	(0 - 8)	A2_XN-1000.41747
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS%)	0.0	%	(0 - 8)	A2_XN-1000.41747
Tỷ lệ bạch cầu đoạn ưa Basơ (BASO%)	0.20	%	(0 - 2)	A2_XN-1000.41747
Số lượng bạch cầu đoạn trung tính (NEUT)	**14.6**	G/L	(1.8 - 7.5)	A2_XN-1000.41747
Số lượng bạch cầu Lympho (LYMPT)	**0.68**	G/L	(0.8 - 4.5)	A2_XN-1000.41747
Số lượng bạch cầu Mono (MONO)	**1.17**	G/L	(0 - 0.8)	A2_XN-1000.41747
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Acid (EOS)	0.00	G/L	(0 - 0.8)	A2_XN-1000.41747
Số lượng bạch cầu đoạn ưa Base (BASO)	0.03	G/L	(0 - 0.1)	A2_XN-1000.41747
Số lượng Tiểu cầu (PLT)	325	G/L	(150 - 450)	A2_XN-1000.41747
Thể tích trung bình Tiểu cầu (MPV)	9.80	fL	(5 - 20)	A2_XN-1000.41747
ĐÔNG MÁU				
Thời gian Prothrombin (PT)	15.1	s		A2_STAR_R_MAX.3
Tỷ lệ Prothrombin (PT)	82	%	(70 - 140)	A2_STAR_R_MAX.3
INR	1.09		(0.8 - 1.2)	A2_STAR_R_MAX.3
Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)	28.9	s		A2_STAR_R_MAX.3

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2012; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

BỆNH VIỆN ĐH Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Khoa Huyết học - Truyền máu
Mẫu thường

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số bệnh phẩm: **31924908**
Mã số hồ sơ: **2610163961**
Số thẻ BHYT:

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Năm sinh: **1956** Nam/Nữ: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Khoa/Phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính BS Chỉ định: Ths.BSNT Nguyễn Thành Trung
Thời gian lấy mẫu: 08:26 16/10/2026 Loại mẫu: Máu Người lấy mẫu: BS. Đỗ Giang Phúc
Thời gian nhận mẫu: 08:45 16/10/2026 Tình trạng mẫu: Đạt Người nhận mẫu: Trần Thiện Chiến

XÉT NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ THAM CHIẾU	MÁY XN/ PPXN
Tỷ lệ APTT bệnh/chứng	0.98		(0.8 - 1.2)	A2_STAR_R_MAX.3
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động	**7.49**	g/L	(2 - 4)	A2_STAR_R_MAX.3

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Lần in: 1, 09 giờ 18, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Xác nhận kết quả:
09:16 16/10/2026, CN. Mai Thị Thu Phương

TL. Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu

CN. Nguyễn Xuân Thành

(*) Xét nghiệm đã được công nhận theo ISO 15189:2012; (**) Xét nghiệm thực hiện theo PXN chuyển gửi

Ký số bởi: NGUYEN XUAN THANH
Ngày ký: 09:18:39 16/10/2026

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25583548

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** NS: **1956** Giới tính: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau BS Chỉ định: Nguyễn Thị Liễu
Chẩn đoán lâm sàng: Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật
Chẩn đoán bệnh: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính
Dịch vụ: Chụp Xquang tại giường

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

KẾT QUẢ

KỸ THUẬT: Chụp Xquang tim phổi thẳng (tại giường).

MÔ TẢ:

- Lồng ngực cân đối, không thấy bất thường xương và phần mềm thành ngực.
- Góc sườn hoành hai bên mờ. Vòm hoành trái lên cao.
- Phổi hai bên: các đám mờ rải rác 1/2 dưới hai phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản hai phổi.
- Rốn phổi hai bên không thấy bất thường.
- Hình tim to. Quai động mạch chủ vồng

KẾT LUẬN:

Các đám mờ rải rác 1/2 dưới hai phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản hai phổi. Góc sườn hoành hai bên mờ. Vòm hoành trái lên cao. Hình tim to. Quai động mạch chủ vồng

Digital signed by: NGUYỄN DUY THẮNG
Date: 10:11 19/10/2026
Printed by: NGUYỄN DUY THẮNG
Date: 10:11 19/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 19 *tháng* 10 *năm* 2026 10:11:56
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Duy Thắng

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25560779

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** NS: **1956** Giới tính: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Khoa chỉ định: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau BS Chỉ định: Trần Việt Đức
Chẩn đoán lâm sàng: Viêm túi mật cấp do sỏi
Chẩn đoán bệnh: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính
Dịch vụ: Chụp Xquang tại giường

KẾT QUẢ

KỸ THUẬT: Chụp Xquang tim phổi thẳng (tại giường).

MÔ TẢ:

- Lồng ngực cân đối, không thấy bất thường xương và phần mềm thành ngực.
- Góc sườn hoành hai bên mờ. Vòm hoành trái lên cao.
- Phổi hai bên: các đám mờ rải rác 1/2 dưới hai phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản hai phổi.
- Rốn phổi hai bên không thấy bất thường.
- Hình tim to. Quai động mạch chủ vồng
- Nội khí quản đúng vị trí.

KẾT LUẬN:

Các đám mờ rải rác 1/2 dưới hai phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản hai phổi. Góc sườn hoành hai bên mờ. Vòm hoành trái lên cao. Hình tim to. Quai động mạch chủ vồng

Digital signed by: VŨ THỊ DUNG
Date: 01:27 17/10/2026
Printed by: VŨ THỊ DUNG
Date: 01:27 17/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 17 *tháng* 10 *năm* 2026 01:27:57
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Đoàn Thị Nga
Vũ Thị Dung

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25550295

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** NS: **1956** Giới tính: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Khoa chỉ định: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực BS Chỉ định: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán lâm sàng:
Chẩn đoán bệnh: R10.0 - Đau bụng cấp tính
Dịch vụ: XQ ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]

KẾT QUẢ

KỸ THUẬT: Chụp Xquang ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]
MÔ TẢ:

- Lồng ngực cân đối, không thấy bất thường xương và phần mềm thành ngực.
- Góc sườn hoành hai bên sáng, không thấy tràn dịch, tràn khí màng phổi hai bên.
- Mờ lan tỏa trường phổi hai bên, ưu thế đáy phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản phổi hai bên.
- Rốn phổi hai bên không thấy bất thường.
- Hình tim không to. Các bờ trung thất bình thường.

KẾT LUẬN:
Mờ lan tỏa trường phổi hai bên, ưu thế đáy phổi. Giãn kèm dày thành các nhánh phế quản phổi hai bên.

Digital signed by: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Date: 09:01 16/10/2026
Printed by: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Date: 09:01 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 09:01:34
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Thị Hồng Nhung

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25592640

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

PHIẾU KHÁM SIÊU ÂM

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Năm sinh: 1956
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Chẩn đoán: Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi
Bác sĩ chỉ định: Đỗ Đức Minh
Khoa yêu cầu: Khoa Ngoại tổng hợp
Dịch vụ: Siêu âm ổ bụng

KẾT QUẢ

Gan: Kích thước bình thường, nhu mô đều, không có khối bất thường.
Đường mật trong gan: không giãn, không có cản âm bất thường.
Ống mật chủ: Không giãn, không có cản âm bất thường.
Tĩnh mạch cửa: Không giãn, không có huyết khối.
Túi mật: Đã cắt, còn thâm nhiễm mỡ quanh giường túi mật và hạ sườn phải.
Tuỵ: Không to, nhu mô đều, ống tụy không giãn, quanh tụy không thấy bất thường.
Lách: Kích thước bình thường, nhu mô đều.
Thận phải:Hình dạng, kích thước bình thường, nhu mô đều và dày bình thường. Đài bể thận không giãn, không có sỏi. Niệu quản không giãn
Thận trái: Hình dạng, kích thước bình thường, nhu mô đều và dày bình thường. Đài bể thận không giãn, không có sỏi. Niệu quản không giãn.
Bàng quang: ít nước tiểu, hạn chế đánh giá tiểu khung, sơ bộ trong có hình đầu sonde
Tiền liệt tuyến: kích thước 50x51x54mm tương đương 73gr
Douglas và các khoang bụng không có dịch.
Màng phổi hai bên không có dịch.

Kết Luận: Hình ảnh còn thâm nhiễm mỡ quanh giường túi mật và hạ sườn phải. Tiền liệt tuyến tăng kích thước.

Digital signed by: NGUYỄN THÁI HOÀNG
Date: 09:38 20/10/2026
Printed by: NGUYỄN THÁI HOÀNG
Date: 09:38 20/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 20 *tháng* 10 *năm* 2026 09:38:38
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Thái Hoàng

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM TIM MẠCH

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Số 1 Tôn Thất Tùng – Hà Nội
SĐT: 0985670375

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Năm sinh: 1956
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Chẩn đoán: Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật BS chỉ định: Nguyễn Thị Liễu
Dịch vụ: Siêu âm tim cấp cứu tại giường Khoa yêu cầu: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Điều dưỡng đánh máy:

Nhĩ trái 28±3 mm	ĐMC 31± 4 mm	Thất trái						Thất phải 16±4 mm	VLT		TSTT	
		Dd 46±4 mm	Ds 30±3 mm	EDV 101±17 ml	ESV 37±9 ml	FS 34±6 %	EF 63±7 %		D 7,5±1 mm	S 10±2 mm	D 7±1 mm	S 12±1 mm
30	30	51	39	128	69	22	45	17	5	10	7	12

1. Van hai lá
Kiểu di động: ngược chiều
Khoảng cách hai bờ van: mm
Lá van: thanh mảnh
Dây chằng: thanh mảnh
Mép van: thanh mảnh

Huyết khối nhĩ trái/tiểu nhĩ: không thấy
Doppler qua van hai lá
Chênh áp tối đa mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van **nhẹ** (/4);
Diện tích HoHL cm² (TD); cm² (4B);
Diện tích lỗ van cm² (2D) cm² (PHT)

2. Van động mạch chủ
Lá van: thanh mảnh
Biên độ mở van: mm
ĐK ĐMC lên mm, quai ĐMC mm
ĐMC xuống mm; chênh áp qua eo mmHg

Doppler qua van động mạch chủ
Chênh áp tối đa 3 mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van**không**(/4); Diện tích lỗ van cm² (VTI)
Gốc hở mm/ ĐRTT mm; PHT ms

3. Van động mạch phổi và ĐMP
Lá van: thanh mảnh
ĐK gốc ĐMP mm.Thân ĐMP mm
Nhánh phải mm. Nhánh trái mm
Ước tính ALĐMP tâm thu 30 mmHg

Doppler qua van động mạch phổi
Chênh áp tối đa 3 mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van**nhẹ**(/4)
ALĐMP trung bình mmHg, cuối t trương mmHg

4. Van ba lá
Lá van: thanh mảnh

Doppler qua van ba lá
Hở van**nhẹ**(/4); S HoBL cm²
Chênh áp tâm thu dòng hở 25 mmHg; Vmax: m/s

Khoang màng ngoài tim: không có dịch
Nhận xét khác: Chiều cao: cm; Cân nặng: kg
- Giảm vận động nhiều vùng cơ tim thất trái: chủ yếu 2/3 vách liên thất, thành trước vách về phía mỏm, vùng mỏm, và 1/3 thành dưới thất trái về phía đáy
- EF Simpson 4B: Vd 151 ml, Vs 81 ml , EF 46%
EF Simpson 2B: Vd 101 ml, Vs 63 ml , EF 43%, EF (BP) 44%
- TM chủ dưới 5mm, xẹp thì hít vào

KẾT LUẬN:

Digital signed by: VƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
Date: 13:19 19/10/2026
Printed by: VƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
Date: 13:19 19/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

Hà Nội, Ngày 19 *tháng* 10 *năm* 2026 13:19:23
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Vương Thị Ánh Tuyết

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM TIM MẠCH

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Số 1 Tôn Thất Tùng – Hà Nội
SĐT: 0985670375

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

- Bệnh tim thiếu máu cục bộ.
- Buồng thất trái giãn nhẹ, chức năng tâm thu thất trái giảm (EF 44%)
- Van hai lá hở nhẹ

Digital signed by: VƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
Date: 13:19 19/10/2026
Printed by: VƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
Date: 13:19 19/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 19 *tháng* 10 *năm* 2026 13:19:23
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Vương Thị Ánh Tuyết

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM TIM MẠCH

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Số 1 Tôn Thất Tùng – Hà Nội
SĐT: 0985670375

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Năm sinh: 1956
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp do sỏi BS chỉ định: Nguyễn Văn Sự
Dịch vụ: Siêu âm tim cấp cứu tại giường Khoa yêu cầu: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Điều dưỡng đánh máy:

Nhĩ trái 28±3 mm	ĐMC 31± 4 mm	Thất trái						Thất phải 16±4 mm	VLT		TSTT	
		Dd 46±4 mm	Ds 30±3 mm	EDV 101±17 ml	ESV 37±9 ml	FS 34±6 %	EF 63±7 %		D 7,5±1 mm	S 10±2 mm	D 7±1 mm	S 12±1 mm
34	32	55	41	152	76	25	49	23	10	11	11	13

1. Van hai lá
Kiểu di động: ngược chiều
Khoảng cách hai bờ van: mm
Lá van: thanh mảnh
Dây chằng: thanh mảnh
Mép van: thanh mảnh

2. Van động mạch chủ
Lá van: thanh mảnh
Biên độ mở van: mm
ĐK ĐMC lên mm, quai ĐMC mm
ĐMC xuống mm; chênh áp qua eo mmHg

3. Van động mạch phổi và ĐMP
Lá van: thanh mảnh
ĐK gốc ĐMP mm.Thân ĐMP mm
Nhánh phải mm. Nhánh trái mm
Ước tính ALĐMP tâm thu 30 mmHg

4. Van ba lá
Lá van: thanh mảnh

Huyết khối nhĩ trái/tiểu nhĩ: không thấy
Doppler qua van hai lá
Chênh áp tối đa 4 mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van **nhẹ** (/4);
Diện tích HoHL cm² (TD); cm² (4B);
Diện tích lỗ van cm² (2D) cm² (PHT)

Doppler qua van động mạch chủ
Chênh áp tối đa 6 mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van **nhẹ** (/4); Diện tích lỗ van cm² (VTI)
Gốc hở mm/ ĐRTT mm; PHT ms

Doppler qua van động mạch phổi
Chênh áp tối đa 3 mmHg
Chênh áp trung bình mmHg
Hở van **nhẹ**(/4)
ALĐMP trung bình mmHg, cuối t trương mmHg

Doppler qua van ba lá
Hở van **nhẹ**(/4); S HoBL cm²
Chênh áp tâm thu dòng hở 25 mmHg; Vmax: m/s

Khoang màng ngoài tim: không có dịch
Nhận xét khác:
- Giảm vận động đồng đều các thành thất trái. Vách liên thất di động dạng block nhánh.
- PP Simpson (4B): Vd: 141 ml, Vs: 90 ml, EF: 35%
- PP Simpson (2B): Vd: 153 ml, Vs: 97 ml, EF: 36 % EF (BP: 36%.

KẾT LUẬN:
Siêu âm tim tại giường đánh giá:
- Buồng thất trái giãn, chức năng tâm thu thất trái giảm EF (BP): 36%.

Digital signed by: NGUYỄN THỊ MINH LÝ
Date: 11:10 17/10/2026
Printed by: NGUYỄN THỊ MINH LÝ
Date: 11:10 17/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

Hà Nội, Ngày 17 *tháng* 10 *năm* 2026 11:10:16
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Minh Lý

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25550304

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

NGUYỄN HẰNG HƯNG

PHIẾU KHÁM SIÊU ÂM

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Năm sinh: 1956
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Chẩn đoán:
Bác sĩ chỉ định: Nguyễn Thành Trung
Khoa yêu cầu: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Dịch vụ: Siêu âm ổ bụng

KẾT QUẢ

Gan: Kích thước bình thường, nhu mô đều, không có khối bất thường.
Đường mật trong gan: không giãn, không có cản âm bất thường.
Ống mật chủ: Không giãn, không có cản âm bất thường.
Tĩnh mạch cửa: Không giãn, không có huyết khối.
Túi mật: căng nhẹ, kích thước 94x38mm, thành dày quanh chu vi 5mm, lắng đọng cholesterol thành túi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi lớn nhất đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhất đường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quanh.
Tuỵ: Không to, nhu mô đều, ống tụy không giãn, quanh tụy không thấy bất thường.
Lách: Kích thước bình thường, nhu mô đều.
Thận phải:Hình dạng, kích thước bình thường, nhu mô đều và dày bình thường. Đài bể thận không giãn, không có sỏi. Niệu quản không giãn
Thận trái: Hình dạng, kích thước bình thường, nhu mô đều và dày bình thường. Đài bể thận không giãn, không có sỏi. Niệu quản không giãn.
Bàng quang: ít nước tiểu hạn chế đánh giá tiểu khung
Douglas và các khoang bụng không có dịch.
Màng phổi hai bên không có dịch.
Thành bụng dày, chướng nhiều hơi hạn chế đánh giá ruột thừa.
Kết Luận: Hình ảnh bùn, sỏi túi mật và ống cổ túi mật/ túi mật căng nhẹ, dày thành kèm thâm nhiễm mỡ nhẹ quanh túi mật. Lắng đọng cholesterol thành túi mật.

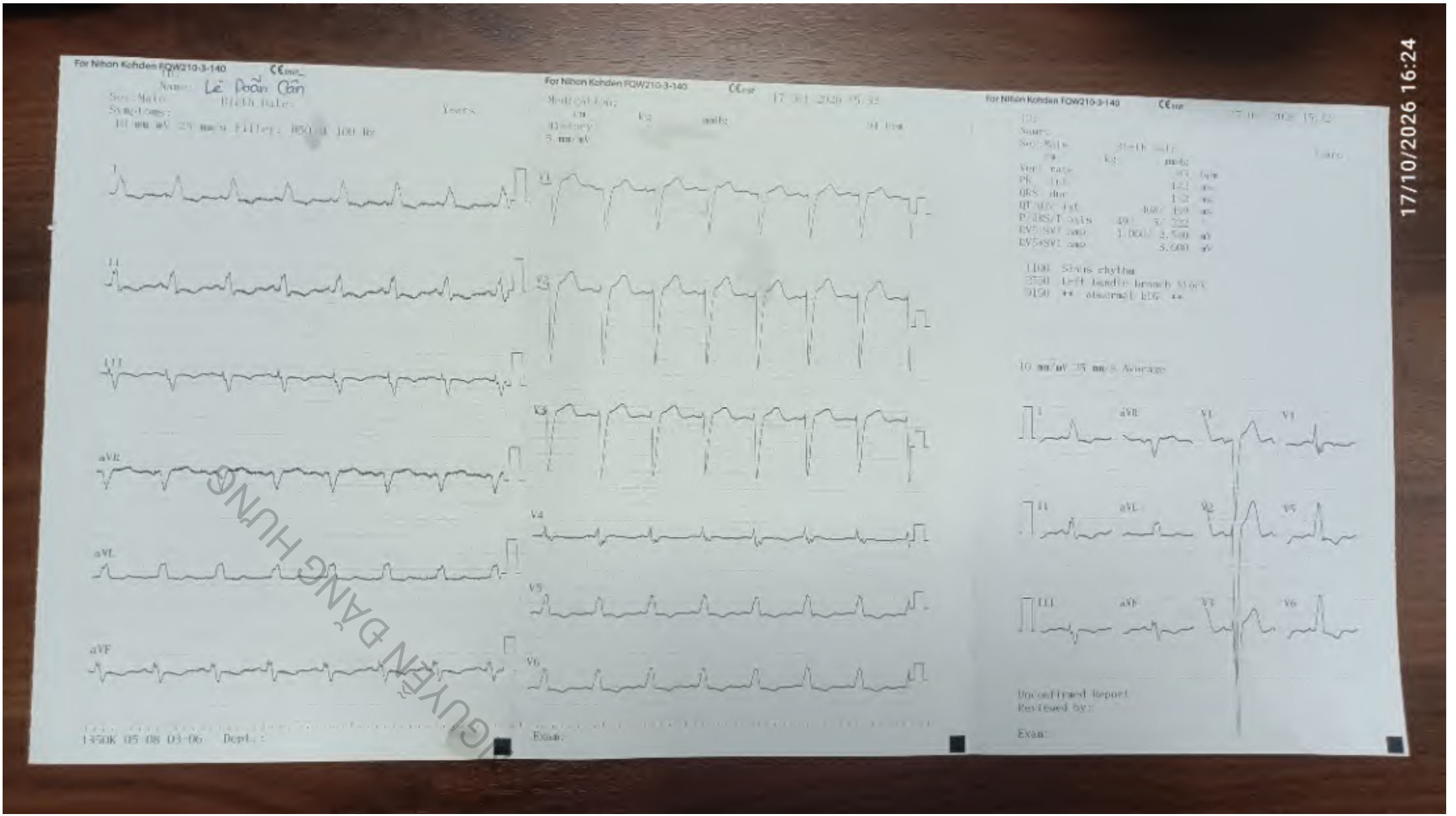
Digital signed by: VŨ THỊ DUNG
Date: 08:51 16/10/2026
Printed by: VŨ THỊ DUNG
Date: 08:51 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 08:51:42
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Vũ Thị Dung



17/10/2026 16:24

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

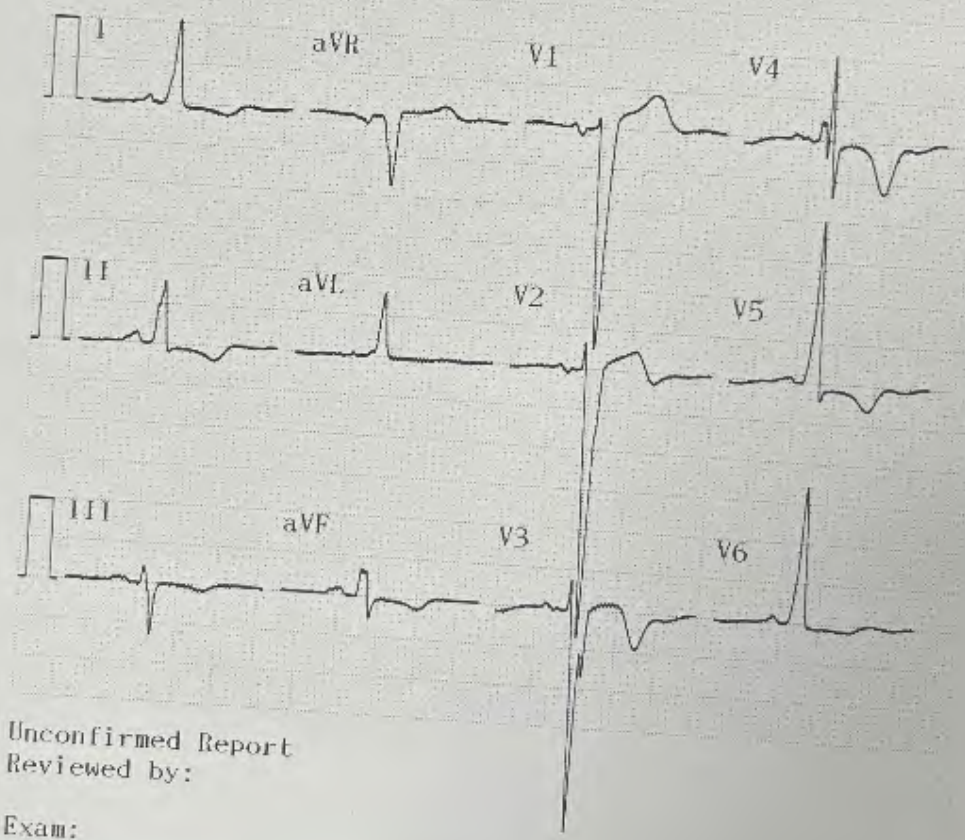
For Nihon Kohden FQW210-3-140 CE 0197

ID: 19-Oct-2026 8:49
Name:
Sex:Male Birth Date: Years
cm kg mmHg
Vent rate 73 bpm
PR int 134 ms
QRS dur 114 ms
QT/QTc int 428/ 453 ms
P/QRS/T axis 43/ 14/ 230 -
RV5/SV1 amp 2.025/ 2.735 mV
RV5+SV1 amp 4.760 mV

1100 Sinus rhythm
2217 Type-B Wolff-Parkinson-White syndrome
0102 ARTIFACT PRESENT
9150 ** abnormal ECG **

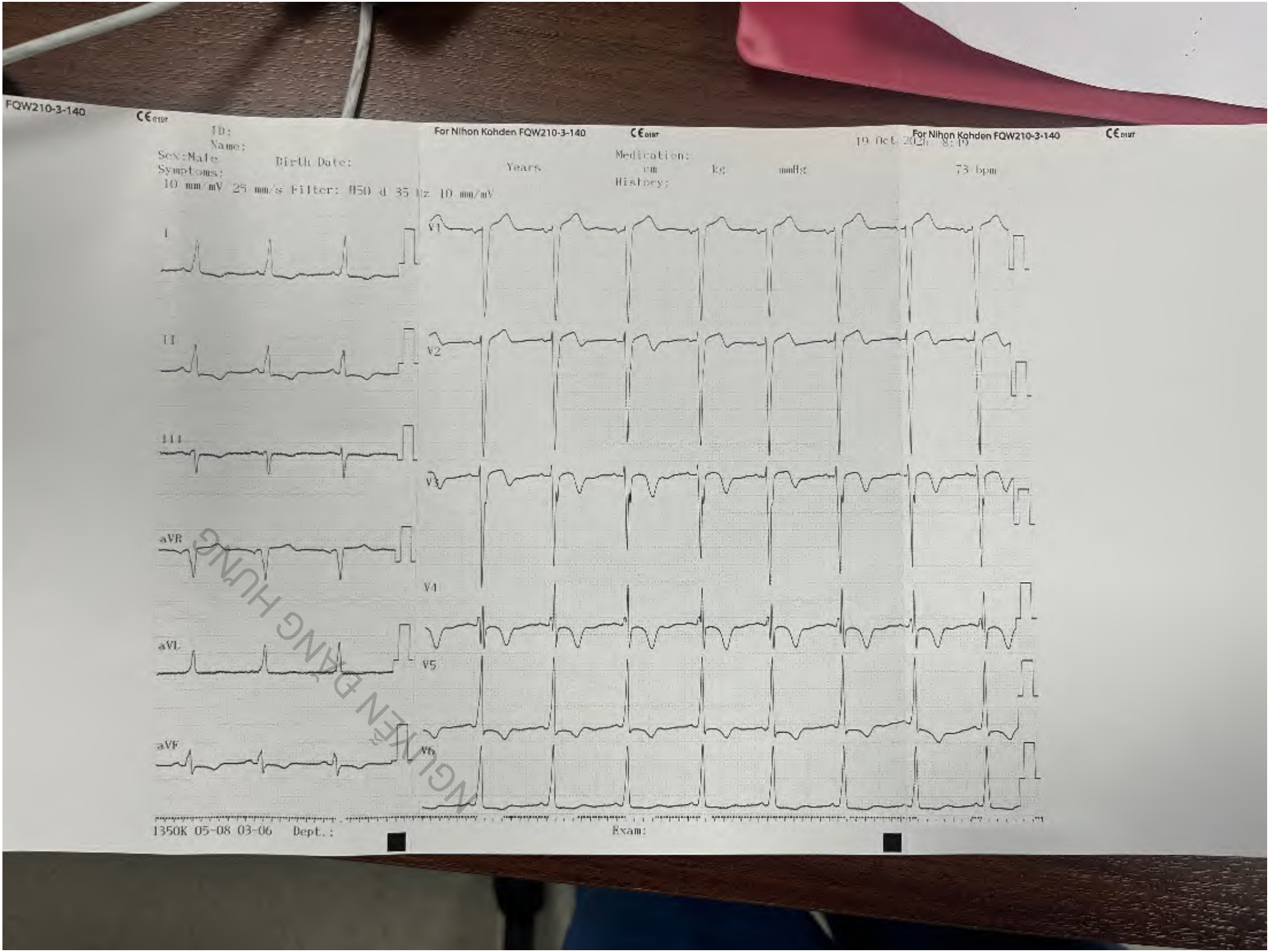
NGUYỄN BẰNG HƯNG

10 mm/mV 25 mm/s Average



Unconfirmed Report
Reviewed by:

Exam:


FQW210-3-140
For Nihon Kohden FQW210-3-140
For Nihon Kohden FQW210-3-140
ID:
Name:
Sex:Male
Birth Date:
Symptoms:
Years
Medication:
cm
kg
mmHg
History:
73 bpm
10 mm/mV 25 mm/s Filter: H50 d 35 Hz 10 mm/mV
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
1350K 05-08 03-06
Dept.:
Exam:

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC TÍCH CỰC
ĐT: 02466 708 389

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã Hồ sơ: 2610163961
Mã Kết nối: 25550289

ĐIỆN TIM THƯỜNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Năm sinh: 1956
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Chẩn đoán:
Bác sĩ chỉ định: Nguyễn Thành Trung
Khoa yêu cầu: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực
Dịch vụ: Điện tim thường

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

KẾT LUẬN

Nhịp xoang, đều, tần số 96 chu kỳ/phút
Hình ảnh block nhánh
T âm tại v4-6
Trục trung gian ./.

Digital signed by: ĐỖ GIANG PHÚC
Date: 16:07 16/10/2026
Printed by: ĐỖ GIANG PHÚC
Date: 16:07 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 16:07:32
Bác sĩ chuyên khoa

Đỗ Giang Phúc

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25555691

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** NS: **1956** Giới tính: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Khoa chỉ định: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực BS Chỉ định: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán lâm sàng:
Chẩn đoán bệnh: R10.0 - Đau bụng cấp tính
Dịch vụ: CT tầng trên ổ bụng 16 dãy [có tiêm]
Máy thực hiện: CT 128 dãy - A2
Thuốc cản quang: Ultravist 370 768.86 mg/ml, 100ml, SL: 0.7, Chai - Tiêm tĩnh mạch

KẾT QUẢ

KỸ THUẬT: Chụp CLVT ổ bụng độ dày lớp cắt 3mm trước và sau tiêm thuốc cản quang.
MÔ TẢ:

- Gan không to, bờ đều, rối loạn tưới máu nhu mô gan quanh giường túi mật thì động mạch, nhu mô gan hạ phân thùy V có đám ngấm thuốc kém không đặc hiệu kích thước 24x8mm, gợi hình ống. Phù nhẹ khoảng cửa.
- Tĩnh mạch cửa không giãn, không thấy huyết khối.
- Đường mật trong gan không giãn, không thấy sỏi tăng tỷ trọng
- Ống mật chủ không giãn, không thấy sỏi tăng tỷ trọng
- Túi mật căng, đường kính ngang 43mm, thành dày quanh chu vi 5mm, kết hợp với siêu âm trong lòng túi mật có bùn mật và vài sỏi, viên lớn đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhất đường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ xung quanh, ít dịch dọc rãnh đại tràng lên dày nhất 5mm.
- Tụy: Kích thước bình thường, nhu mô đuôi tụy có nốt vôi đường kính 4mm, ống tụy không giãn.
- Lách không to, nhu mô đều.
- Thận phải: hình thái, kích thước bình thường. Nhu mô dày và ngấm thuốc bình thường. Đài bể thận không giãn, không thấy sỏi. Niệu quản không giãn.
- Thận trái: hình thái, kích thước bình thường. Nhu mô dày và ngấm thuốc bình thường. Đài bể thận không giãn, không thấy sỏi. Niệu quản không giãn.
- Bàng quang ít nước tiểu.
- Tiền liệt tuyến kích thước tương đương 62gr.
- Vài hạch cạnh tâm vị và dọc bó mạch chủ bụng, đường kính trục ngắn <10mm.
- Hố chậu phải: ruột thừa đường kính ngang 6mm, thành mỏng, lòng chứa khí, không thâm nhiễm xung quanh
- Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy, dày 6mm, ngấm huốc mạnh lớp niêm mạc.
- Dày thành đại tràng lên, đại tràng ngang đoạn góc gan, dày quanh chu vi 12mm, ngấm thuốc mạnh lớp niêm mạc, thâm nhiễm xung quanh.

Digital signed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 13:01 16/10/2026
Printed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 13:01 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 13:01:03
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Trúc Linh

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

- Túi thừa manh tràng đường kính 16mm, lòng chứa khí, không thâm nhiễm xung quanh.
- Ít dịch vùng tiểu khung dày 9mm.
- Thoát vị bẹn phải kích thước 22x15mm, đường kính cổ 19mm, nội dung là mỡ mạc nối, không thấy thâm nhiễm xung quanh.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

KẾT LUẬN:
Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại tràng ngang đoạn góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọc rãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung. Đám ngấm thuốc kém không đặc hiệu gan phải. Nốt vôi hóa nhỏ đuôi tụy. Túi thừa manh tràng, hiện không viêm. Vài hạch cạnh tâm vị và dọc bó mạch chủ bụng. Phù nhẹ khoảng cửa. Tiền liệt tuyến tăng kích thước. Thoát vị bẹn phải.

Digital signed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 13:01 16/10/2026
Printed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 13:01 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 13:01:03
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Trúc Linh

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
Nơi tri thức hội tụ cùng y đức

Mã Hồ sơ: 2610163961

Mã Người bệnh: 2610036327
Mã ghép nối: 25555693

Số tổng đài: 19006422
Website: http://www.benhviendaihocyhanoi.com

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG

KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** NS: **1956** Giới tính: **Nam**
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0986410715
Khoa chỉ định: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực BS Chỉ định: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán lâm sàng:
Chẩn đoán bệnh: R10.0 - Đau bụng cấp tính
Dịch vụ: CT lồng ngực 16 dãy [không tiêm]

KẾT QUẢ

KỸ THUẬT: Chụp CLVT (từ 1- 32 dãy) lồng ngực, độ dày lớp cắt 1.25mm không tiêm thuốc cản quang.

MÔ TẢ:

- Phổi hai bên: giãn không đều, dày thành phế quản phổi hai bên, chủ yếu phân thùy 5 và thùy dưới hai phổi, ứ dịch trong lòng các nhánh phế quản. Vài đám đông đặc - xẹp phổi rải rác hai phổi, lớn nhất kích thước 54x44mm, trong có phế quản chứa khí. Vài nốt đặc, kính mờ rải rác hai phổi, lớn nhất đường kính 8mm. Nốt vôi hóa thùy trên phổi trái đường kính 4mm. Vài dải xơ - xẹp rải rác hai phổi, co kéo nhẹ nhu mô lân cận. Giảm nhẹ thể tích phổi trái.
- Vị trí cạnh khí quản, carina và cửa sổ chủ phổi có vài hạch, lớn nhất kích thước 16x12mm, bờ đều.
- Dịch khoang màng phổi trái dày nhất 6mm, dày kèm vôi hóa màng phổi trái.
- Xương và phần mềm thành ngực không thấy bất thường.
- Động mạch vành: vôi hoá rải rác LAD
- Động mạch chủ ngực: không thấy hình ảnh phình, có vôi hóa rải rác.

KẾT LUẬN:

Hình ảnh theo dõi giãn phế quản bội nhiễm phổi hai bên. Vài đám đông đặc - xẹp phổi, vài nốt đặc, kính mờ rải rác hai phổi (theo dõi viêm). Nốt vôi hóa thùy trên phổi trái. Vài dải xơ - xẹp rải rác hai phổi, co kéo nhẹ nhu mô lân cận. Giảm nhẹ thể tích phổi trái. Dịch khoang màng phổi trái. Dày kèm vôi hóa màng phổi trái. Vôi hóa rải rác LAD và động mạch chủ ngực. Vài hạch trung thất.

Digital signed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 12:35 16/10/2026
Printed by: NGUYỄN TRÚC LINH
Date: 12:35 16/10/2026
Vui lòng truy cập địa chỉ **http://pacs.hmuh.vn/** hoặc quét **mã QR** để xem hình ảnh và kết quả
(xem trên trình duyệt chrome)

Tài khoản: 2610036327
Mật khẩu: 5n8xv$7B
Vui lòng thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu thành công!

*Trong trường hợp người bệnh không truy cập được, xin vui lòng gọi điện đến số: **19006422** để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!*

Hà Nội, Ngày 16 *tháng* 10 *năm* 2026 12:35:25
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Nguyễn Trúc Linh

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 1

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Phòng: Khoa Cấp cứu Số giường: K011
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
08 giờ 19 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân nam 70 tuổi, tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, khoảng 19h ngày 15/10/2026, bệnh nhân xuất hiện đau bụng mạn sườn trái lan lên ngực sau xương ức. Ngày nay đau tăng --> CC ĐHY Khám: Bệnh nhân tỉnh, mệt GCS 15 điểm Da, niêm mạc hồng Không phù, không xuất huyết dưới da Hiện không sốt Tự thở khí phòng SpO2 95% RRPN giảm vùng đáy phổi 2 bên Tim đều M: 98 ck/phút HA: 152/86mmHg Bụng mềm, chướng hơi nhẹ Điểm đau McBurney (+) PUTB(+), CUPM (-) Cơ tròn tự chủ - **DVKT:** + **Hóa sinh**: Định lượng CRP hs (CReactive Protein high sesitivity) [Máu] (M:104 BC :16,56) + **Đông máu**: Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), Định lượng Fibrinogen, Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) + **Hóa sinh**: Creatinin, GOT, GPT, Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu], Đo hoạt độ Lipase [Máu], Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu], Urê, Bil D + **Huyết học**: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) + **Khí máu**: Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) [POCT] + **Miễn dịch**: Định lượng Troponin T [Máu] + **Truyền máu**: Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) + **Điện tim - CAVI**: Điện tim thường + **Siêu âm**: Siêu âm ổ bụng + **X - quang**: XQ ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]	Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% - 500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch chậm duy trì vein* - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN BS Nguyễn Thành Trung
09 giờ 18 phút Thứ 6,	Bệnh nhân tỉnh, mệt Hiện không sốt	Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 1 Chai

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
16/10/2026	Tự thở khí phòng SpO2 93% RRPN giảm, rales nổ rải rác vùng đáy phổi 2 bên Tim đều M: 99 ck/phút HA: 142/70mmHg Bụng chướng, điểm đau McBurney (+) PUTB (+) SA: Hình ảnh bùn, sỏi túi mật và ống cổ túi mật/ túi mật căng nhẹ, dày thành kèm thâm nhiễm mỡ nhẹ quanh túi mật. Lắng đọng cholesterol thành túi mật. - **DVKT:** + **Khí máu**: Xét nghiệm Khí máu [Máu] + **Kháng sinh**: Kháng sinh ưu tiên quản lý - **Dịch vụ khám**: + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B	*Pha kháng sinh* Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 3 Chai *Pha kháng sinh* (1) Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x 2 Lọ *Pha 2 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 9h45* (1) Meropenem (**Meronem***) 1g x 3 Lọ *Pha 1 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 18h - 02h - 10h* - Chuyển thở oxy 3L/phút - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN BS Nguyễn Thành Trung
10 giờ 45 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân có chỉ định chụp CLVT ổ bụng theo ý kiến hội chẩn chuyên khoa - **DVKT:** + **CLVT**: CT lồng ngực 16 dãy [không tiêm], CT tầng trên ổ bụng 16 dãy [có tiêm]	- Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN BS Nguyễn Thành Trung
13 giờ 21 phút Thứ 6, 16/10/2026	CT bụng Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại trángngang đoạn góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọcrãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung. Đám ngấm thuốc kém không đặc hiệu gan phải. Nốt vôi hóa nhỏđuôi tụy. Túi thừa manh tràng, hiện không viêm. Vài hạch cạnh tâm vị và dọc bó mạch chủ bụng. Phù nhẹkhoảng cửa. Tiền liệt tuyến tăng kích thước. Thoát vị bẹn phải - **Dịch vụ khám**: + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng 301_ hội chẩn khoa Ngoại B	- HC ngoại B - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN **BS. Nguyễn Tiến Thành**
15 giờ 58 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân tỉnh, mệt Hiện không sốt Tự thở khí phòng SpO2 95% RRPN giảm, rales nổ rải rác vùng đáy phổi 2 bên Tim đều M: 92 ck/phút HA: 138/73mmHg Bụng chướng, điểm đau McBurney (+) PUTB (+)	Glucose (**Glucose 10% [IVC]**) 10% - 500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch 50ml/h* - Dặn bệnh nhân nhịn ăn - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
	Bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu	BS Nguyễn Thành Trung
20 giờ 45 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân tỉnh, mệt Hiện không sốt Tự thở khí phòng SpO2 95% RRPN giảm, rales nổ rải rác vùng đáy phổi 2 bên Tim đều M: 80 ck/phút HA: 135/70 mmHg Bụng chướng, điểm đau McBurney (+) PUTB (+)	- Chuyển mổ cấp cứu - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN ThS.BS Nguyễn Tất Thành
21 giờ 03 phút Thứ 6, 16/10/2026	Trả thuốc	Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x -2 Chai ① Meropenem (**Meronem***) 1g x -2 Lọ Ký số bởi: **Nguyễn Thành Trung** Ngày ký: **06:17:33 17/10/2026** BS Nguyễn Thành Trung

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 1

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 Số giường: H004
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
08 giờ 19 phút Thứ 6, 16/10/2026	BN vào mổ - **DVKT:** + **Phẫu thuật nội soi**: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật	- Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: NHINAN BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng
21 giờ 42 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân vào phòng mổ, huyết động ổn định, SpO2 95% không oxy, phổi rale ẩm hai đáy phổi. - **DVKT:** + **Dịch vụ độc lập**: Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)	- KS đã dùng meronem ở khoa CC - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN Ký số bởi: TRẦN VIỆT ĐỨC Ngày ký: 03:20:22 17/10/2026 ThS. BS. Trần Việt Đức
22 giờ 37 phút Thứ 6, 16/10/2026	Bệnh nhân sau mổ cắt túi mật - viêm phổi - BN chưa tỉnh, da niêm mạc hồng - Tim đều tần số 85 l/p, HA 120/80 mmHg - Phổi rale ẩm hai đáy phổi SpO2 100% FiO2 40% - Bụng mềm, không chướng - Nhiệt độ: 37.8 độ C - Tiểu vàng đang ra - **DVKT:** + **Khí máu**: Xét nghiệm Khí máu [Máu] + **X - quang**: Chụp Xquang tại giường	clorid; calci clorid dihydrat; Natri lactat khan (**Lactated Ringer's**) 3g; 0,15g; 0,1g; 1,55g/500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch 50ml/h* Magnesi sulfat (**MAGNESI SULFAT KABI 15%**) 15%/10ml x 1 Ống *Pha dịch truyền ringer* Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 1 Chai *Pha thuốc* (1) Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 1g x 1 Lọ *SE 1g/3h lúc 2h sáng* Paracetamol (**A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)**) 1g/6,67ml x 1 Ống *Truyền tĩnh mạch lúc 5h sáng mai* Pantoprazol (**Ulceron [ĐB]**) 40mg x 1 Lọ *Tiêm tĩnh mạch chậm* Propofol (**Diprivan Inj**) 1%-20ml x 7 Ống *SE 20ml/h* - - An thần thở máy - Theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, vết mổ, dẫn lưu - Thử lại KMĐM, chụp XQ tại giường - Thử ĐMMM 8h/lần + insullin theo phác đồ - Xét nghiệm mai: Công thức máu, đường máu, điện giải đồ, khí máu. troponin T - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
		ThS. BS. Trần Việt Đức

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 2

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 Số giường: H004
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
01 giờ 00 phút Thứ 7, 17/10/2026	XN mai - **DVKT:** + **Hóa sinh**: Định lượng Glucose, Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] + **Huyết học**: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) + **Khí máu**: Xét nghiệm Khí máu [Máu] + **Miễn dịch**: Định lượng Troponin T [Máu]	- Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN ThS. BS. Trần Việt Đức
07 giờ 54 phút Thứ 7, 17/10/2026	Bệnh nhân nam 70 tuổi Tiền sử: Đau đây V Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp- Viêm phổi Phẫu thuật: Nội soi cắt túi mật Hiện tại ngày thứ 1 sau mổ Bn tỉnh, tự thở Phổi rale ẩm hai đáy, SpO2 100% (FiO2 30%) Tim hình ảnh block nhánh, T âm, M 75 HA 115/70 mmHg (nor liều nhỏ) Bụng mềm, dẫn lưu ổ bụng 15ml Tiểu 150ml/3h Ngày qua không sốt Hb 129 HCT 40% BC 17.25 TC 274 Na/K 138/4.1 Glucose 8.6 Troponin T 11.3 Khí máu: pH 7.32 CO2 48 HCO3 24 Lac 1.4 p/F 260 - **DVKT:** + **Dịch vụ độc lập**: Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) (15h 17/10) + **Dịch vụ độc lập**: Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) (x 3 lần) + **Siêu âm**: Siêu âm tim cấp cứu tại giường - **Dịch vụ khám**: + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng 5067 + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng khám PHCN 217(A5)	Glucose monohydrat 55g/250ml (**Glucose 20% [Kabi]**) 20% x 500ml x 1 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch* Magnesi sulfat (**MAGNESI SULFAT KABI 15%**) 15%/10ml x 1 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 1 Chai *pha paracetamol* (2) Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x 6 Lọ *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h* Kali clorid (**Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]**) 10% 10ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Calci clorid (**Calci clorid**) 500mg/5ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Paracetamol (**A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)**) 1g/6,67ml x 1 Ống *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4* Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x 1 Ống *tiêm tĩnh mạch chậm 1/2 ống nếu tiểu 100ml/3h* Pantoprazol (**Pantoloc IV [ĐB]**) 40mg x 1 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm* Enoxaparin Natri (**LOVENOX 40mg**) 40mg/ 0,4ml x 1 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm* Ringer lactat (**Lactated Ringer's Injections**) 500ml x 2 Chai *truyền tĩnh mạch*

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
	NGUYỄN ĐĂNG HƯNG	- 1. Theo dõi mạch, HA, SPO2, nước tiểu, nhiệt độ, dẫn lưu 2. Tư thế đầu cao 30 độ, thẳng trục 3. Tập PHCN, lý liệu pháp hô hấp tích cực Thở NIV xen kẽ, tập ho khạc 4. Cấy đờm khạc 5. Chế độ ăn: Tạm nhịn ăn 6. XN mai: CTM, đường, điện giải đồ, khí máu Siêu âm tim Hội chẩn CK Tim mạch về rối loạn nhịp tim của BN Hội chẩn CK hô hấp về điều trị tình trạng viêm phổi - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN Ths. BSNT Nguyễn Văn Sự
15 giờ 47 phút Thứ 7, 17/10/2026	Xét nghiệm máu theo HC tim mạch - **DVKT:** + **Miễn dịch**: Định lượng proBNP (NTproBNP) [Máu], Định lượng Troponin T [Máu]	- Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN ThS.BS. Lê Văn Tiến
16 giờ 30 phút Thứ 7, 17/10/2026	Trả thuốc	Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x -1 Ống Ký số bởi: **LÊ VĂN TIẾN** Ngày ký: **11:48:55 20/10/2026** ThS.BS. Lê Văn Tiến

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 3

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ) Số giường: H038

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật .

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
01 giờ 16 phút Chủ nhật, 18/10/2026	XN sáng - **DVKT:** + **Khí máu**: Xét nghiệm Khí máu [Máu] (thêm lactat) + **Hóa sinh**: Định lượng Glucose, Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] + **Huyết học**: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)	- Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN Ths.BS. Trần Xuân Bách
08 giờ 19 phút Chủ nhật, 18/10/2026	Bn sau mổ ngày thứ 2 Bn tỉnh, tự thở Phổi rale ẩm hai đáy, SpO2 96% (FiO2 30%) Tim đều,nhịp xoang, M 75 HA 130/80 mmHg Bụng mềm, dẫn lưu ổ bụng 40 ml/ 24h Tiểu 1200ml/24h Ngày qua không sốt Hb 135 HCT 42% BC 13,6 TC 299 Na/K 138/3,7 Glucose 5,3 Khí máu: pH 7.45 CO2 38 HCO3 26 Lac 0,6 p/F 350 Siêu âm tim (17/10): thất trái giãn, EF 36%	Glucose monohydrat 55g/250ml (**Glucose 20% [Kabi]**) 20% x 500ml x 1,0 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch* Magnesi sulfat (**MAGNESI SULFAT KABI 15%**) 15%/10ml x 1,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 1,0 Chai *pha paracetamol* ③ Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x 6,0 Lọ *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h* Kali clorid (**Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]**) 10% 10ml x 2,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Calci clorid (**Calci clorid**) 500mg/5ml x 2,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Paracetamol (**A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)**) 1g/6,67ml x 1,0 Ống *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4* Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x 2 Ống *tiêm tĩnh mạch chia 4* Pantoprazol (**Pantoloc IV [ĐB]**) 40mg x 1,0 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm* Enoxaparin Natri (**LOVENOX 40mg**) 40mg/ 0,4ml x 1,0 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm* Ringer lactat (**Lactated Ringer's Injections**) 500ml x 1 Chai *truyền tĩnh mạch*

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
		- 1. Theo dõi mạch, HA, SPO2, nước tiểu, nhiệt độ, dẫn lưu 2. Tư thế đầu cao 30 độ, thẳng trục 3. Tập PHCN, lý liệu pháp hô hấp tích cực Thở NIV xen kẽ, tập ho khạc 5. Chế độ ăn: Tạm nhịn ăn 6. XN mai: CTM, đường, điện giải đồ, khí máu, troponin T, ProBNP, cre, CRP Hội chẩn lại CK Tim mạch - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN Ths.BS. Trần Xuân Bách
08 giờ 35 phút Chủ nhật, 18/10/2026	BN ho lọc xọc đờm ECG: ST chênh xuống - **DVKT:** + **Miễn dịch**: Định lượng Troponin T [Máu]	Acetylcystein (**Acetylcystein**) 200mg x 3 Gói *Uống chia 3 cách 8h* - Ăn uống theo nhu cầu - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN Ký số bởi: **NGUYỄN THANH HIỀN** Ngày ký: **08:44:53 18/10/2026** ThS.BSNT. Nguyễn Thanh Hiền

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 4

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ) Số giường: H038

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật .
Chẩn đoán kèm theo: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
01 giờ 00 phút Thứ 2, 19/10/2026	Xn sáng - **DVKT:** + **Khí máu**: Xét nghiệm Khí máu [Máu] (+lactate) + **Miễn dịch**: Định lượng proBNP (NTproBNP) [Máu] (suy tim EF 36%, proBNP gần nhất 1004) + **Miễn dịch**: Định lượng Troponin T [Máu] (Suy tim EF 36%, ST chênh xuống) + **Hóa sinh**: Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu], Creatinin, Định lượng Glucose, Định lượng CRP hs (CReactive Protein high sesitivity) [Máu] + **Huyết học**: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)	- Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN ThS.BSNT. Nguyễn Thanh Hiền
08 giờ 09 phút Thứ 2, 19/10/2026	hiện tại Nt3 sau mổ: Bn tỉnh, hợp tác, không đau ngực Tự thở, tần số 18 l/ph, Phổi rale ẩm hai đáy, giảm thông khí 2 đáy, SpO2 96% (không oxy) NIV xen kẽ, ho khạc đờm xanh Tim đều xoang, M 90 HA 130/80 mmHg, Bụng mềm, dẫn lưu ổ bụng 50 ml/ 24h Tiểu 3700 ml/24h (40mg Lasix) - bilan - 1540ml Ngày qua không sốt Hb 142 HCT 44% BC 9.9 (13,6) TC 318 Na/K 136/3.6 Glu 6.6 CRP 10.8 (9.5) Cre 62 TnT 12.1 (11.4) ProBNP 1783 (1004) KMĐM: pH 7.45 CO2 45.6 pO2 73 HCO3 29.2 Lac 0.5 BE 6.5 p/F 348 (350) Siêu âm tim (17/10): thất trái giãn, EF 36% CVLT 16/10: Hình ảnh theo dõi giãn phế quản bội nhiễm phổi hai bên. Vài đám đông đặc - xẹp phổi, vài nốt đặc, kính mờ rải rác hai phổi (theo dõi viêm) KS: Meropenem NT3 - **DVKT:** + **Dịch vụ độc lập**: Xét nghiệm đường máu	Glucose monohydrat 55g/250ml (**Glucose 20% [Kabi]**) 20% x 500ml x 1,0 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch* Magnesi sulfat (**MAGNESI SULFAT KABI 15%**) 15%/10ml x 1,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x 1,0 Chai *pha paracetamol* Kali clorid (**Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]**) 10% 10ml x 2,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Calci clorid (**Calci clorid**) 500mg/5ml x 2,0 Ống *pha truyền tĩnh mạch* Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x 2,0 Ống *tiêm tĩnh mạch chia 4* Pantoprazol (**Pantoloc IV [ĐB]**) 40mg x 1,0 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm* Enoxaparin Natri (**LOVENOX 40mg**) 40mg/ 0,4ml x 1,0 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
	mao mạch tại giường (một lần) + **Siêu âm**: Siêu âm tim cấp cứu tại giường + **Thủ thuật**: Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo giờ thực tế] + **X - quang**: Chụp Xquang tại giường - **Dịch vụ khám**: + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng phục hồi chức năng	④ Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 1g x 1 Lọ *SE 1 lọ/3h* Acetylcystein (**Acetylcystein**) 200mg x 3,0 Gói *Uống chia 3 cách 8h* Ringer lactat (**Lactated Ringer's Injections**) 500ml x 1,0 Chai *truyền tĩnh mạch* - 1. Theo dõi mạch, HA, SPO2, nước tiểu, nhiệt độ, dẫn lưu 2. Tư thế đầu cao 30 độ, thẳng trục 3. Tập PHCN, lý liệu pháp hô hấp tích cực Thở NIV xen kẽ, tập ho khạc + Anroro Ellipta 62.5/25mcg x 01 hộp, hít qua đường miệng ngày 01 liều, sáng + Ventolin 200 dose x 01 bình, xịt hít qua đường miệng 02 nhát khi khó thở, tối đa 08 nhát xịt/ngày 5. Chế độ ăn: ăn nhẹ theo nhu cầu 6. XN mai: CTM, đường, điện giải đồ, khí máu, troponin T, ProBNP, cre, CRP , AST, ALT, bil TP - Chụp XQ ngực tại giường - Siêu âm tim tại giường - Ghi ECG - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN  ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu
12 giờ 39 phút Thứ 2, 19/10/2026	BN tỉnh Da niêm mạc hồng Tim đều M 80l/p, HA 125/78 mmHg Phổi rõ, sp02 96% (không oxy), thở êm NT 14-16l/p, ho khạc được, ít đờm Bụng mềm, ăn tiêu Không sốt Tiểu 200ml/3h vàng trong SÂ tim (19/10): TD bệnh mạch vành mạn- Giảm vận động đồng đều các thành thất trái, thất (T) gianx, EF 45% XQ ngực có cải thiện => Kính chuyển khoa phòng điều trị tiếp	- Đề nghị về khoa: - Tiếp tục dùng kháng sinh Meronem , chỉnh theo MLCT. Theo dõi bilan nhiễm khuẩn 48h - Hội chẩn lại nộ tim mạch dùng thuốc, chụp mạch vành cho bệnh nhân - Tiếp tục dùng thuốc xịt theo hội chẩn hô hấp, tập PHCN hô hấp - Chăm sóc cấp I Chế độ ăn: NHINAN  ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu
13 giờ 10 phút Thứ 2, 19/10/2026	Trả thuốc	Natri clorid (**Natri clorid [Bitechphar]**) 0,9% x 250ml x -1 Chai Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x -1 Ống Pantoprazol (**Pantoloc IV [ĐB]**) 40mg x -1

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
		Lọ Enoxaparin Natri (**LOVENOX 40mg**) 40mg/ 0,4ml x -1 Bơm tiêm Acetylcystein (**Acetylcystein**) 200mg x -2 Gói

Ký số bởi: **Nguyễn Thị Liễu**
Ngày ký: **14:12:30 20/10/2026**

ThS.BSNT.Nguyễn Thị Liễu

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 4

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Phòng: Phòng 307 Số giường: H018
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi.
Chẩn đoán kèm theo: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
15 giờ 02 phút Thứ 2, 19/10/2026	Sau mổ về khoa TỈnh Huyết động ổn Bụng mềm Đau vết mổ VAS 4/10 GAS +	④ Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 1g x 1 Lọ *Truyên TM 30 G/P 24h* ***Natri clorid [Bitechphar] (0,9% x 250ml) x 1 (Chai)*** Furosemid (**Agifuros**) 40mg x 1 Viên *Uống tối* - Chăm sóc cấp III Chế độ ăn: BT15 Ký số bởi: **Phan Tuấn Hiếu** Ngày ký: **15:05:18 19/10/2026**

Ths.BSNT Phan Tuấn Hiếu

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 5

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Phòng: Phòng 307 Số giường: H018
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi.
Chẩn đoán kèm theo: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
07 giờ 00 phút Thứ 3, 20/10/2026	Bệnh nhân tỉnh Toàn trạng ổn định Không sốt Da niêm mạc hồng Tự thở êm Bụng mềm Vết mổ thấm ít dịch DL ổ bụng ra ít dịch hồng trong Gas(+) --> BCN đi buồng đồng ý với điều trị hiện tại - **DVKT:** + **Siêu âm**: Siêu âm ổ bụng - **Dịch vụ khám**: + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng 5067 + Khám chuyên khoa - hội chẩn [với bệnh nhân nội trú] - Phòng hội chẩn Khoa Hô hấp 425A	(5) Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x 6 Lọ *Pha truyền TM chia 3* ***Glucose 5% [Kabi] (5% x 100ml) x 3 (Chai nhựa PPKB)*** Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x 2 Ống *Tiêm TMC chia 2* Paracetamol (**A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)**) 1g/6,67ml x 1 Ống *Pha truyền TM khi đau* ***Glucose 5% [Kabi] (5% x 100ml) x 1 (Chai nhựa PPKB)*** Salbutamol sulfat (**Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]**) 5mg/5ml x 3 Ống *Khí dung chia 3* Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) (**Ozzy-40**) 40mg x 1 Viên *Uống trước ăn 30 phút* Salbutamol (**Atisaltolin 5mg/2,5ml**) 5mg/2,5ml x 1 Ống *Khí dung* - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: BT15 Ký số bởi: ĐỖ ĐỨC MINH Ngày ký: 08:16:34 21/10/2026
10 giờ 42 phút Thứ 3, 20/10/2026	Trả thuốc	Salbutamol sulfat (**Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]**) 5mg/5ml x -3 Ống Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

MS: 39/BV-01
Số vào viện: 2610163961

TỜ ĐIỀU TRỊ số 5

Họ tên BN: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam
Khoa: Khoa Ngoại tổng hợp Phòng: Phòng 307 Số giường: H018
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi.
Chẩn đoán kèm theo: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGÀY GIỜ	DIỄN BIẾN BỆNH	Y LỆNH
10 giờ 42 phút Thứ 3, 20/10/2026	Trả thuốc	⑥ Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x -4 Lọ **Glucose 5% [Kabi] (5% x 100ml) x -2 (Chai nhựa PPKB)** Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x -1 Ống Salbutamol sulfat (**Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]**) 5mg/5ml x -3 Ống Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh
07 giờ 00 phút Thứ 4, 21/10/2026	Bệnh nhân tỉnh Toàn trạng ổn định Không sốt Da niêm mạc hồng Tự thở êm Bụng mềm Vết mổ khô DL ổ bụng ra ít dịch hồng trong Gas(+) --> BCN đi buồng đồng ý với điều trị hiện tại --> Ổn định, ra viện, hoàn 1 phần thuốc	⑥ Meropenem (**Meropenem/ Anfarm***) 500mg x 6,0 Lọ *Pha truyền TM chia 3* ***Glucose 5% [Kabi] (5% x 100ml) x 3,0 (Chai nhựa PPKB)*** Furosemid (**Vinzix**) 20mg/2ml x 2,0 Ống *Tiêm TMC chia 2* Paracetamol (**A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)**) 1g/6,67ml x 1,0 Ống *Pha truyền TM khi đau* ***Glucose 5% [Kabi] (5% x 100ml) x 1,0 (Chai nhựa PPKB)*** Salbutamol sulfat (**Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]**) 5mg/5ml x 3,0 Ống *Khí dung chia 3* Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) (**Ozzy-40**) 40mg x 1,0 Viên *Uống trước ăn 30 phút* - Chăm sóc cấp II Chế độ ăn: BT15 Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh
08 giờ 19 phút Thứ 4, 21/10/2026	Trả thuốc	Ký số bởi: ĐỖ ĐỨC MINH Ngày ký: 08:21:05 21/10/2026 Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Mã đơn thuốc: 01934269YB2B-c
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: 19006422

2610163961

Phòng 302
Mã BN: 2610036327

RA VIỆN

ĐƠN THUỐC

Họ tên: LÊ DOÃN CẦN
Số điện thoại: 0986 410 715
Ngày sinh: 13/06/1956
Giới tính: Nam
Số định danh cá nhân/CCCD/hộ chiếu của người bệnh: 001056024301
Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
Số thẻ BHYT: GD4010128348609
Chẩn đoán: K81.0 - Viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật hoại tử/ Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - Suy tim EF 36%/ I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Thuốc điều trị:

STT	Tên thuốc - Hàm lượng	SL
1	Cefprozil (**PRICEFIL**) 500 mg *Uống sáng 1 viên, tối 1 viên sau ăn*	14 Viên
2	Ornidazol (**BANZOL 500**) 500mg *Uống sáng 1 viên, tối 1 viên sau ăn*	14 Viên
3	Paracetamol (**PARTAMOL TAB**) 500mg *Uống 1 viên khi đau, pha với nước*	10 Viên
4	**BONCINCO** (300mg + 3mg + 3,5mg ... *Uống sáng 1 ống, tối 1 ống sau ăn*	30 Ống
5	Sacubitril + Valsartan (**UPERIO [K]**) 50mg *Uống sáng 1/2 viên, tối 1/2 viên sau ăn*	15 Viên
6	Empagliflozin (**JARDIANCE 10 [70]**) 10mg *Uống sáng 1 viên sau ăn*	30 Viên
7	Spironolacton (**SPIROVELL 25MG**) 25mg *Uống sáng 1 viên sau ăn*	30 Viên
8	Furosemid (**AGIFUROS**) 40mg *Uống sáng 1 viên sau ăn*	30 Viên

Cộng khoản: 8

Khi sử dụng thuốc có vấn đề thắc mắc xin liên hệ: 19006422 (trong giờ hành chính)

Lời dặn: Ra viện dùng thuốc theo đơn, thay băng cách ngày, cắt chỉ sau 7 ngày tại y tế cơ sở gần nhà. Nghỉ theo chế độ BHXH 7 ngày kể từ ngày ra viện. Đề nghị lấy kết quả giải phẫu bệnh khi khám lại.
Khám lại sau 2 tuần hoặc ngay khi có bất thường tại phòng khám G067 nhà A2 vào thứ 5 (Bác sĩ Đăng Hưng)

Khám lại xin mang theo phiếu này

10:15:55 Ngày 20 tháng 10 năm 2026

Bác sĩ khám bệnh

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

Quét QR để tra cứu bảng kê và xuất HĐĐT

Lưu ý: Quý khách thực hiện thao tác quét mã QR và gửi yêu cầu xuất hóa đơn ngay trong ngày mua thuốc

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ghi chú:

- Quý khách vui lòng gọi điện thoại đến số tổng đài tư vấn và đặt lịch hẹn khám: 19006422 (Cước phí 1000đ/phút) để chủ động đặt lịch hẹn và lấy số khám lần sau.

- Thời gian đặt lịch hẹn khám: Từ 7h00-22h00 các ngày trong tuần. Quý khách vui lòng gọi điện đặt lịch sớm nhất một tuần và chậm nhất 1 ngày trước khi đến khám.

Ký bởi: ĐỖ ĐỨC MINH
Ngày ký: 17:14:47 20/10/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã HS: 2610163961
Mã BN: 2610036327

TRÍCH BIÊN BẢN HỘI CHẨN

Họ và tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 **Giới tính:** Nam ☒ Nữ ☐

Đã điều trị từ ngày: 08:19 16/10/2026 Đến ngày: .../.../...

Tại số giường: K011 Buồng: Khoa Cấp cứu Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính Hội chẩn lúc: 08:19 16/10/2026

Chủ tọa: Ngô Đức Hùng Thư ký: Nguyễn Thành Trung

Thành viên tham gia:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN BỆNH, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Bệnh nhân nam 70 tuổi, tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật
Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, khoảng 19h ngày 15/10/2026, bệnh nhân xuất hiện đau bụng mạn sườn trái lan lên ngực sau xương ức. Ngày nay đau tăng --> CC ĐHY
Khám: Bệnh nhân tỉnh, mệt GCS 15 điểm
Da, niêm mạc hồng
Không phù, không xuất huyết dưới da
Hiện không sốt
Thở oxy kính 3L/phút SpO2 95%
RRPN giảm vùng đáy, rales nổ 2 bên
Tim đều M: 98 ck/phút
HA: 152/86mmHg
Bụng mềm, chướng hơi nhẹ
Điểm đau McBurney (+)
PUTB(+), CUPM (-)
Cơ tròn tự chủ

KẾT LUẬN (Sau khi hội chẩn):

Đồng ý chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc theo ý kiến hội chẩn chuyên khoa, chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc đánh giá tổn thương phổi

HƯỚNG ĐIỀU TRỊ TIẾP THEO:

Chờ kết quả CLS

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

THƯ KÝ(1)

BS Nguyễn Thành Trung

CHỦ TỌA(2)

Ký số bởi: **NGÔ ĐỨC HÙNG**
Ngày ký: **10:50:45 16/10/2026**

BSNT Ngô Đức Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã HS: 2610163961
Mã BN: 2610036327

TRÍCH BIÊN BẢN HỘI CHẨN

Họ và tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 **Giới tính:** Nam ☒ Nữ ☐

Đã điều trị từ ngày: 08:19 16/10/2026 Đến ngày: .../.../...

Tại số giường: K011 Buồng: Khoa Cấp cứu Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Chẩn đoán: K80.0 - Sỏi túi mật kèm viêm túi mật cấp tính/ Viêm túi mật cấp do sỏi Hội chẩn lúc: 15:30 16/10/2026

Chủ tọa: Nguyễn Đăng Hưng Thư ký: Nguyễn Đăng Hưng

Thành viên tham gia:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN BỆNH, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Bệnh nhân nam 70 tuổi,
Tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật
Vào viện vì đau bụng HSP 1 ngày nay, đau âm ỉ liên tục, không sốt
Khám:
Bệnh nhân tỉnh
Da, niêm mạc hồng
Không phù, không xuất huyết dưới da
Không sốt
BỤng ấn đau HSP
Putb (+)
Siêu âm: Túi mật: căng nhẹ, kích thước 94x38mm, thành dày quanh chu vi 5mm, lắng đọng cholesterol thànhtúi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi lớn nhất đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhấtđường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quan
XN máu: Chrp 9
CLVT: Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại trángngang đoạn góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọcrãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung
-> Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp do sỏi
-> Về Ck ngoại tiêu hóa có chỉ định mổ cấp cứu
-> Hoàn thiện bilan, dặn nhịn ăn, giải thích gia đình
-> Báo BS cọc I

KẾT LUẬN (Sau khi hội chẩn):

Viêm túi mật cấp do sỏi

HƯỚNG ĐIỀU TRỊ TIẾP THEO:

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

THƯ KÝ(1)

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

CHỦ TỌA(2)

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

Ký số bởi: NGUYỄN ĐĂNG HƯNG
Ngày ký: 16:48:37 16/10/2026

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
KHOA: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2026

BẢN CAM ĐOAN CHẤP NHẬN THỰC HIỆN PHẪU THUẬT, GÂY MÊ HỒI SỨC

Sau khi trao đổi giữa bác sĩ với người bệnh và người nhà người bệnh, chúng tôi đứng tên dưới đây làm bản cam đoan như sau:

I. BÁC SĨ, PHẪU THUẬT VIÊN, THỦ THUẬT VIÊN

Tên dịch vụ (dự kiến): Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Khoa/phòng: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Chức danh: BS

Tên tôi là: Nguyễn Đăng Hưng

Tôi đã giải thích kỹ và đầy đủ về tình trạng bệnh, lý do cần thực hiện phẫu thuật/thủ thuật, dự kiến phương pháp phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức và những nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra trong, sau quá trình thực hiện phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức và điều trị cũng như các tiên lượng phục hồi sau phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Tôi đã giải thích các vật tư y tế dự kiến sử dụng, kể cả vật tư ngoài danh mục bảo hiểm chi trả có thể cần thiết sử dụng trong phẫu thuật/thủ thuật/Gây mê hồi sức.

Tôi cam kết phục vụ người bệnh bằng lương tâm và trách nhiệm, cùng với tất cả sự hiểu biết về chuyên môn của mình và phương tiện hiện có của Bệnh viện.

II. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI BỆNH - THÂN NHÂN - NGƯỜI GIÁM HỘ

Tôi tên là: Lê Doãn Thái Bình là người bệnh/là: Con

của người bệnh (ghi rõ mối quan hệ với người bệnh), tên là: LÊ DOÃN CẦN

hiện đang điều trị tại Khoa:

1. Chúng tôi đã được bác sĩ giải thích kỹ và đầy đủ về tình trạng bệnh, dự kiến phương pháp phẫu thuật/thủ thuật/ gây mê hồi sức cùng những nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra trước, trong và sau phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức cũng như tiên lượng phục hồi sau phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức. Chúng tôi đã hiểu được lợi ích mà phương pháp phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức mang lại cũng như nguy cơ nếu không thực hiện cuộc phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức này. Chúng tôi cũng hiểu rủi ro, tai biến y khoa là biến cố khách quan ngoài ý muốn của nhân viên y tế và người bệnh.

2. Chúng tôi hiểu rằng bất cứ thay đổi/ bổ sung các kỹ thuật ngoài những mô tả kỹ thuật đã giải thích trước khi phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức của Bác sĩ sẽ chỉ thực hiện khi cần thiết để điều trị tốt nhất cho người bệnh và sẽ được giải thích sau ca mổ. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý để bác sĩ thực hiện các can thiệp kỹ thuật bổ sung này trong trường hợp cần thiết.

3. Chúng tôi hiểu rằng Bác sĩ đã cố gắng mô tả các biến chứng phổ biến nhất có thể xảy ra trong hoặc sau phẫu thuật/ thủ thuật/ gây mê hồi sức. Dù sao vẫn không thể chi tiết đến hết các biến chứng có thể xảy ra. Nếu một biến chứng mà chúng tôi chưa được cảnh cáo xảy ra, bác sĩ sẽ xử lý theo chuyên môn cần thiết và thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.

4. Chúng tôi đã được cho biết: mô (bao gồm cả máu) bị loại bỏ, hình ảnh trong phẫu thuật/ thủ thuật hoặc điều trị sẽ được ẩn danh và có thể được dùng để giảng dạy, kiểm soát chất lượng, lưu trữ hoặc xử lý theo tiêu chuẩn quy định, phù hợp với đạo đức, pháp luật.

5. Chúng tôi đã được giải thích về những vật tư y tế tiêu hao được sử dụng cho cuộc phẫu thuật/ thủ thuật hoặc điều trị sau này có thể không có danh mục của Bảo hiểm y tế chi trả và sẽ thanh toán toàn bộ những chi phí trên.

Chúng tôi đã đọc bản cam kết này với tinh thần tự nguyện và hoàn toàn minh mẫn. Chúng tôi đã hiểu tất cả các vấn đề mà các bác sĩ giải thích về tiến trình phẫu thuật/ thủ thuật, nguy cơ của cuộc phẫu thuật/ thủ thuật/ gây mê hồi sức hoặc sử dụng các mô (bao gồm cả máu) bị loại bỏ, những hình ảnh ẩn danh có thể được dùng để giảng dạy,

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

kiểm soát được chất lượng, lưu trữ hoặc xử lý theo tiêu chuẩn quy định, phù hợp với đạo đức, pháp luật.

Sau khi thảo luận với gia đình, người bệnh, tất cả chúng tôi:

☒ Đồng ý ☐ Không đồng ý cho Bác sĩ tiến hành phẫu thuật/ thủ thuật và cam kết sẽ chấp nhận mọi nguy cơ do tai biến có thể xảy ra (kể cả tử vong) trước, trong và sau quá trình thực hiện phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức cho người bệnh mà không có ý kiến thắc mắc khiếu nại, khiếu kiện gì.

☒ Đồng ý ☐ Không đồng ý sử dụng vật tư tiêu hao ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả (nếu có).

(Chọn "**Đồng ý**" hoặc "**Không đồng ý**")

Xác nhận của người bệnh:

"Tôi đã đọc và hiểu rõ cam đoan này trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo. Tôi đồng ý cho các bác sĩ và các nhân viên y tế thực hiện phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức cho tôi và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình."

Họ và tên người bệnh: LÊ DOÃN CẦN

Chữ ký/xác nhận danh tính:

Ký hoặc điểm chỉ(1)

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Con - Lê Doãn Thái Bình
16/10/2026 16:54:36

Xác nhận của thân nhân người bệnh:

Tôi tên là: Lê Doãn Thái Bình Quan hệ với người bệnh: Con

Sinh ngày: .../.../... Số CMTND/số hộ chiếu/Căn cước:

Cấp ngày: .../.../... Nơi cấp: Số ĐT: 0986 410 715

Địa chỉ:

"Tôi đại diện cho người bệnh, cho gia đình và người thân của người bệnh xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định đồng ý để Bác sĩ và các nhân viên y tế thực hiện phẫu thuật/thủ thuật/gây mê hồi sức cho người bệnh."

Họ và tên: Lê Doãn Thái Bình

Chữ ký(2)

Con - LÊ DOÃN Thái Bình
16/10/2026 16:55:02

III. XÁC NHẬN CỦA BÁC SĨ, PHẪU THUẬT VIÊN/ THỦ THUẬT VIÊN:

Tôi xác nhận một lần nữa rằng: Tôi đã giải thích kỹ và đầy đủ cho người bệnh, thân nhân của người bệnh về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị cùng các nguy cơ biến chứng cũng như tiên lượng hồi phục trong quá trình điều trị.

BÁC SĨ/ PHẪU THUẬT VIÊN(3)

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

PHIẾU PHẪU THUẬT

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐

Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam

Khoa/ Phòng: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Tên dịch vụ: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật ; Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương

Ngày/ giờ mổ: 21:30 16/10/2026 **Kết thúc:** 23:25 16/10/2026

Chẩn đoán:

+ **Trước Phẫu thuật:** Viêm túi mật cấp do sỏi
+ **Sau Phẫu thuật:** Viêm túi mật hoại tử

Phương pháp phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng

Phẫu thuật viên: Nguyễn Đăng Hưng

Phụ Phẫu thuật viên: Đỗ Đức Minh/ Phùng Văn Thức

Bác sỹ gây mê hồi sức: Trần Việt Đức

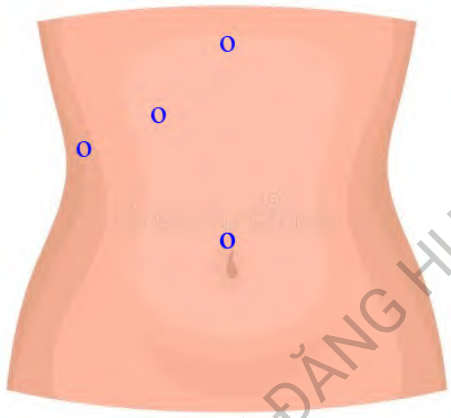
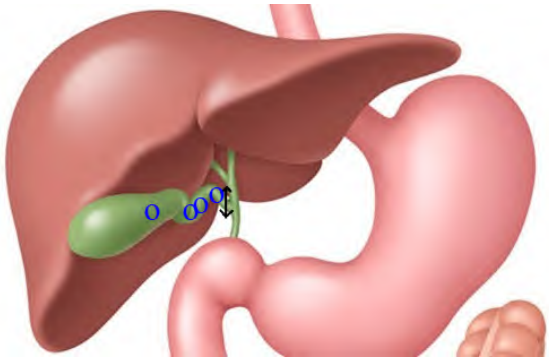
Kỹ thuật viên gây mê: Lê Thị Yến

Điều dưỡng dụng cụ: Ngô Kim Bằng

Phương pháp vô cảm: Mê nội khí quản

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ký số bởi: **NGUYỄN ĐĂNG HƯNG**
Ngày ký: **23:26:26 16/10/2026**

LƯỢC ĐỒ PHẪU THUẬT	TRÌNH TỰ PHẪU THUẬT
 	⁎ Đặt 4 trocart theo hình vẽ ⁎ Vào ổ bụng kiểm tra : Ổ bụng có nhiều dịch đục và giả mạc ở dưới gan và dọc rãnh ĐT (P), phúc mạc nhẵn, gan 2 thùy hồng, túi mật thành dày, có điểm hoại tử đen, sỏi kẹt cổ túi mật. Toàn bộ cuống gan và đầu tụy viêm phù nề. Douglas có ít dịch đục. Các tạng khác nhìn ngoài không có gì đặc biệt. *CĐ : Viêm túi mật hoại tử *PT : Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng ⁎ Tiến hành: Tổ chức xung quanh túi mật hoại tử, dễ chảy máu. Giải phóng túi mật khỏi giường túi mật. Phẫu tích bộc lộ ống cổ túi mật. Cặp ống cổ TM bằng hemalock. Hút rửa ổ bụng. Cầm máu kỹ. Đặt 01 DL dưới gan. Lấy bệnh phẩm gửi giải phẫu bệnh, tháo hơi. ⁎ Đóng các lỗ trocart Lỗ trocart 10mm đóng 2 lớp, lỗ trocart 5mm đóng 1 lớp.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

PHẪU THUẬT VIÊN(1)

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật
nội dung và chữ ký của tôi

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI GÂY MÊ HỒI SỨC

MS: 13/BV-01
Mã NB: 2610036327

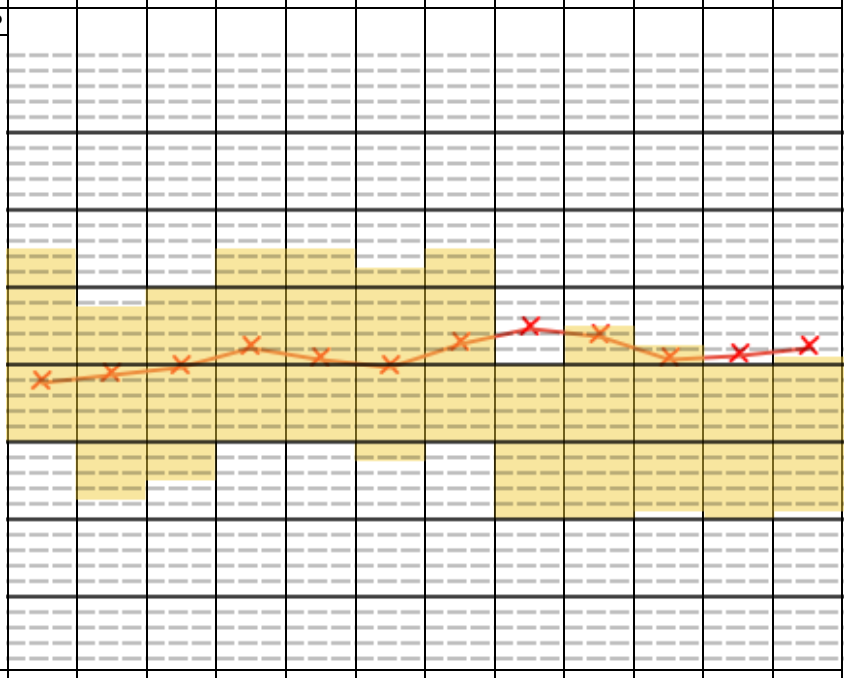
Khoa: Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau
Mã HS: 2610163961

Họ và tên: LÊ DOÃN CẦN Tuổi: 70 Giới tính: Nam Nặng (kg): 66 Cao (cm): 165
Tên dịch vụ: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật
Chẩn đoán: Viêm túi mật cấp do sỏi
Phương pháp PT: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng Tư thế:
Phương pháp vô cảm: Mê nội khí quản Bác sĩ gây mê: Trần Việt Đức
Nhóm máu:O+ Bác sĩ phẫu thuật: Nguyễn Đăng Hưng
Ngày phẫu thuật: 16/10/2026 Tiền mê: Tác dụng:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

ĐÁNH GIÁ TRƯỚC MỔ:
- ASA:
  - ☐ Dạ dày đầy
  - ☐ Cấp cứu
- Malalmapati:
- Dị ứng:
- Tiền sử/ Thuốc liên quan GHMS:
- Bất thường lâm sàng/ cận lâm sàng liên quan GMHS:

Bắt đầu (O) Kết thúc (X)



GIỜ	21:35	21:45	21:55	22:05	22:15	22:25	22:35	22:45	22:55	23:05	23:15	23:25	NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
Nhiệt độ													
Mạch	96	98	100	105	102	100	106	110	108	102	103	105	
Huyết áp	130/80	115/65	120/70	130/80	130/80	125/75	130/80	100/60	110/60	105/62	100/60	102/62	
Rút nội khí quản	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ghi chú													
Đồng từ: Phải/ trái													
Số lượng mất máu													
Số lượng nước tiểu													
Khác													
ALĐMPB ☐ mmHg ☐ mmH2O													
ALTMTT ☐ mmHg ☐ mmH2O													
Nhịp thở	12	12	12	14	14	14	14		14		14		
Hô hấp – Máy mê – TTLT	475	470	475	472	470	475	470		475		475		
Hô hấp – Máy mê – FeCO2	31	32	32	30	30	30	30		30		30		
Hô hấp – Máy mê – Áp lực đường thở	24	28	28	28	28	28	28		28		28		
Hô hấp – Máy mê – SpO2 (%)	100	100	100	100	100	100	100		100		100		
Hô hấp – Máy mê – FiO2 (%)	50	50	50	50	50	50	50		50		50		
Hô hấp – Máy mê – Servoran (%)	2	2	2	2	2	2	2		2		2		
Hô hấp – Máy mê – Desflurane (%)													
(%)													TỔNG CỘNG

THUỐC, DỊCH TRUYỀN		Paracetamol 1g/6,67ml						1				1			2
		Ketorolac 30mg/1ml										30			30
		Rocuronium bromid 50mg/5ml	40												40
		Dexamethason 4mg/1ml	8												8
		Propofol 1%-20ml	150	60											210
		Sevoflurane 100%/250ml													0
		Ondansetron 8mg/4ml	8												8
		Natri clorid 0,9% x 250ml										250			250
		Natri Clorid; Kali clorid; calci clorid dihydrat; Natri lactat khan 3g; 0,15g; 0,1g; 1,55g/500ml	500						500						1000
		Povidon iodin 10% x 500ml													0
		Natri clorid 0,9 % x 1000ml													0
		Phenylephrine 50µg/ml (dưới dạng phenylephrine clohydrat 60.90 µg/ml) 50µg/ml								100					100

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ngày...tháng...năm...

IÊ HỒI SỨC(1)

Ký số bởi: **TRẦN VIỆT ĐỨC**
Ngày ký: **08:11:26 17/10/2026**

ThS. BS. Trần Việt Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG KÊ SỬ DỤNG THUỐC PHẪU THUẬT

Tên NB: LÊ DOÃN CẦN Tuổi: 70 Giới tính: Nam

Mã hồ sơ: 2610163961 Đối tượng: Bảo hiểm Mã BN: 2610036327

Phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên mục	Hàm lượng	Đơn vị	Số lượng
1	A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)	1g/6,67ml	Ống	1
2	Degas	8mg/4ml	Ống	1
3	Dexamethasone	4mg/1ml	Ống	2
4	Diprivan Inj	1%-20ml	Ống	2
5	Lactated Ringer's	3g; 0,15g; 0,1g;	Chai	2
6	Movepain	30mg/1ml	Ống	1
7	Natri clorid [Bitechphar]	0,9% x 250ml	Chai	1
8	Natri clorid [K]	0,9 % x 1000ml	Chai	2
9	Phenylephrine Aguettant 50 mcg/mL [K]	50µg/ml	Bơm	1
10	Povidone iodin 10% (S.Pharm) [K]	10% x 500ml	Chai	0,5
11	Rocuronium-BFS [K] [2-8°C]	50mg/5ml	Lọ	1
12	Sevorane Solution	100%/250ml	mL	20

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

ĐIỀU DƯỠNG PHỤ MÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD Nguyễn Thị Hương

BÁC SĨ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. BS. Trần Việt Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG KÊ SỬ DỤNG VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHẪU THUẬT

Tên NB: LÊ DOÃN CẦN Tuổi: 70 Giới tính: Nam

Mã hồ sơ: 2610163961 Đối tượng: Bảo hiểm Mã BN: 2610036327

Phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên mục	Đơn vị	Số lượng
I. VẬT TƯ			
1	Băng vô trùng có gạc 5x7cm	Miếng	5
2	Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước cố định kim luồn 53 x 80mm	Miếng	1
3	Bộ dẫn lưu áp lực âm silicon kèm dây dẫn/ Dây to	Bộ	1
4	Bộ dây thở máy dùng một lần	Cái	1
5	Bơm tiêm 10ml đầu trượt	Cái	3
6	Bơm tiêm 20ml	Cái	3
7	Bơm tiêm 5ml	Cái	3
8	Cannula mayo	Cái	1
9	Chạc 3 tiêm (dây 25cm)	Cái	2
10	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide ≥75cm, số 3/0, có 1 kim 3/8C dài 26mm (± ≤1mm) Nylon Monofilament	Sợi	1
11	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 dài ≥90cm có chất kháng khuẩn, số 1, có 1 kim 1/2C dài 40mm (± ≤1mm) Vicryl Plus	Sợi	1
12	Đầu nối ống dẫn lưu thẳng	Cái	1
13	Đầu nối vát	Cái	1
14	Điện cực tim	Cái	3
15	Gạc phẫu thuật cỡ 10x10cmx12 lớp, có sợi cản quang	Cái	30
16	Gạc PTKD 7.5x7.5x6 lớp	Cái	10
17	Găng chăm sóc không vô trùng (KHÔNG BỘT)/ Cỡ M	Đôi	30
18	Găng phẫu thuật đã tiệt trùng/ Cỡ 7	Đôi	10
19	Kẹp (clip) cầm máu tự khóa Polyme, các cỡ	Cái	6
20	Kim lấy thuốc/ 18F	Cái	3
21	Kim luồn an toàn có cánh, không cổng tiêm dùng cho người lớn	Cái	1
22	Kim luồn tĩnh mạch các số các cỡ	Cái	1
23	Lọc khuẩn, lọc virus	Cái	2
24	Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật/11	Cái	1
25	Mặt nạ thở oxy	Cái	1
26	Ống nối dây máy thở gấp góc	Cái	1
27	Ống nội khí quản có bóng chèn và không bóng chèn	Cái	1
28	Tấm điện cực trung tính có dây	Cái	0,2
29	Tấm trải nilon 100 x130cm	Cái	1

STT	Tên mục	Đơn vị	Số lượng
30	Thông dạ dày/16F	Cái	1
31	Thông dạ dày/18F	Cái	1
32	Túi camera M6	Cái	1
33	Vật liệu cầm máu tự tiêu Cellulose oxy hóa tái tổ hợp cỡ lớn. 10.2cm x 20.3cm (W1912)	Miếng	1
34	VT70.39. Dây hút dịch phẫu thuật	Cái	1

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD. Lương Thị Hiền

ĐIỀU DƯỠNG PHỤ MÊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD. Lương Thị Hiền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

Mã HS: 2610163961
Mã BN: 2610036327

Họ và tên NB: LÊ DOÃN CẦN **Ngày sinh:** 13/06/1956 **Giới tính:** ☒ Nam ☐ Nữ

Chẩn đoán trước PT: Viêm túi mật cấp do sỏi **Ngày phẫu thuật:** 16/10/2026 **Khoa chuyển mổ:** Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau **Phòng mổ:** 6

TRƯỚC KHI GÂY MÊ

ĐD phụ mê

☒ 1. Xác nhận đã kiểm tra tên, tuổi, giới, mã hồ sơ của người bệnh.
☒ 2. Xác nhận đã kiểm tra vị trí, phương pháp phẫu thuật và giấy cam kết phẫu thuật.
☒ 3. Xác nhận đã kiểm tra thuốc và các thiết bị gây mê.
☒ 4. Xác nhận có máy Monitor, máy đo bão hoà oxy trong máu gắn trên người bệnh và hoạt động bình thường...

ĐD dụng cụ và ĐD chạy ngoài

☒ 1. Xác nhận đủ các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho cuộc PT như: bộ dụng cụ phẫu thuật, máy hút, dao điện, giàn mổ nội soi...

BS gây mê

Người bệnh có:

1. Tiền sử dị ứng?
   ☒ Không ☐ Có
2. Khó thở/Nguy cơ bị sặc?
   ☒ Không ☐ Có thiết bị hỗ trợ đã sẵn sàng
3. Có dự trù máu?
   ☒ Không ☐ Có
4. Có nguy cơ tắc mạch?
   ☒ Không ☐ Có

TRƯỚC KHI RẠCH RA

Phẫu thuật viên

☒ 1. Xác nhận tất cả các thành viên trong kíp đã giới thiệu tên và nhiệm vụ
☒ 2. Xác nhận lại họ tên, tuổi, giới của người bệnh.
☒ 3. Xác nhận chẩn đoán trước phẫu thuật, vị trí rạch da, phương pháp phẫu thuật.
☒ 4. Film của người bệnh được PTV chuẩn bị đầy đủ và hiển thị trên đèn đọc film.
☒ 5. Thời gian PT dự kiến: phút
☒ 6. Tiên lượng mất máu: ml
☒ 7. Tiên lượng các biến cố, dự tính những bất thường trong phẫu thuật:

BS gây mê

1. Vấn đề đặc biệt cần chú ý ở người bệnh?
   ☐ Không ☒ Có VP
2. Kháng sinh dự phòng có được thực hiện trong vòng 60 phút gần đây không?
   ☐ Không ☒ Có
3. Có tiền sử dùng thuốc chống đông?
   ☒ Không ☐ Có

ĐD dụng cụ và ĐD chạy ngoài

☒ 1. Xác nhận tiệt trùng dụng cụ
☒ 2. Xác nhận đã đếm bông gạc và ghi lên bảng

TRƯỚC KHI NB RỜI PHÒNG PHẪU THUẬT

ĐD dụng cụ và ĐD chạy ngoài

☒ 1. Hoàn thành việc kiểm tra, đếm thiết bị, kim, bông, gạc PT,...đã sử dụng cho cuộc PT.
☒ 2. Dán nhãn bệnh phẩm phẫu thuật **(Đọc to nhãn bệnh phẩm, gồm cả thông tin NB)**
3. Có vấn đề gì về dụng cụ cần giải quyết?
   ☒ Không ☐ Có
   1bp

Bàn giao phòng hồi tỉnh - hồi sức

Phẫu thuật viên và BS gây mê

☒ 1. Những vấn đề chính về tình trạng người bệnh liên quan tới hậu phẫu, hồi sức:

ĐD phụ mê và ĐD hồi sức

☒ 1. Đủ, đúng bệnh án + số film:
☒ 2. Thời gian , phương pháp phẫu thuật
3. Vấn đề chính liên quan đến chăm sóc người bệnh sau mổ:
   ☐ Dị ứng, phản vệ:
   ☐ Chế phẩm máu: ml
   ☒ Dịch truyền: ml
   ☒ Số lượng nước tiểu: ml
   ☐ Thuốc đặc biệt cần lưu ý:

PHẪU THUẬT VIÊN[1] (hoặc BS được uỷ quyền)	BS GÂY MÊ[1] (hoặc BS được uỷ quyền)	ĐD PHỤ MÊ[1]	ĐD DỤNG CỤ[1]	ĐD CHẠY NGOÀI[1]
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng	ThS. BS. Trần Việt Đức	ĐD. Lê Thị Yến	ĐD. Lương Thị Hiền	ĐD. Lương Thị Hiền

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU CÔNG KHAI DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH NỘI TRÚ

Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 16/10/2026

Mã hồ sơ: 2610163961
Số giường: H027
Số buồng: Cấp cứu lưu 141

Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/06/1956 Ngày vào viện: 16/10/2026
Chẩn đoán: K81.0 Viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Tên Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	Đơn vị	Số lượng (theo ngày/tháng)							Ghi Chú
			16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	
1.	**Xét nghiệm**									
1	Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]	Lần	1,0							
2	Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]	Lần	1,0							
3	Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]	Lần	1,0							
4	Định lượng Creatinin (máu)	Lần	1,0							
5	Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu]	Lần	1,0							
6	Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss-phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động	Lần	1,0							
7	Định lượng Troponin T [Máu]	Lần	1,0							
8	Định lượng Urê máu [Máu]	Lần	1,0							
9	Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)	Lần	1,0							
10	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]	Lần	1,0							
11	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]	Lần	1,0							
12	Đo hoạt độ Lipase [Máu]	Lần	1,0							
13	Mức lọc cầu thận ước tính (CKD-EPI Creatinine 2021)	Lần	1,0							
14	Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động	Lần	1,0							
15	Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động	Lần	1,0							
16	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)	Lần	1,0							
17	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) [POCT]	Lần	1,0							
18	Xét nghiệm Khí máu [Máu]	Lần	1,0							
2.	**Chẩn đoán hình ảnh**									
1	Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)	Lần	1,0							
2	Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy)[Có tiêm thuốc, chưa bao gồm thuốc cản quang]	Lần	1,0							
3	Chụp X-quang ngực thẳng [chụp tim phổi thẳng]	Lần	1,0							
4	Điện tim thường	Lần	1,0							
5	Siêu âm ổ bụng	Lần	1,0							

STT	Tên Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh	Đơn vị	Số lượng (theo ngày/tháng)							Ghi Chú
			16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	
6.	**Thuốc, dịch truyền (tên, nồng độ/hàm lượng)**									
1	Glucose 10% [IVC] 10% - 500ml	Chai	1,0							
2	Meronem* 1g	Lọ	3,0							
3	Meropenem/ Anfarm* 500mg	Lọ	2,0							
4	Natri clorid [Bitechphar] 0,9% - 500ml	Chai	1,0							
5	Natri clorid [Bitechphar] 0,9% x 250ml	Chai	4,0							
6	Ultravist 370 768.86 mg/ml, 100ml	Chai	0,7							
7.	**Vật tư y tế (không có trong dịch vụ kỹ thuật)**									
1	Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước cố định kim luồn 53 x 80mm	Miếng	1,0							
2	Bơm tiêm 10ml đầu trượt	Cái	1,0							
3	Bơm tiêm 1ml đầu trượt	Cái	1,0							
4	Bơm tiêm 5ml	Cái	1,0							
5	Chạc 3 tiêm không dây nối	Cái	1,0							
6	Dây truyền dịch loại có bịt đầu nhọn, có gài gập dây nhanh, có chức năng đuổi khí tự động và ngăn dịch	Cái	1,0							
7	Găng chăm sóc có bột	Đôi	2,0							
8	Kim lấy thuốc/ 18F	Cái	1,0							
9	Kim luồn tĩnh mạch các số các cỡ	Cái	1,0							
10	Que test thử đường máu mao mạch	Cái	2,0							
11	Vòng đeo tay bệnh nhân	Cái	1,0							

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Ngày 16 tháng 10 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vợ - BÙI HOÀNG BÍCH HỒNG
16/10/2026 20:55:29

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐD. Đàm Thị Hương Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Khoa Ngoại tổng hợp

Số: 351357/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MS:02
Số Hồ sơ/Số BA: 2610163961/2610036327

GIẤY RA VIỆN

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

- Họ tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/06/1956 (Tuổi: 70)
- Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp:
- Số CCCD/CMND/Định danh công nhân/Hộ chiếu: 001056024301 Ngày cấp: 10/07/2021
- Mã số BHXH/Thẻ BHYT số: GD4010128348609
- Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
- Vào viện lúc: 08 giờ 19 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2026
- Ra viện lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2026
- Chẩn đoán:

+ Bệnh chính: K81.8 - Viêm túi mật thể khác

+ CĐ ra viện (chi tiết): Viêm túi mật hoại tử/ Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - Suy tim EF 36%

+ Bệnh kèm theo: I50.9 - Suy tim, không xác định;J18.9 - Viêm phổi, không xác định;J44.1 - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đợt cấp, không xác định

- Phương pháp điều trị: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng

- Ghi chú:

+ Lời dặn bác sĩ (chi tiết): Ra viện dùng thuốc theo đơn, thay băng cách ngày, cắt chỉ sau 7 ngày tại y tế cơ sở gần nhà.
Nghỉ theo chế độ BHXH 7 ngày kể từ ngày ra viện. Đề nghị lấy kết quả giải phẫu bệnh khi khám lại.
Khám lại sau 2 tuần hoặc ngay khi có bất thường tại phòng khám G067 nhà A2 vào thứ 5 (Bác sĩ Đăng Hưng)

+ Người bệnh đặt lịch khám, tái khám liên hệ trước qua Hotline: 19006422

Ngày 21 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Vũ Hoàng Phương

Ký số bởi: VŨ HOÀNG PHƯƠNG
Ngày ký: 08:41:03 21/10/2026

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

PGS.TS Nguyễn Hoàng

Ký số bởi: NGUYỄN HOÀNG
Ngày ký: 08:08:43 21/10/2026

Vui lòng cài đặt ứng dụng BV ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI từ App Store hoặc Google Play để đăng nhập hồ sơ sức khỏe.
Đề nghị tự bảo mật thông tin về tài khoản.
Tài khoản đăng nhập: , mật khẩu:

B. TỔNG KẾT BỆNH ÁN

1. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng: Tiền sử viêm phế quản mạn tính, sỏi túi mật

Vào viện vì đau bụng HSP 1 ngày nay, đau âm ỉ liên tục, không sốt

Khám:

Bệnh nhân tỉnh

Da, niêm mạc hồng

Không phù, không xuất huyết dưới da

Không sốt

BỤng ấn đau HSP

Putb (+)

Siêu âm: Túi mật: căng nhẹ, kích thước 94x38mm, thành dày quanh chu vi 5mm, lắng đọng cholesterol thànhtúi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi lớn nhất đường kính 19mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ lớn nhấtđường kính 4mm, thâm nhiễm mỡ nhẹ xung quan

XN máu: Chrp 9

CLVT: Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại tràngngang đoạn góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọcrãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

2. Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: CLVT: Hình ảnh theo dõi sỏi, bùn túi mật và ống cổ túi mật/ viêm túi mật cấp. Dày thành đại tràng lên, đại tràngngang đoạn

góc gan - theo dõi viêm phản ứng. Dày nhẹ thành tá tràng đoạn ngang mức đầu tụy. Ít dịch dọcrãnh đại tràng lên và vùng tiểu khung

3. Phương pháp điều trị: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Phẫu thuật, thủ thuật: Phẫu thuật ☒ Thủ thuật ☒

Giờ, ngày	Phương pháp phẫu thuật, vô cảm	Bác sĩ phẫu thuật	Bác sĩ gây mê
16/10/2026	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng	Nguyễn Đăng Hưng	Trần Việt Đức

4. Tình trạng người bệnh ra viện: Ổn định

5. Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo: Ra viện

Hồ sơ, phim, ảnh		NGƯỜI GIAO HỒ SƠ	Ngày 21 tháng 10 năm 2026
Loại	Số tờ		BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ
- X quang			
- CT scanner			
- Siêu âm		NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ	Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh
- Xét nghiệm			
- Khác			
- Toàn bộ hồ sơ			

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã số vào viện: 2610163961
Mã NB: 2610036327

HỒ SƠ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CỦA ĐIỀU DƯỠNG

1. Họ và tên người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN**
2. Tuổi: 70 Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐ Giường: H018 Phòng: Phòng 307
3. Số điện thoại liên hệ: 0986 410 715
4. Địa chỉ liên hệ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
5. Ngày/tháng/năm vào viện: 16-10-2026
6. Lí do vào viện: đau bụng mạn sườn trái
7. Quá trình bệnh lý: Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà,khoảng 19h ngày 15/10/2026, bệnh nhân xuấthiện đau bụng mạn sườn trái lan lên ngực sauxương ức. Ngày nay đau tăng --> CC ĐHY
8. Chẩn đoán: Viêm túi mật hoại tử/ Giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - Suy tim EF 36%
9. Tiền sử bệnh: Tiểu đường ☐ Cao HA ☐ Bệnh tim mạch ☐ Hen xuyễn ☐ Dạ dày ☐

Khác: tiền sử viêm phếquản mạn tính, sỏi túi mật

Gia đình: Khỏe mạnh ☒ Có người bệnh tật ☐

10. Tiền sử dị ứng

- Thuốc: chưa phát hiện
- Khác (thời tiết, thức ăn, mỹ phẩm,...): chưa phát hiện

11. Dự kiến chăm sóc và theo dõi:

- Tiếp đón - hướng dẫn nội quy ☒
- Đo dấu hiệu sinh tồn ☒
- Mời BS khám và cho y lệnh ☒
- Thực hiện y lệnh ☒
- Dinh dưỡng ☒
- Giáo dục sức khỏe ☒
- Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ ☒
- Chăm sóc bệnh nhân sau mổ ☐
- Khác:

ĐIỀU DƯỠNG ĐÓN BỆNH NHÂN(1)

ĐD Vũ Thị Thúy Hoài

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa : Khoa Ngoại tổng hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi : Lãnh đạo khoa: Khoa Ngoại tổng hợp

Tên tôi là : con: Lê Doãn Thái Bình

Là người nhà của **Người bệnh**: LÊ DOÃN CẦN

Tôi đã được phổ biến nội quy Bệnh viện và nội quy Khoa phòng, tôi viết giấy này xin nằm điều trị loại giường như sau:

+ Khoa điều trị: Khoa Ngoại tổng hợp

Loại phòng - Đơn giá	Từ ngày	Đến ngày
	...:... .../.../...	...:... .../.../...
	...:... .../.../...	...:... .../.../...

- Trong thời gian nằm viện để phục vụ cho công tác điều trị, khám chữa bệnh, nếu phát sinh chuyển giường Người bệnh và người nhà chấp hành đúng theo bảng giá giường tại Bệnh viện.
- Tôi nộp tạm ứng viện phí lần đầu theo quy định bệnh viện ít nhất là: VNĐ và nộp tiếp theo định kỳ khi được thông báo.
- Người nhà ở lại chăm sóc người bệnh phải đeo thẻ/ mặc áo vàng theo quy định. Khi làm mất thẻ người nhà người bệnh, tôi đồng ý đền bù 100.000 VNĐ/thẻ.
- Tôi xin cam đoan chấp hành:

+ Thực hiện đầy đủ các chỉ định điều trị, chăm sóc của Bác sỹ, Điều dưỡng và nhân viên y tế về: Thuốc, dinh dưỡng , vệ sinh, thời gian xuất viện kể cả người bệnh nằm giường đặc biệt hoặc điều trị tại Khoa KCBYC.

+ Tự giữ gìn bảo vệ tài sản cá nhân, bệnh viện, tiết kiệm điện nước.

+ Người nhà người bệnh không được ngồi lên giường và ăn trong buồng bệnh.

+ Người nhà người bệnh không được hút thuốc lá trong bệnh viện.

+ Thanh toán viện phí đầy đủ khi ra viện.

Ngày 19 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH/ NGƯỜI BỆNH(1)

Cần

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã số: 2610163961

PHIẾU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Họ tên bệnh nhân: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: **70** Giới **Nam**
Giường: H053 Phòng: Phòng 302
Chẩn đoán: **K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

THỜI GIAN	DIỄN BIẾN	THỰC HIỆN - CHĂM SÓC
14:00 19/10/2026	**1. Ý thức:** Tỉnh [X], lơ mơ [ ], hôn mê [ ] Glasgow: **2. Da,n/mạc:** hồng [X], hơi nhợt [ ], nhợt [ ] khác: **3. Khó thở:** có [ ], không [X] **4. Đau:** có [X], không [ ] vị trí: vm độ đau: 4/10 **5. Vận động:** liệt [ ], yếu [ ], bình thường [X] **6. Ho:** khan [ ], đờm [ ], máu [ ], đau ngực [ ] khác: **7. Tiêu hóa:** chán ăn [ ], ăn kém [ ], buồn nôn [ ], nôn [ ] + Đau bụng [ ], tiêu chảy [ ], táo bón [ ] số lần: **8. Vết thương/VM:** Khô [X], thấm dịch [ ] khác: Dẫn lưu: số lượng: ml, khác: **9.** Phù [ ], Cổ chướng [ ] **10. Tiết niệu:** đái buốt/dắt [ ], máu [ ] + NT: màu sắc: số lượng: **11. Loét:** có [ ], không [X] , độ loét: , vị trí: **12. Dinh dưỡng:** **13. Khác:** BỆNH NHÂN ĐÓN TỪ PHÒNG HỒI TỈNH VỀ KHOA HA 120/80 mmHg NHIỆT ĐỘ 36.8 DLOB RA 20 ML DỊCH HỒNG	**1. Thực hiện y lệnh** + Thuốc [X] + Cận lâm sàng: XN [ ] CĐHA [ ] TDCN [ ] Khác: + Đo DHST + Thay băng: Có [ ] Không [X] + Rút dẫn lưu: Có [ ] Không [X] + Thủ thuật: + Cấp chăm sóc: Cấp I [ ] Cấp II [X] Cấp III [ ] **2. Thông báo nội quy** [X] **3. Dinh dưỡng:** **4. Vệ sinh cá nhân:** **5. PHCN:** **6. GDSK:** **7. Chăm sóc khác:** THỰC HIỆN Y LỆNH THEO DÕI TOÀN TRẠNG BÁO BS THỰC HIỆN Y LỆNH HC TIM MẠCH, HC HÔ HẤP **ĐD ghi rõ tên:** Bùi Thị Hoài Liên **ĐD. Bùi Thị Hoài Liên**
09:00 20/10/2026	**1. Ý thức:** Tỉnh [X], lơ mơ [ ], hôn mê [ ] , Glasgow: **2. Da,n/mạc:** hồng [X], hơi nhợt [ ], nhợt [ ] Khác: **3. Khó thở:** có [ ], không [X] **4. Tiêu hóa:** Nôn [ ], buồn nôn [ ], chán ăn [ ], ăn kém [ ] đau bụng [ ], tiêu chảy [ ], táo bón [ ] , số lần **5. Vết mổ/VT:** khô [ ], thấm dịch [X], chảy máu [ ] - Dẫn lưu: có [X] không [ ] , số lượng: , màu sắc: **6. Sonde tiểu:** có [ ] không [X] **7. Dinh dưỡng:** sonde DD [ ], Mở thông DD/HT [ ] **8. Đau:** có [X] không [ ] (vị trí , tính chất) **9. Vận động:** Tại giường [ ], ngồi dậy [ ], đi lại [X] **10. Dấu hiệu, triệu chứng khác:** Bệnh nhân không sốt Huyết động ổn Tự thở êm Bụng mềm Đau tức vùng mổ Vết mổ thấm ít dịch Dẫn lưu dưới gan ra 50ml dịch hồng Chân dẫn lưu không thấm dịch Trung tiện được Vân động đi lại được	**1. Thực hiện y lênh** + Thuốc [X] + Đo DHST + Xét nghiệm [ ] TDCN [ ] CĐHA [ ] + Thay băng vết mổ: Có [X] Không [ ] + Chế độ chăm sóc cấp: Cấp I [ ] Cấp II [X] Cấp III [ ] + Tiến hành các thủ thuật: đặt sonde tiểu [ ] dạ dày [ ] chườm ấm [ ] chườm lạnh [ ] rút DL [ ] vỗ rung [ ] **2. Vệ sinh cá nhân:** Có [X] Không [ ] **3. Phục hồi chức năng:** Có [ ] Không [X] **4. Chế độ ăn:** BT01 [ ] BT15 [X] DD02 [ ] **5. Thay quần áo, ga trải giường:** Có [X] Không [ ] **6. Chăm sóc khác:** BS Minh chỉ định --> Siêu âm ổ bụng Thực hiện y lệnh Theo dõi đau, dấu hiệu sinh tồn Theo dõi mầu sắc, tính chất, số lượng dẫn lưu **ĐD ghi rõ tên:** Nguyễn Thị Yến **ĐD. Nguyễn Thị Yến**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã số: 2610163961

PHIẾU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Họ tên bệnh nhân: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: **70** Giới **Nam**
Giường: H053 Phòng: Phòng 302
Chẩn đoán: **K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

08:10 21/10/2026	**1. Ý thức:** Tỉnh [X], lơ mơ [ ], hôn mê [ ] , Glasgow: **2. Da,n/mạc:** hồng [X], hơi nhợt [ ], nhợt [ ] Khác: **3. Khó thở:** có [ ], không [X] **4. Tiêu hóa:** Nôn [ ], buồn nôn [ ], chán ăn [ ], ăn kém [ ] đau bụng [ ], tiêu chảy [ ], táo bón [ ] , số lần **5. Vết mổ/VT:** khô [X], thấm dịch [ ], chảy máu [ ] - Dẫn lưu: có [X] không [ ] , số lượng: , màu sắc: **6. Sonde tiểu:** có [ ] không [X] **7. Dinh dưỡng:** sonde DD [ ], Mở thông DD/HT [ ] **8. Đau:** có [X] không [ ] (vị trí , tính chất) **9. Vận động:** Tại giường [ ], ngồi dậy [ ], đi lại [X] **10. Dấu hiệu, triệu chứng khác:** Bệnh nhân không sốt Huyết động ổn Tự thở êm Bụng mềm Đau tức vùng mổ Vết mổ khô Dẫn lưu dưới gan ra ~10ml dịch hồng Chân dẫn lưu không thấm dịch Trung tiện được Vân động đi lại được	**1. Thực hiện y lênh** + Thuốc [X] + Đo DHST + Xét nghiệm [ ] TDCN [ ] CĐHA [ ] + Thay băng vết mổ: Có [X] Không [ ] + Chế độ chăm sóc cấp: Cấp I [ ] Cấp II [X] Cấp III [ ] + Tiến hành các thủ thuật: đặt sonde tiểu [ ] dạ dày [ ] chườm ấm [ ] chườm lạnh [ ] rút DL [ ] vỗ rung [ ] **2. Vệ sinh cá nhân:** Có [X] Không [ ] **3. Phục hồi chức năng:** Có [ ] Không [X] **4. Chế độ ăn:** BT01 [ ] BT15 [X] DD02 [ ] **5. Thay quần áo, ga trải giường:** Có [ ] Không [X] **6. Chăm sóc khác:** BS Minh chỉ định --> Rút dẫn lưu ổ bụng --> Ổn định, ra viện, hoàn 1 phần thuốc Thực hiện y lệnh Tổng kết ra viện giáo dục sức khỏe Hướng dẫn thay băng cắt chỉ tại cơ sở y tế địa phương Hướng dẫn thủ tục ra viện **ĐD ghi rõ tên:** Nguyễn Thị Yến **ĐD. Nguyễn Thị Yến**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H004 | Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Đăng Hưng
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(1) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g *SE 1g/3h lúc 2h sáng*	**1**	**Lọ**	
2	**Natri Clorid; Kali clorid; calci clorid dihydrat; Natri lactat khan** (Lactated Ringer's) 3g; 0,15g; 0,1g; 1,55g/500ml *Truyền tĩnh mạch 50ml/h*	**1**	**Chai**	
3	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml *Pha dịch truyền ringer*	**1**	**Ống**	
4	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml *Truyền tĩnh mạch lúc 5h sáng mai*	**1**	**Ống**	
5	**Pantoprazol** (Ulceron [ĐB]) 40mg *Tiêm tĩnh mạch chậm*	**1**	**Lọ**	
6	**Propofol** (Diprivan Inj) 1%-20ml *SE 20ml/h*	**7**	**Ống**	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *Pha thuốc*	**1**	**Chai**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

Con - bình
17/10/2026 05:51:55

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Phạm Thị Khương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	**Glucose** (Glucose 10% [IVC]) 10% - 500ml *Truyền tĩnh mạch 50ml/h*	**1**	**Chai**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
16/10/2026 16:05:19

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

CNĐD Nguyễn Thị Trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *Pha kháng sinh*	**3**	**Chai**	
2	(1) **Meropenem** (Meronem*) 1g *Pha 1 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 18h - 02h - 10h*	**3**	**Lọ**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
16/10/2026 11:59:37

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Nguyễn Thị Kim Chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(1) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *Pha 2 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 9h45*	**2**	**Lọ**	
2	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *Pha kháng sinh*	**1**	**Chai**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
16/10/2026 09:52:58

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Nguyễn Thị Kim Chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% - 500ml *Truyền tĩnh mạch chậm duy trì vein*	**1**	**Chai**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
16/10/2026 08:30:07

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Nguyễn Thị Kim Chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 17/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H004 | Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 | Bác sĩ điều trị: Trần Việt Đức
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(2) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h*	**6**	**Lọ**	
2	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml *truyền tĩnh mạch*	**1**	**Chai nhựa PPKB**	
3	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
4	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**1**	**Ống**	
5	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
6	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4*	**1**	**Ống**	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *pha paracetamol*	**1**	**Chai**	
8	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml *truyền tĩnh mạch*	**2**	**Chai**	

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
9	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml *tiêm tĩnh mạch chậm 1/2 ống nếu tiểu < 100ml/3h*	**1**	**Ống**	Hoàn trả
10	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg *tiêm tĩnh mạch chậm*	**1**	**Lọ**	
11	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*	**1**	**Bơm tiêm**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
19/10/2026 06:00:29

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Vương Thị Diệu My

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 18/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN
Tuổi: 70
Giới tính: Nam
Số giường: H038
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Bác sĩ điều trị: Trần Xuân Bách

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(3) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h*	**6**	**Lọ**	
2	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml *truyền tĩnh mạch*	**1**	**Chai nhựa PPKB**	
3	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
4	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**1**	**Ống**	
5	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
6	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4*	**1**	**Ống**	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *pha paracetamol*	**1**	**Chai**	
8	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml *truyền tĩnh mạch*	**1**	**Chai**	
9	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml *tiêm tĩnh mạch chia 4*	**2**	**Ống**	

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
10	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg *tiêm tĩnh mạch chậm*	**1**	**Lọ**	
11	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*	**1**	**Bơm tiêm**	
12	**Acetylcystein** (Acetylcystein) 200mg *Uống chia 3 cách 8h*	**3**	**Gói**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
19/10/2026 04:32:04

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Chu Thị Thủy

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 19/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Phan Tuấn Hiếu
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(4) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g *Truyền TM 30 G/P 24h* **Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml	**1** **1**	**Lọ** **Chai**	
2	**Furosemid** (Agifuros) 40mg *Uống tối*	**1**	**Viên**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
19/10/2026 15:38:04

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Bùi Thị Hoài Liên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 19/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN
Tuổi: 70
Giới tính: Nam
Số giường: H038
Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ)
Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thanh Hiền

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml *truyền tĩnh mạch*	**1**	**Chai nhựa PPKB**	
2	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
3	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml *pha truyền tĩnh mạch*	**1**	**Ống**	
4	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml *pha truyền tĩnh mạch*	**2**	**Ống**	
5	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *pha paracetamol*	**1**	**Chai**	hoàn 1
6	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml *truyền tĩnh mạch*	**1**	**Chai**	
7	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml *tiêm tĩnh mạch chia 4*	**2**	**Ống**	hoàn 1
8	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg *tiêm tĩnh mạch chậm*	**1**	**Lọ**	hoàn 1

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
9	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*	**1**	**Bơm tiêm**	hoàn 1
10	**Acetylcystein** (Acetylcystein) 200mg *Uống chia 3 cách 8h*	**3**	**Gói**	hoàn 2
11	(4) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g *SE 1 lọ/3h*	**1**	**Lọ**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
19/10/2026 12:54:54

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Nguyễn Thị Linh Chi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 20/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	**Salbutamol** (Atisaltolin 5mg/2,5ml) 5mg/2,5ml *Khí dung*	**1**	**Ống**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
20/10/2026 15:24:30

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Nguyễn Thị Yến

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 20/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(5) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *Pha truyền TM chia 3* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml	**6** **3**	**Lọ** **Chai nhựa**	
2	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml *Tiêm TMC chia 2*	**2**	**PPKB Ống**	
3	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml *Pha truyền TM khi đau* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml	**1** **1**	**Ống** **Chai nhựa**	
4	**Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat)** (Ozzy-40) 40mg *Uống trước ăn 30 phút*	**1**	**PPKB Viên**	
5	**Salbutamol sulfat** (Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]) 5mg/5ml *Khí dung chia 3*	**0** (-3)	**Ống**	

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
20/10/2026 15:24:06

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Nguyễn Thị Yến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 21/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(6) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *Pha truyền TM chia 3* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml	**2** (-4) **1** (-2)	**Lọ** **Chai nhựa**	
2	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml *Tiêm TMC chia 2*	**1** (-1)	**PPKB Ống**	
3	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml *Pha truyền TM khi đau* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml	**1** **1**	**Ống** **Chai nhựa**	
4	**Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat)** (Ozzy-40) 40mg *Uống trước ăn 30 phút*	**1**	**PPKB Viên**	
5	**Salbutamol sulfat** (Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]) 5mg/5ml *Khí dung chia 3*	**0** (-3)	**Ống**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN

LÊ DOÃN CẦN
21/10/2026 08:25:37

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐDT. Nguyễn Thế Tuyền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 16/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H004 | Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Đăng Hưng
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(1) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g x 1 Lọ *SE 1g/3h lúc 2h sáng*				02:00 17/10 (LT.Yến)	
2	**Natri Clorid; Kali clorid; calci clorid dihydrat; Natri lactat khan** (Lactated Ringer's) 3g; 0,15g; 0,1g; 1,55g/500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch 50ml/h*				23:50 (LT.Yến) 16/10	
3	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml x 1 Ống *Pha dịch truyền ringer*				23:50 (LT.Yến) 16/10	
4	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml x 1 Ống *Truyền tĩnh mạch lúc 5h sáng mai*				05:00 17/10 (LT.Yến)	
5	**Pantoprazol** (Ulceron [ĐB]) 40mg x 1 Lọ *Tiêm tĩnh mạch chậm*				23:50 16/10 (LT.Yến)	

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
6	**Propofol** (Diprivan Inj) 1%-20ml x 7 Ống *SE 20ml/h*				23:50 16/10 (LT.Yến) 02:01 17/10 (LT.Yến) 05:00 17/10 (LT.Yến)	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 1 Chai *Pha thuốc*				05:00 (LT.Yến) 17/10	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Phạm Thị Khương

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

PHIẾU BÀN GIAO THUỐC

Ngày 16/10/2026

Mã NB: 2610036327
Bệnh án:

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

STT	Y LỆNH	SL	ĐVT	Ghi chú
1	(1) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg *Pha 2 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 9h45*	**2**	**Lọ**	
2	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml *Pha kháng sinh*	**1**	**Chai**	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI BỆNH KÝ TÊN



NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 16/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% - 500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch chậm duy trì vein*	08:25 (NTK.Chi)				

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Nguyễn Thị Kim Chi

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 16/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: K011 | Phòng: Khoa Cấp cứu | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: R10.0 - Đau bụng cấp tính

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 3 Chai *Pha kháng sinh*					
2	(1) **Meropenem** (Meronem*) 1g x 3 Lọ *Pha 1 lọ vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h 18h - 02h - 10h*					
3	**Glucose** (Glucose 10% [IVC]) 10% - 500ml x 1 Chai *Truyền tĩnh mạch 50ml/h*		16:03 (NT.Trang)			

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 17/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H004 | Phòng: Phòng hồi tỉnh P214 | Bác sĩ điều trị: Trần Việt Đức
Chẩn đoán: K81.0/ Viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(2) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg x 6 Lọ *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h*	10:00 (VTD.My)	18:00 (VTD.My)		02:00 18/10 (VTD.My)	
2	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml x 1 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch*	10:00 (VTD.My)				
3	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	10:00 (VTD.My)				
4	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml x 1 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	10:00 (VTD.My)				
5	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	10:00 (VTD.My)				
6	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml x 1 Ống *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4*				02:00 18/10 (VTD.My)	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 1 Chai *pha paracetamol*				02:00 → 02:20 (VTD.My) 18/10 - 18/10	

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
8	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml x 2 Chai *truyền tĩnh mạch*	10:00 → (VTD.My)		22:00 (VTD.My) 22:00 → (VTD.My)	10:00 (VTD.My) 18/10	
9	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml x 1 Ống *tiêm tĩnh mạch chậm 1/2 ống nếu tiểu < 100ml/3h*					Hoàn trả
10	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg x 1 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm*			20:00 (VTD.My)		
11	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml x 1 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*		16:00 (VT.Sao)			

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD Vương Thị Diệu My

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 18/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H038 | Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ) | Bác sĩ điều trị: Trần Xuân Bách

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(3) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg x 6 Lọ *pha truyền tĩnh mạch, SE 2 lọ trong 3h cách nhau 8h*	10:00 (LT.Linh)	18:00 (LT.Linh)		02:00 19/10 (LT.Linh)	
2	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml x 1 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch*	11:00 (LT.Linh)	→	→	11:00 (LT.Linh) 19/10	
3	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (LT.Linh)				
4	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml x 1 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (LT.Linh)	→	→	11:00 (LT.Linh) 19/10	
5	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (LT.Linh)				
6	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml x 1 Ống *truyền tĩnh mạch khi VAS >= 4*				03:03 19/10 (CT.Thủy)	
7	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 1 Chai *pha paracetamol*				03:03 → 04:00 (CT.Thủy) 19/10 - 19/10	

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
8	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml x 1 Chai *truyền tĩnh mạch*	11:00 → (LT.Linh)			11:00 (LT.Linh) 19/10	
9	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml x 2 Ống *tiêm tĩnh mạch chia 4*	10:00 (LT.Linh)	16:00 (LT.Linh)	22:00 (LT.Linh)	04:00 19/10 (LT.Linh)	
10	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg x 1 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm*			20:00 (LT.Linh)		
11	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml x 1 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*		16:00 (LT.Linh)			
12	**Acetylcystein** (Acetylcystein) 200mg x 3 Gói *Uống chia 3 cách 8h*	10:00 (LT.Linh)	16:00 (LT.Linh)	22:00 (LT.Linh)		

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Chu Thị Thủy

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 19/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Phan Tuấn Hiếu
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(4) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g x 1 Lọ *Truyền TM 30 G/P 24h* **Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 1 Chai				00:18 20/10 (ĐT.Thủy)	
2	**Furosemid** (Agifuros) 40mg x 1 Viên *Uống tối*		15:37 (BTH.Liên)			

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Đào Thu Thủy

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Trung tâm Gây mê hồi sức và Quản lý đau

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 19/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H038 | Phòng: Phòng hồi sức (GMHS&CĐ) | Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thanh Hiền

Chẩn đoán: K81.0/ Viêm phổi/Sau mổ cắt túi mật

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	**Glucose monohydrat 55g/250ml** (Glucose 20% [Kabi]) 20% x 500ml x 1 Chai nhựa PPKB *truyền tĩnh mạch*	11:00 (NTL.Chi)				
2	**Kali clorid** (Potassium Chloride Proamp[Kali clorid Pháp]) 10% 10ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (NTL.Chi)				
3	**Magnesi sulfat** (MAGNESI SULFAT KABI 15%) 15%/10ml x 1 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (NTL.Chi)				
4	**Calci clorid** (Calci clorid) 500mg/5ml x 2 Ống *pha truyền tĩnh mạch*	11:00 (NTL.Chi)				
5	**Natri clorid** (Natri clorid [Bitechphar]) 0,9% x 250ml x 1 Chai *pha paracetamol*					hoàn 1
6	**Ringer lactat** (Lactated Ringer's Injections) 500ml x 1 Chai *truyền tĩnh mạch*	11:46 (NTL.Chi)				
7	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml x 2 Ống *tiêm tĩnh mạch chia 4*	11:00 (NTL.Chi)				hoàn 1

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
8	**Pantoprazol** (Pantoloc IV [ĐB]) 40mg x 1 Lọ *tiêm tĩnh mạch chậm*					hoàn 1
9	**Enoxaparin Natri** (LOVENOX 40mg) 40mg/ 0,4ml x 1 Bơm tiêm *tiêm dưới da vào 16h chiều nay, báo BS trước tiêm*					hoàn 1
10	**Acetylcystein** (Acetylcystein) 200mg x 3 Gói *Uống chia 3 cách 8h*	10:00 (NTL.Chi)				hoàn 2
11	(4) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 1g x 1 Lọ *SE 1 lọ/3h*	10:00 (NTL.Chi)				

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Nguyễn Thị Linh Chi

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 20/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(5) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg x 6 Lọ *Pha truyền TM chia 3* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml x 3 Chai nhựa PPKB	08:00 (NT.Yến)	16:00 (NT.Yến)		00:00 21/10 (LTT.Hương)	
2	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml x 2 Ống *Tiêm TMC chia 2*	08:00 (NT.Yến)		20:54 (LTT.Hương)		
3	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml x 1 Ống *Pha truyền TM khi đau* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml x 1 Chai nhựa PPKB		17:54 (LTT.Hương)			
4	**Salbutamol sulfat** (Salbutamol Renaudin 5mg/5ml (0,1%) [Tiêm]) 5mg/5ml x 0 Ống *Khí dung chia 3*					

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Lê Như Cường

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 20/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	**Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat)** (Ozzy-40) 40mg x 1 Viên *Uống trước ăn 30 phút*	10:11 (NT.Yến)				
2	**Salbutamol** (Atisaltolin 5mg/2,5ml) 5mg/2,5ml x 1 Ống *Khí dung*	08:24 (NT.Yến)				

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐD. Nguyễn Thị Yến

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Khoa Ngoại tổng hợp

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

Mã hồ sơ 2610163961

PHIẾU SỬ DỤNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN

Ngày 21/10/2026

Người bệnh: LÊ DOÃN CẦN | Tuổi: 70 | Giới tính: Nam
Số giường: H018 | Phòng: Phòng 307 | Bác sĩ điều trị: Đỗ Đức Minh
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

STT	Y LỆNH	THỰC HIỆN Y LỆNH				Ghi chú
		Sáng	Chiều	Tối	Đêm	
1	(6) **Meropenem** (Meropenem/ Anfarm*) 500mg x 2 Lọ *Pha truyền TM chia 3* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml x 1 Chai nhựa PPKB	08:00 (NT.Yến)				
2	**Furosemid** (Vinzix) 20mg/2ml x 1 Ống *Tiêm TMC chia 2*	08:00 (NT.Yến)				
3	**Paracetamol** (A.T PARACETAMOL inj 1g/6,67ml (HT)) 1g/6,67ml x 1 Ống *Pha truyền TM khi đau* **Glucose khan, 5g/100ml** (Glucose 5% [Kabi]) 5% x 100ml x 1 Chai nhựa PPKB	09:14 (NT.Yến)				
4	**Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat)** (Ozzy-40) 40mg x 1 Viên *Uống trước ăn 30 phút*	06:13 (NT.Yến)				

NGƯỜI CẤP THUỐC KÝ TÊN

ĐDT. Nguyễn Thế Tuyền

Nhận xét quá trình dùng thuốc

- An toàn [X]
- Khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHIẾU KIỂM TRA NGƯỜI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng chuẩn bị người bệnh tích vào mục Trước khi chuyển đến khu mổ
Điều dưỡng nhận người bệnh tại khu mổ tích vào mục Đã kiểm tra

I. Thông tin người bệnh:

1. Họ và tên NB: LÊ DOÃN CẦN — Ngày sinh: 13/06/1956
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐ — Mã hồ sơ: 2610163961
3. Chẩn đoán trước phẫu thuật: Viêm túi mật cấp do sỏi
4. Phương pháp phẫu thuật (dự kiến): Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

II. Các chi tiết cần kiểm tra

☒ **PT cấp cứu** ☐ **PT có kế hoạch**

Dị ứng: ☒ Không ☐ Có **Dị nguyên:**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Trước khi chuyển đến khu mổ			*Bàn giao tại khu mổ*
Không	**Có**		**Đã kiểm tra**
		A. Nhận dạng người bệnh	
☐	☒	Bằng lời, khác:	☒
☐	☒	Vòng tay/ Thẻ nhận dạng	☒
		B. Hồ sơ bệnh án	
☐	☒	1. Dấu thông qua mổ (không áp dụng với PT cấp cứu)	☒
☐	☒	2. Biên bản hội chẩn phẫu thuật, chữ ký chủ tọa (chữ ký Lãnh đạo khoa hoặc BS cọc 1 nếu là PT cấp cứu	☒
☒	☐	3. Phiếu khám mê (nếu là PT cấp cứu chỉ cần ghi khám mê vào trong hồ sơ)	☒
☐	☒	4. Cam kết thực hiện phẫu thuật, gây mê hồi sức ☒ Chữ ký của người bệnh ☒ Chữ ký của người nhà	☒
		C. Bilan phẫu thuật	
☐	☒	1. Huyết học: ☒ CTM ☒ Nhóm máu ABO ☒ Rh	☒
☐	☒	2. Hóa sinh (Ure, Creatinin, Glucozơ, AST, ALT, Điện giải đồ)	☒
☐	☒	3. Đông máu cơ bản	☒
☒	☐	4. Bộ test miễn dịch: ☐ HBsAg ☐ HCV ☐ HIV	☒
☐	☒	5. Thăm dò chức năng, CĐHA: ☒ Điện tim thường ☐ Siêu âm tim ☐ Đo CNHH ☐ Khác ☒ XQ. Số lượng phim/ảnh: ☒ CT scan. Số lượng phim/ảnh: ☐ MRI. Số lượng phim/ảnh:	☒
☒	☐	6. Các chỉ định khác của bác sĩ gây mê:	
		D. Khác	
☒	☐	1. Dự trù máu. Số lượng:	☒
☐	☒	2. Nhịn ăn, uống hoàn toàn từ lúc: 19 giờ 00 phút Ngày 15 tháng 10 năm 2026	☒
☐	☒	3. Thuốc dùng trước phẫu thuật: Meronem x 1 g Thời gian: 18:00 16/10/2026	☒
☒	☐	4. Vệ sinh thân thể	☒
☐	☒	5. Đã tháo răng giả. Số lượng:	☒
☐	☒	6. Đã tháo đồ trang sức. Nếu không tháo được, ghi số lượng, màu sắc:	☒
☐	☒	7. ☒ Đã cởi quần áo lót; ☒ Thay quần áo hoặc váy mổ mới	☒
☒	☐	8. Xác nhận bác sĩ đã đánh dấu phẫu thuật	☒
☐	☒	9. Có người nhà người bệnh đi cùng	☒
☐	☒	10. Giờ chuyển phòng mổ: 20 giờ 46 phút Ngày 16 tháng 10 năm 2026	☒

Điều dưỡng chuẩn bị NB	**Điều dưỡng chuyển NB**	**Điều dưỡng phòng mổ**	**Điều dưỡng phòng hồi tỉnh**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
CNĐD Nguyễn Thị Trang	ĐD Vũ Thị Thúy Hoài	ĐD. Lê Thị Yến	ĐD. Lê Thị Yến

Ghi chú của phòng mổ/ phòng hồi tỉnh: thở oxy, lắp monitoring theo dõi. Tiếp tục dùng kháng sinh Meronem , chỉnhtheo MLCT. Theo dõi bilan nhiễm khuẩn 48h- Hội chẩn lại nội tim mạch dùng thuốc, chụp mạch vành cho bệnh nhân- Tiếp tục dùng thuốc xịt theo hội chẩn hô hấp, tập PHCN hô hấp

Điều dưỡng nhận NB về khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐD. Bùi Thị Hoài Liên

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên NB: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: **70** ☒ Nam ☐ Nữ

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TÉ NGÃ MORSE							
Thời điểm đánh giá			**Lúc nhận bệnh vào khoa**	**Sau phẫu thuật**	**Sau thủ thuật**	**Thay đổi tình trạng bệnh lý**	**Sau khi bị té ngã**
Tiền sử té ngã: vừa mới xảy ra hoặc trong 3 vòng tháng qua		Không Có	☒ 0 ☐ 25	☒ 0 ☐ 25	☐ 0 ☐ 25	☐ 0 ☐ 25	☐ 0 ☐ 25
Có bệnh lý đi kèm:tiểu đường, cao huyết áp... và đang dùng thuốc nhiều loại thuốc khác nhau		Không Có	☐ 0 ☒ 15	☐ 0 ☒ 15	☐ 0 ☐ 15	☐ 0 ☐ 15	☐ 0 ☐ 15
Đang được truyền dịch/catheter khóa heparin		Không Có	☐ 0 ☒ 20	☒ 0 ☐ 20	☐ 0 ☐ 20	☐ 0 ☐ 20	☐ 0 ☐ 20
Sử dụng hỗ trợ đi lại	Đi lại không cần hỗ trợ, nghỉ ngơi tại giường		☒ 0 ☐ 15 ☐ 30	☒ 0 ☐ 15 ☐ 30	☐ 0 ☐ 15 ☐ 30	☐ 0 ☐ 15 ☐ 30	☐ 0 ☐ 15 ☐ 30
	Xe lăn, nạng chống, nạng bốn chân, khung tập đi, ĐD hỗ trợ,...						
	Phải vịn vào bàn ghế, bờ tường xung quanh để đi lại						
Tư thế bất thường khi di chuyển	Bình thường		☒ 0 ☐ 10 ☐ 20	☒ 0 ☐ 10 ☐ 20	☐ 0 ☐ 10 ☐ 20	☐ 0 ☐ 10 ☐ 20	☐ 0 ☐ 10 ☐ 20
	Yếu/Nằm trên giường/Bất động						
	Không thăng bằng						
Tình trạng tinh thần	Định hướng được bản thân		☒ 0 ☐ 15	☒ 0 ☐ 15	☐ 0 ☐ 15	☐ 0 ☐ 15	☐ 0 ☐ 15
	Quên, lú lẫn						
Tổng điểm			35	15			
Nguy cơ thấp (0-24): Vòng đeo tay Màu trắng **Nguy trung bình** (25-44): Vòng đeo tay Màu vàng **Nguy cơ cao** (>= 45): Vòng đeo tay Màu đỏ			2 - Nguy trung bình	1 - Nguy cơ thấp			
Người đánh giá (Ghi tên)			ĐD Nguyễn Thị Kim Chi	ĐD. Bùi Thị Hoài Liên			

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG THEO DÕI DỊCH VÀO RA

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

Tên dịch vụ: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Chẩn đoán:

Cách thức PT:

Ngày theo dõi: 16/10/2026

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Giờ	Tổng dịch vào				Giờ	Tổng dịch ra				Ký nhận
	Dịch truyền TM	SL	Ăn uống	SL		Nước tiểu	Dẫn lưu	Hô hấp và da	Khác	
23:30	Dịch còn	200			...:...					huongnt1
00:30	RL + magie	510			03:00	100				huongnt1
...:...	Propofol	140			...:...					huongnt1
...:...	Nacl +Para	250			06:00	50				huongnt1
...:...	KS	50			...:...		5		DL Douglas	huongnt1
...:...					...:...		10		Sonde DD:	huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
...:...					...:...					huongnt1
Tổng	1150		0			150	15	0	0	khuonggmhs
Tổng dịch	1150					165				
Bilan	985									
Nhận xét	Bilan dương									

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG THEO DÕI DỊCH VÀO RA

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

Tên dịch vụ: Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [vết loét/vết thương phần mềm dài ≤ 15cm]

Chẩn đoán:

Cách thức PT:

Ngày theo dõi: 17/10/2026

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Giờ	Tổng dịch vào				Giờ	Tổng dịch ra				Ký nhận
	Dịch truyền TM	SL	Ăn uống	SL		Nước tiểu	Dẫn lưu	Hô hấp và da	Khác	
...:...	Dịch cũ	100			09:00	100				myvtd
10:00	G20% + ĐGĐ	550			12:00	100				myvtd
...:...	Meropenem	50			15:00	100				myvtd
...:...	Ringer	500			18:00	200				myvtd
...:...					21:00	150				myvtd
18:00	Meropenem	50			00:00	200				myvtd
...:...					03:00	100				myvtd
22:00	ringer	500			06:00	100	40		DL dưới gan	myvtd
02:00	Meropenem	50			...:...					myvtd
...:...					...:...					myvtd
...:...					...:...					myvtd
...:...	Thuốc khác	20			...:...					myvtd
...:...					...:...					myvtd
...:...					...:...					myvtd
Tổng	1820		0			1050	40	0	0	kiennt1
Tổng dịch	1820					1090				
Bilan	730									
Nhận xét	Bilan dương									

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG THEO DÕI DỊCH VÀO RA

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

Tên dịch vụ: Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [vết loét/vết thương phần mềm dài ≤ 15cm]

Chẩn đoán:

Cách thức PT:

Ngày theo dõi: 18/10/2026

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Giờ	Tổng dịch vào				Giờ	Tổng dịch ra				Ký nhận
	Dịch truyền TM	SL	Ăn uống	SL		Nước tiểu	Dẫn lưu	Hô hấp và da	Khác	
...:...	Dịch cũ	200			...:...					llinhgmhs
10:00	Meropenem 2g	50	10h: ACC+cháo	150	09:00	300			10h: 10mg Vinzix	llinhgmhs
11:00	Glucose 20% + ĐG	550			12:00	900				llinhgmhs
...:...	Ringer lactac	500	16h: ACC+ nước	200	15:00	400			16h: 10mg Vinzix	llinhgmhs
...:...			18h cháo	100	18:00	600				llinhgmhs
...:...			22h: ACC	80	21:00	400			22h: 10mg Vinzix	llinhgmhs
18:00	Meropenem 2g	50			00:00	200				llinhgmhs
...:...	nacl 0.9% pha para	250			03:00	600			04h: 10mg Vinzix	llinhgmhs
02:00	Meropenem 2g	50			06:00	300		50	DL dưới gan	llinhgmhs
...:...					...:...					llinhgmhs
...:...					...:...					llinhgmhs
...:...					...:...					llinhgmhs
...:...					...:...					llinhgmhs
...:...	Thuốc khác	30			...:...					llinhgmhs
Tổng	1680		530			3700	0	50	0	thuygmhs
Tổng dịch	2210					3750				
Bilan	-1540									
Nhận xét	Bilan âm									

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG THEO DÕI DỊCH VÀO RA

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính ☒ Nam ☐ Nữ

Tên dịch vụ: Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ [vết loét/vết thương phần mềm dài ≤ 15cm]

Chẩn đoán:

Cách thức PT:

Ngày theo dõi: 19/10/2026

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Giờ	Tổng dịch vào				Giờ	Tổng dịch ra				Ký nhận
	Dịch truyền TM	SL	Ăn uống	SL		Nước tiểu	Dẫn lưu	Hô hấp và da	Khác	
...:...	Dịch cũ				09:00	200				chibgmhs
...:...	glu+ đg	70			12:00	200			10mg vinzix	chibgmhs
...:...	meropenem	50	10h uống acc	30	15:00					chibgmhs
...:...	ringer lactat	100	ăn cháo	250	18:00					chibgmhs
...:...					21:00					chibgmhs
...:...					00:00					chibgmhs
...:...					03:00					chibgmhs
...:...					06:00					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
...:...					...:...					chibgmhs
Tổng	220		280			400	0	0	0	chibgmhs
Tổng dịch	500					400				
Bilan	100									
Nhận xét	Bilan dương									

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LOÉT TỲ ĐÈ - THANG ĐO BARDEN		ĐIỂM
Nhận biết cảm giác		
1. Giới hạn hoàn toàn (Không đáp ứng với kích thích đau)	☐	4
2. Rất giới hạn (chỉ đáp ứng với kích thích đau)	☐	
3. Giới hạn nhẹ (đáp ứng bằng lời nói, giảm khả năng nhận biết đau ở 1 trong 2 chi)	☐	
4. Không suy giảm	☒	
Tình trạng da (mức độ da ẩm ướt)		
1. Luôn luôn ẩm ướt	☐	4
2. Thường xuyên ẩm ướt	☐	
3. Thỉnh thoảng ẩm ướt	☐	
4. Hiếm khi ẩm ướt	☒	
Hoạt động (mức độ di chuyển/ vận động)		
1. Nằm liệt giường	☒	1
2. Đi bằng xe lăn	☐	
3. Đi lại ít	☐	
4. Đi lại thường xuyên	☐	
Vận động (mức độ thay đổi tư thế và vận động)		
1. Hoàn thành bất động (Không thể thay đổi tư thế dù nhỏ khi không được giúp đỡ)	☐	3
2. Rất giới hạn (Thỉnh thoảng thay đổi nhỏ tư thế hay vị trí chi)	☐	
3. Giới hạn nhẹ (Thường xuyên thay đổi nhỏ tư thế hay vị trí chi)	☒	
4. Không giới hạn (Thường xuyên thay đổi tư thế mà không cần giúp đỡ)	☐	
Dinh dưỡng		
1. Kém (Không ăn được 1 bữa đầy đủ, ăn ít hơn 1/3 thức ăn, cần bổ sung thêm dịch, ăn đường ống, truyền dịch/ truyền tĩnh mạch khoảng 5 ngày /lần	☒	1
2. Trung bình (Hiếm khi ăn được 1 bữa đầy đủ, ăn ít hơn 1/2 thức ăn, thỉnh thoảng cần thêm bữa phụ hoặc ăn bằng ống	☐	
3. Khá (ăn hết hơn 1/2 thức ăn, thỉnh thoảng bỏ 1 bữa nhưng có thể ăn thêm bữa ngoài	☐	
4. Tốt (ăn gần hết thức ăn, không bao giờ bỏ bữa, có thể ăn thêm bữa ngoài)	☐	
Ma sát và dịch chuyển		
1. Có vấn đề (Cần giúp đỡ tối đa khi di chuyển, thường xuyên bị trượt xuống, tình trạng liệt hay co cứng)	☐	2
2. Vấn đề tiềm tàng (di chuyển yếu hay cần giúp đỡ, duy trì tư thế tốt một cách tương đối nhưng đôi khi trượt xuống)	☒	
3. Không có vấn đề gì (di chuyển không cần giúp đỡ, luôn luôn duy trì tư thế tốt nhất trên giường hay ghế)	☐	
Thời gian đánh giá: 08 giờ 00 phút Ngày 17 tháng 10 năm 2026	Tổng cộng:	15
A. 19-23: Không có nguy cơ B. 15-18: Nguy cơ thấp C. 13-14: Nguy cơ trung bình D. 10-12: Nguy cơ cao E. ≤ 9: Nguy cơ rất cao	**ĐD. Trần Thị Cúc**	B
Hướng dẫn: Điều dưỡng đánh giá nguy cơ ngã và nguy cơ loét tỳ đè của bệnh nhân bắt đầu khi bệnh nhân vào khoa Sau khi đánh giá cần sử dụng vòng đeo tay và chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh nhân		

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LOÉT TỲ ĐÈ - THANG ĐO BARDEN		ĐIỂM
Nhận biết cảm giác		
1. Giới hạn hoàn toàn (Không đáp ứng với kích thích đau)	☐	4
2. Rất giới hạn (chỉ đáp ứng với kích thích đau)	☐	
3. Giới hạn nhẹ (đáp ứng bằng lời nói, giảm khả năng nhận biết đau ở 1 trong 2 chi)	☐	
4. Không suy giảm	☒	
Tình trạng da (mức độ da ẩm ướt)		
1. Luôn luôn ẩm ướt	☐	3
2. Thường xuyên ẩm ướt	☐	
3. Thỉnh thoảng ẩm ướt	☒	
4. Hiếm khi ẩm ướt	☐	
Hoạt động (mức độ di chuyển/ vận động)		
1. Nằm liệt giường	☒	1
2. Đi bằng xe lăn	☐	
3. Đi lại ít	☐	
4. Đi lại thường xuyên	☐	
Vận động (mức độ thay đổi tư thế và vận động)		
1. Hoàn thành bất động (Không thể thay đổi tư thế dù nhỏ khi không được giúp đỡ)	☐	4
2. Rất giới hạn (Thỉnh thoảng thay đổi nhỏ tư thế hay vị trí chi)	☐	
3. Giới hạn nhẹ (Thường xuyên thay đổi nhỏ tư thế hay vị trí chi)	☐	
4. Không giới hạn (Thường xuyên thay đổi tư thế mà không cần giúp đỡ)	☒	
Dinh dưỡng		
1. Kém (Không ăn được 1 bữa đầy đủ, ăn ít hơn 1/3 thức ăn, cần bổ sung thêm dịch, ăn đường ống, truyền dịch/ truyền tĩnh mạch khoảng 5 ngày /lần	☐	2
2. Trung bình (Hiếm khi ăn được 1 bữa đầy đủ, ăn ít hơn 1/2 thức ăn, thỉnh thoảng cần thêm bữa phụ hoặc ăn bằng ống	☒	
3. Khá (ăn hết hơn 1/2 thức ăn, thỉnh thoảng bỏ 1 bữa nhưng có thể ăn thêm bữa ngoài	☐	
4. Tốt (ăn gần hết thức ăn, không bao giờ bỏ bữa, có thể ăn thêm bữa ngoài)	☐	
Ma sát và dịch chuyển		
1. Có vấn đề (Cần giúp đỡ tối đa khi di chuyển, thường xuyên bị trượt xuống, tình trạng liệt hay co cứng)	☐	2
2. Vấn đề tiềm tàng (di chuyển yếu hay cần giúp đỡ, duy trì tư thế tốt một cách tương đối nhưng đôi khi trượt xuống)	☒	
3. Không có vấn đề gì (di chuyển không cần giúp đỡ, luôn luôn duy trì tư thế tốt nhất trên giường hay ghế)	☐	
Thời gian đánh giá: 07 giờ 30 phút Ngày 18 tháng 10 năm 2026	Tổng cộng:	16
A. 19-23: Không có nguy cơ B. 15-18: Nguy cơ thấp C. 13-14: Nguy cơ trung bình D. 10-12: Nguy cơ cao E. ≤ 9: Nguy cơ rất cao	ĐD. Lê Thùy Linh	B
Hướng dẫn: Điều dưỡng đánh giá nguy cơ ngã và nguy cơ loét tỳ đè của bệnh nhân bắt đầu khi bệnh nhân vào khoa Sau khi đánh giá cần sử dụng vòng đeo tay và chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh nhân		

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG CẤP CỨU

Mã hồ sơ: 2610163961
Ngày: 16/10/2026
Ngày điều trị thứ: 1

Họ và tên bệnh nhân: **LÊ DOÃN CÀN** Giường/ Cáng:
Giới: Nam ☒ Nữ ☐ Tuổi: 70
Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thành Trung
Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

Mode thở			
VT/FiO2/R/PEEP	/ / /	/ / /	/ / /

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Bệnh sử	**Giờ**	08:00	15:14	17:23	20:46	...:...	...:...	**THUỐC VÀ DỊCH TRUYỀN**	
	Mạch	98	104	91	90			1. Natriclorua 0,9% 500ml X chai	
	Nhiệt độ	36.9	36.6	36.1	38.3			2. Glucose % X chai	
	HA	152 / 86	146 / 86	132 / 88	135 / 84	/	/	3. Ringerlactac 500ml X chai	
	Glasgow	16	15	15	15				
	Sp02	95	93	96	97				
	Nhịp thở	16	25	18	18				
	Thở oxy	L/p	L/p	L/p	L/p	L/p	L/p		
	News 2 core								
	ĐMMM								
	INR								
Thực hiện thuốc									
Thủ thuật/ Chăm sóc								A. Phụ chọc dịch MP	B. Bó bột C. F2 nẹp CS cổ
Dinh dưỡng								D. Vệ sinh răng miệng	E. Thở oxy mask
Nước tiểu								G. Phụ Đặt ống NKQ	H. Tư thế fowler
Khác								K. Phụ chọc dịch não tủy	L. Đặt sonde Dạ dày
Nhận xét/Đánh giá sau khi thực hiện y lệnh		tiếp nhận NB vào khoa	TD tiếp	bn tạm nhịn ăn chờ mổ cc	chuyển mổ cc			M. Thay đổi tư thế U. Tiểu phẫu thuật	I. Đặt sonde Tiểu N. Thay băng /cắt chỉ
								F. Phụ đặt catheter TMTT Y. Chăm sóc NKQ/MKQ Z. Gội đầu	X. Cấp cứu ngừng tuần hoàn W. Khí dung T. Hút đờm rãi
Điều dưỡng ký tên ghi họ tên		chintk	nttrang	thuyhoai	thuyhoai				

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH HSTC CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính:Nam Số giường: H053

Bác sĩ điều trị: Ngày: .../.../... Ngày điều trị thứ: Cân nặng lúc vào: Cao:

Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi

Cân nặng hiện tại (kg): Ngày cân: .../.../...

GIỜ			23:30	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00			
HUYẾT ÁP	MẠCH	NHIỆT ĐỘ	16/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10			
180	180	42												
160	160	41												
140	140	40												
120	120	39												
100	100	38												
80	80	37												
60	60	36												
40	40	35												

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

	Nhiệt độ	37.5	37.7			37			36.8				
	Mạch	98	96	96	95	94	94	95	95	94			
	Huyết áp	100/60	110/65	115/70	115/70	110/65	120/70	115/68	105/60	110/62			
	Ghi chú								6h rút NKQ				
	SPO2	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	NHỊP THỞ												
	GLASSGOW												
THỞ MÁY	MODE	SIMV VC	SIMV VC	SIMV VC	SIMV VC	SIMV VC	SIMV VC	SIMV VC	TT	TT			
	TV	470	450	425	425	450	450	425					
	TẦN SỐ	14	14	16	16	16	16	16					
	I/E - I TIME - PEAK LOW	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
	FIO2 (%)	40	40	40	40	40	40	40	30	30			
	PEEP/CPAP/EPAP	5	5	5	5	5	5	5					
	PS/IPAP												
THỞ OXY	Gọng kính(1/p)												
	Mask(1/p)												
	Mask túi(1/p)												
DỊCH	**DỊCH VÀO** Dịch, thuốc												
	Ăn												
	Khác												
	Tổng cũ: Tổng												
	DỊCH RA Tiểu												
	Khác												
	Ghi chú												
	Tổng cũ: Tổng												
	DỊCH VÀO - DỊCH RA												
ĐỜM	Màu (Xanh - Trắng - Đục - Máu)		Trắng			Trắng			Trắng				
	Số lượng		Ít			Vừa			Ít				
PHÂN	Số lần												
	Màu												
	Tính chất												
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG	Dịch tồn dư dạ dày												
	Đường máu mao mạch……giờ/lần		x			x			x				
	Hút đờm												
	Tư thế	Ngửa		Ngửa			Ngửa			Ngửa			
	Tắm												
	Gội đầu							x					
	Thay băng							x					
	Vệ sinh răng miệng - mũi												
	Vị trí NKQ (cm)												
	Số ngày đặt NKQ / MKQ												
	Áp lực cuff												
Tên ĐD	Ca1:	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn	ĐD Nguyễn Thị Hươn
	Ca2:												
	Ca3:												

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH HSTC CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:

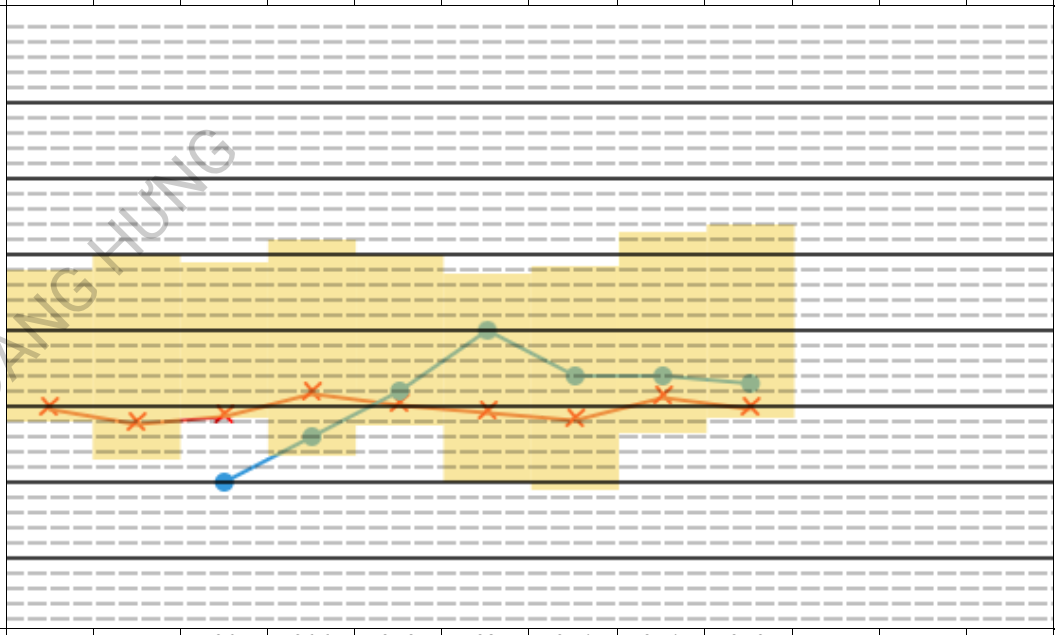
NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính:Nam Số giường: H053

Bác sĩ điều trị: Ngày: 17/10/2026 Ngày điều trị thứ: 2 Cân nặng lúc vào: Cao:

Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi Cân nặng hiện tại (kg): Ngày cân: .../.../...

GIỜ			07:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	00:00	03:00	06:00			
HUYẾT ÁP	MẠCH	NHIỆT ĐỘ	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	17/10	18/10	18/10	18/10			
180	180	42												
160	160	41												
140	140	40												
120	120	39												
100	100	38												
80	80	37												
60	60	36												
40	40	35												



	Nhiệt độ				36	36.6	37.2	38	37.4	37.4	37.3		
	Mạch		80	76	78	84	81	79	77	83	80		
	Huyết áp		116/76	120/66	118/77	124/67	120/75	115/60	117/58	126/73	128/77		
	Ghi chú												
	SPO2		100		100	100	100	100	100	100	100		
	NHỊP THỞ		16		16	17		19		18			
	GLASSGOW												
THỞ MÁY	MODE		TT	TT	NIV	TT	NIV	TT	NIV	TT	NIV		
	TV												
	TẦN SỐ												
	I/E - I TIME - PEAK LOW												
	FIO2 (%)				40	30	40	30	40	21	40		
	PEEP/CPAP/EPAP				5		5		5		5		
	PS/IPAP				10		10		10		10		
THỞ OXY	Gọng kính(1/p)												
	Mask(1/p)		4	3	3	5		5					
	Mask túi(1/p)												
DỊCH	**DỊCH VÀO**	Dịch, thuốc											
		Ăn											
		Khác											
		Tổng cũ: **Tổng**											
	DỊCH RA	Tiêu											
		Khác											
		Ghi chú											
		Tổng cũ: **Tổng**											
	DỊCH VÀO - DỊCH RA												
ĐỜM	Màu (Xanh - Trắng - Đục - Máu)												
	Số lượng												
PHÂN	Số lần												
	Màu												
	Tính chất												
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG	Dịch tồn dư dạ dày												
	Đường máu mao mạch……giờ/lần												
	Hút đờm				Ngửa	Ngửa	Ngửa	Ngửa	Ngửa	Ngửa	Ngửa		
	Tư thế												
	Tắm												
	Gội đầu										x		
	Thay băng										x		
	Vệ sinh răng miệng - mũi												
	Vị trí NKQ (cm)												
	Số ngày đặt NKQ / MKQ												
	Áp lực cuff												
Tên ĐD	Ca1:		ĐD. Nguyễn Mạnh Cường	ĐD. Nguyễn Mạnh Cường	Nguyễn Thị Hằng Nhung	Nguyễn Thị Hằng Nhung	Nguyễn Thị Hằng Nhung	Nguyễn Thị Hằng Nhung	Nguyễn Thị Hằng Nhung	Nguyễn Thị Hằng Nhung	ĐD. Nguyễn Trung Kiên	ĐD Vương Thị Diệu My	ĐD Vương Thị Diệu My	ĐD Vương Thị Diệu My
	Ca2:													
	Ca3:													

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH HSTC CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:

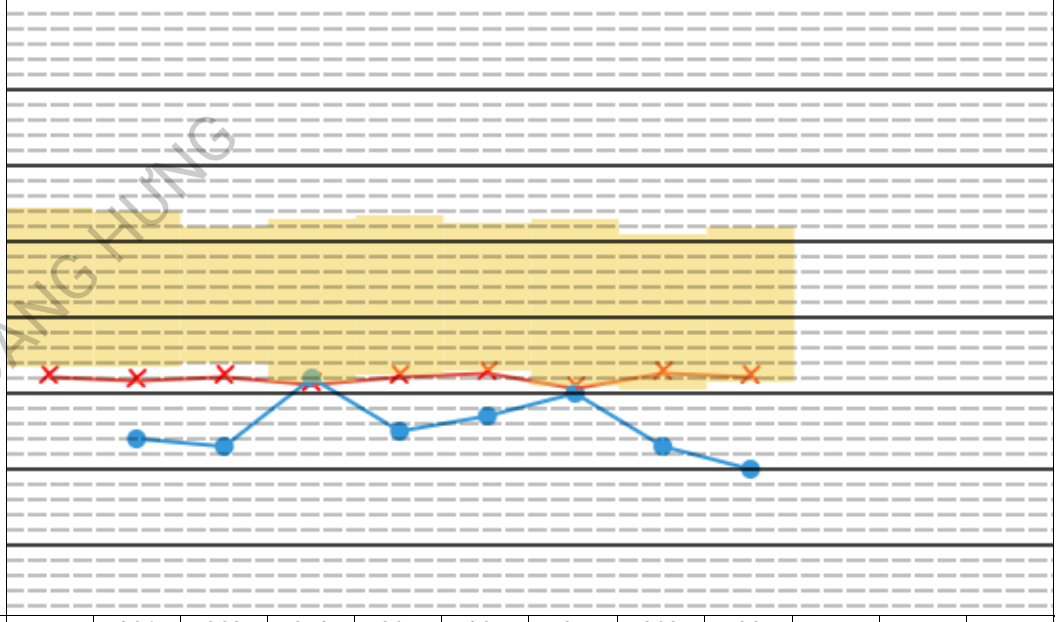
NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính:Nam Số giường: H053

Bác sĩ điều trị: Ngày: 19/10/2026 Ngày điều trị thứ: 4 Cân nặng lúc vào: Cao:

Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi Cân nặng hiện tại (kg): Ngày cân: .../.../...

GIỜ			07:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	00:00	03:00	06:00			
HUYẾT ÁP	MẠCH	NHIỆT ĐỘ	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	19/10	19/10	19/10			
180	180	42												
160	160	41												
140	140	40												
120	120	39												
100	100	38												
80	80	37												
60	60	36												
40	40	35												



	Nhiệt độ			36.4	36.3	37.2	36.5	36.7	37	36.3	36			
	Mạch		85	84	85	83	85	86	82	86	85			
	Huyết áp		129/87	128/87	124/88	126/83	127/85	125/86	126/82	122/81	124/83			
	Ghi chú													
	SPO2		96	95	96	95	96	97	96	95	96			
	NHỊP THỞ		20	19	21	20	18	21	19	18	20			
	GLASSGOW													
THỞ MÁY	MODE		TT	TT	TT	NIV	TT	TT	TT	TT	NIV			
	TV													
	TẦN SỐ													
	I/E - I TIME - PEAK LOW													
	FIO2 (%)					35					35			
	PEEP/CPAP/EPAP					5					5			
	PS/IPAP					8					8			
THỞ OXY	Gọng kính(1/p)													
	Mask(1/p)													
	Mask túi(1/p)													
DỊCH	**DỊCH VÀO**	Dịch, thuốc												
		Ăn												
		Khác												
		Tổng cũ: **Tổng**												
	DỊCH RA	Tiêu												
		Khác												
		Ghi chú												
		Tổng cũ: **Tổng**												
	DỊCH VÀO - DỊCH RA													
ĐỜM	Màu (Xanh - Trắng - Đục - Máu)													
	Số lượng													
PHÂN	Số lần													
	Màu													
	Tính chất													
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG	Dịch tồn dư dạ dày													
	Đường máu mao mạch……giờ/lần													
	Hút đờm			Ngửa		Trái		Phải	Ngửa	Ngửa	Ngồi dậy			
	Tư thế													
	Tắm													
	Gội đầu										x			
	Thay băng										x			
	Vệ sinh răng miệng - mũi													
	Vị trí NKQ (cm)													
	Số ngày đặt NKQ / MKQ													
	Áp lực cuff													
Tên ĐD	Ca1:		ĐD. Lê Thùy Linh	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Chu Thị Thùy	ĐD. Lê Thùy Linh	ĐD. Lê Thùy Linh	ĐD. Lê Thùy Linh
	Ca2:													
	Ca3:													

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BẢNG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH HSTC CỦA ĐIỀU DƯỠNG

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Họ và tên: **LÊ DOÃN CẦN** Tuổi: 70 Giới tính:Nam Số giường: H053

Bác sĩ điều trị: Ngày: 19/10/2026 Ngày điều trị thứ: 4 Cân nặng lúc vào: Cao:

Chẩn đoán: K81.0/ Giãn phế quản bội nhiễm cấp - Suy tim EF 36% / sau mổ viêm túi mật cấp do sỏi Cân nặng hiện tại (kg): Ngày cân: .../.../...

GIỜ			07:00	09:00	12:00	12:30	12:50							
HUYẾT ÁP	MẠCH	NHIỆT ĐỘ	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10							
180	180	42												
160	160	41												
140	140	40												
120	120	39												
100	100	38												
80	80	37												
60	60	36												
40	40	35												
	Nhiệt độ			36.3	36.5									
	Mạch		88	85	83	80	83							
	Huyết áp		130/80	128/78	125/76	131/82	127/80							
	Ghi chú													
	SPO2		98	99	97	99	98							
	NHỊP THỞ		20	19	21	20	20							
	GLASSGOW													
THỞ MÁY	MODE		TT	TT	TT	TT	TT							
	TV													
	TẦN SỐ													
	I/E - I TIME - PEAK LOW													
	FIO2 (%)		21	21	21	21	21							
	PEEP/CPAP/EPAP													
	PS/IPAP													
THỞ OXY	Gọng kính(1/p)													
	Mask(1/p)													
	Mask túi(1/p)													
DỊCH	**DỊCH VÀO**	Dịch, thuốc												
		Ăn												
		Khác												
		Tổng cũ: **Tổng**												
	DỊCH RA	Tiêu												
		Khác												
		Ghi chú												
		Tổng cũ: **Tổng**												
	DỊCH VÀO - DỊCH RA													
ĐỜM	Màu (Xanh - Trắng - Đục - Máu)													
	Số lượng													
PHÂN	Số lần													
	Màu													
	Tính chất													
CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG	Dịch tồn dư dạ dày													
	Đường máu mao mạch……giờ/lần													
	Hút đờm			Ngửa	Ngửa	Ngửa								
	Tư thế													
	Tắm													
	Gội đầu													
	Thay băng													
	Vệ sinh răng miệng - mũi													
	Vị trí NKQ (cm)													
	Số ngày đặt NKQ / MKQ													
	Áp lực cuff													
Tên ĐD	Ca1:		Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi	Chi
	Ca2:		DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi	DD. Nguyễn Thị Linh Chi
	Ca3:													

NGUYỄN ĐẶNG HƯNG

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG KHÁNG SINH CẦN ƯU TIÊN QUẢN LÝ

I.Nội dung tại khoa lâm sàng Ngày / tháng / năm: 16/10/2026

Họ tên người bệnh: LÊ DOÃN CẦN Mã hồ sơ: 2610163961

Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Tuổi: 70 Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ Cân nặng (kg): 66 Dị ứng: Chưa phát hiện

Chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn:

VP cộng đồng ☒ VP bệnh viện ☐ VP thở máy ☐ Shock NK ☐ NK huyết ☐ Viêm màng não/ Các NK TKTƯ ☐

NK tiết niệu ☐ NK ổ bụng ☒ NK da, mô mềm ☐ NK khác: ☐

Bệnh khác mắc kèm:

Tính trạng lâm sàng khi hội chẩn: Bệnh nhân tỉnh, mệt Nhiệt độ (độ C): 36.9
Hiện không sốt
Tự thở khí phòng SpO2 93%
RRPN giảm, rales nổ rải rác vùng đáy phổi 2 bên
Tim đều M: 99 ck/phút
HA: 142/70mmHg
Bụng chướng, điểm đau McBurney (+)
PUTB (+)

Kết quả cận lâm sàng gần nhất Bạch cầu: 16.56 CRP: 9.48 PCT:

Khác (dịch não tủy, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh ...):

Thanh thải creatinin (ml/ph) Lọc máu HD (24/48/72 giờ) Có ☐ Không ☒
97.5 Lọc máu liên tục Có ☐ Không ☒

Xét nghiệm vi sinh: (không làm ghi rõ lý do)

Bệnh phẩm	Ngày cấy	Ngày trả	Kết quả vi khuẩn/nấm, kháng sinh đồ
	.../...	.../...	
	.../...	.../...	
	.../...	.../...	

Phác đồ KS đang điều trị (ngày điều trị)	**Lý do dùng phác đồ KSƯTQL**
	☐ Không/kém đáp ứng với phác đồ ban đầu ☐ KQ vi sinh, vi khuẩn kháng/đa kháng thuốc ☐ Đang/ đã từng gặp ADR với kháng sinh ☒ Khác

Phác đồ kháng sinh yêu cầu

Kháng sinh	Liều dùng/1 lần (Liều nạp nếu có)	Khoảng cách dùng	Cách dùng	Thời gian điều trị (ngày)
Meropenem	1g	8h	Pha vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Bác sĩ điều trị[1] (Ký, ghi rõ họ tên) BS Nguyễn Thành Trung	**Lãnh đạo khoa lâm sàng**[2] (Ký, ghi rõ họ tên)
II. Ý kiến của ban QLSDKS	Ngày...tháng...năm...
Thống nhất sử dụng ý kiến trên	Có ☒ Không ☐
Ý kiến khác:	
	Người được ban QLSDKS phân công[3] (Ký và ghi rõ họ tên) **DS. Vũ Hồng Khánh**

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

PHIẾU YÊU CẦU SỬ DỤNG KHÁNG SINH CẦN ƯU TIÊN QUẢN LÝ

I.Nội dung tại khoa lâm sàng Ngày / tháng / năm: 16/10/2026

Họ tên người bệnh: LÊ DOÃN CẦN Mã hồ sơ: 2610163961

Khoa: Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực

Tuổi: 70 Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ Cân nặng (kg): 66 Dị ứng: Chưa phát hiện

Chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn:

VP cộng đồng ☒ VP bệnh viện ☐ VP thở máy ☐ Shock NK ☐ NK huyết ☐ Viêm màng não/ Các NK TKTƯ ☐

NK tiết niệu ☐ NK ổ bụng ☒ NK da, mô mềm ☐ NK khác: ☐

Bệnh khác mắc kèm:

Tính trạng lâm sàng khi hội chẩn: Bệnh nhân tỉnh, mệt Nhiệt độ (độ C): 36.9
Hiện không sốt
Tự thở khí phòng SpO2 93%
RRPN giảm, rales nổ rải rác vùng đáy phổi 2 bên
Tim đều M: 99 ck/phút
HA: 142/70mmHg
Bụng chướng, điểm đau McBurney (+)
PUTB (+)

Kết quả cận lâm sàng gần nhất Bạch cầu: 16.56 CRP: 9.48 PCT:

Khác (dịch não tủy, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh ...):

Thanh thải creatinin (ml/ph) Lọc máu HD (24/48/72 giờ) Có ☐ Không ☒
97.5 Lọc máu liên tục Có ☐ Không ☒

Xét nghiệm vi sinh: (không làm ghi rõ lý do)

Bệnh phẩm	Ngày cấy	Ngày trả	Kết quả vi khuẩn/nấm, kháng sinh đồ
	.../...	.../...	
	.../...	.../...	
	.../...	.../...	

Phác đồ KS đang điều trị (ngày điều trị)	**Lý do dùng phác đồ KSƯTQL**
	☐ Không/kém đáp ứng với phác đồ ban đầu
	☐ KQ vi sinh, vi khuẩn kháng/đa kháng thuốc
	☐ Đang/ đã từng gặp ADR với kháng sinh
	☒ Khác

Phác đồ kháng sinh yêu cầu

Kháng sinh	Liều dùng/1 lần (Liều nạp nếu có)	Khoảng cách dùng	Cách dùng	Thời gian điều trị (ngày)
Meropenem	1g	8h	Pha vào 100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch 33ml/h	

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Bác sĩ điều trị[1] (Ký, ghi rõ họ tên) BS Nguyễn Thành Trung	**Lãnh đạo khoa lâm sàng**[2] (Ký, ghi rõ họ tên) BSNT Ngô Đức Hùng
II. Ý kiến của ban QLSDKS	Ngày...tháng...năm...
Thống nhất sử dụng ý kiến trên	Có ☐ Không ☐
Ý kiến khác:	
	Người được ban QLSDKS phân công[3] (Ký và ghi rõ họ tên) DS. Vũ Hồng Khanh

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHIẾU GHI THANH TOÁN TIỀN PHẪU THUẬT

Phòng mổ (tua trực):

Họ và tên: LÊ DOÃN CẦN **Mã HS:** 2610163961 **Tuổi:** 70 **Mã số VP:** .....

Ngày, tháng, năm mổ: 21:30 16/10/2026 **Thời gian mổ: từ** 21:30 16/10/2026 **đến** 23:25 16/10/2026

Chẩn đoán trước khi mổ: Viêm túi mật cấp do sỏi

Phương pháp phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng

.....

.....

Mã phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

Loại phẫu thuật: I

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Chức danh	Họ và tên	Mã số	Ghi chú
Phẫu thuật viên chính 1	Nguyễn Đăng Hưng	350928	
Phụ 1	Đỗ Đức Minh	352725	
Phụ 2	Phùng Văn Thức	HV232409	
Bác sỹ gây mê 1	Trần Việt Đức	190939	
Bác sỹ gây mê 2			
Y tá phụ mê 1	Lê Thị Yến	190355	
Y tá phụ mê 2			
Y tá dụng cụ	Ngô Kim Bằng	193014	
Y tá chạy ngoài	Lương Thị Hiền	190348	
Chạy máy			
Phụ chạy máy			
Tổng số người tham gia phẫu thuật	**7**		

PHẪU THUẬT VIÊN CHÍNH(1)
(Ký và ghi rõ họ tên)

BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng

BÁC SĨ GÂY MÊ(2)
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. BS. Trần Việt Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã HS: 2610163961
Mã NB: 2610036327

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẪU THUẬT

1. Họ và tên Người bệnh: **LÊ DOÃN CẦN**
2. Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Việt Nam
3. Vào viện: 16/10/2026
4. Ngày mổ: 16/10/2026
5. Chẩn đoán: Viêm túi mật hoại tử
6. Phương pháp phẫu thuật: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật , hút rửa, DL ổ bụng
7. Phẫu thuật viên: Nguyễn Đăng Hưng
8. Bác sĩ gây mê: Trần Việt Đức
9. Phương pháp vô cảm: Mê nội khí quản
10. Hậu phẫu: Ổn định
11. Kết quả GPB: lấy khi khám lại

Lưu ý: Người bệnh mang theo giấy này khi khám bệnh.

Ngày 21 tháng 10 năm 2026

BÁC SĨ PHẪU THUẬT(1)

Ths. BSNT. Đỗ Đức Minh

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

KHÁM LẠI

Ngày	Kết quả	Bác sĩ

1. Tình trạng người bệnh khi xuất viện:

*Bệnh nhân khỏi cho về nhà ☒ Chuyển viện ☐ Khác:

Nặng xin về ☐ Bệnh nhân tử vong ☐

***Tình trạng bệnh nhân:**

Tỉnh táo ☒ Mê ☐ Lơ mơ ☐ Khác:

Còn sonde dạ dày ☐ Còn ống mở NKQ ☐

Đã cắt chỉ ☐ Chưa cắt chỉ ☒ Chỉ tự tiêu ☐

* Vận chuyển: Tự đi lại ☒ BN ngồi xe đẩy ☐ BN nằm cáng ☐

BN cần oxy mang theo ☐ BN có người dắt ☐

*Phương tiện về: Xe cứu thương ☐ Xe riêng ☒ Khác:

2. Hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết:

*** Hướng dẫn về vệ sinh và chăm sóc vết thương:**

Vệ sinh thân thể bằng nước và xà phòng ☐

Tránh nước vào vết thương ☒ Thay băng vết mổ ☒

Khác: Hướng dẫn thay băng cắt chỉ tại cơ sở y tế địa phương

*** Hướng dẫn về ăn uống:**

Ăn uống bình thường ☒ Hạn chế muối ☐ Hạn chế mỡ ☒

Ăn lỏng, dễ tiêu ☐ Không sử dụng các chất kích thích ☒

Khác:

*** Hướng dẫn về vận động:**

Vận động nhẹ nhàng ☒ Tập PHCN ☐ Không mang vác nặng ☒

Khác:

*** Hướng dẫn sử dụng thuốc và khám lại:**

Uống thuốc theo đơn ☒ Khám lại theo hẹn ☒

Khác:

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

DANH MỤC BÀN GIAO BỆNH NHÂN KHI RA VIỆN

STT	Nội dung	Có	Không
1	Giấy ra viện:	☒	☐
2	Đơn thuốc:	☒	☐
3	Phiếu phẫu thuật:	☒	☐
4	Thẻ BHYT:	☐	☒
5	Giấy hẹn khám lại	☐	☒
6	Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH:	☒	☐
7	Giấy chuyển tuyến, chuyển viện:	☐	☒
8	Photo xét nghiệm:	☐	☒
9	Phim XQ: Phim CT: Phim MRI:	☐	☒
10	Khác:	☐	☒

Ký nhận(2)

(Ghi rõ họ tên và mối quan hệ)

Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA(3)

ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC(1)

ĐD. Nguyễn Thị Yến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH

Đề nghị Ông (Bà) cung cấp thông tin của bệnh nhân
Họ và tên BN (VIẾT IN HOA): **LÊ DOÃN CẦN**

☒ Tự đến ☐ Chuyển từ bệnh viện khác đến

*Hiện tại có mang theo các loại giấy tờ sau không:

- Thẻ BHYT	☒ Có	☐ Không
- Thẻ bảo hiểm PVI	☐ Có	☒ Không
- Thẻ bảo hiểm Bảo Việt	☐ Có	☒ Không
- Giấy chuyển viện:	☐ Có	☒ Không
- Giấy chuyển tuyến huyện	☐ Có	☒ Không
- Giấy chuyển tuyến tỉnh	☐ Có	☒ Không
- CMTNND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh:	☒ Có	☐ Không
- Tài liệu tuyến trước:		

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

20 giờ 50 phút Ngày 16 tháng 10 năm 2026

NHÂN VIÊN XÁC NHẬN THÔNG TIN(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐD. Đàm Thị Hương Lan

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN(1)
(LÀ CỦA BỆNH NHÂN)
(Ký, ghi rõ họ tên)



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM CĐHA & CTĐQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHAI THÁC TIỀN SỬ DỊ ỨNG CỦA NGƯỜI BỆNH

STT	Nội dung	Tên thuốc, dị nguyên gây dị ứng	Không/Có: Số lần	Biểu hiện lâm sàng- xử trí
1	NB đã từng tiêm thuốc cản quang hay chưa?		☐ Không ☒ Có Số lần	
2	Nếu đã từng tiêm thuốc cản quang, có bị dị ứng với thuốc đó không?		☒ Không ☐ Có Số lần	
3	Loại thuốc hoặc dị nguyên nào đã gây dị ứng?		☒ Không ☐ Có Số lần	
4	NB dị ứng với loại côn trùng nào?		☒ Không ☐ Có Số lần	
5	NB dị ứng với loại thực phẩm nào?		☒ Không ☐ Có Số lần	
6	NB dị ứng với các tác nhân khác: Phấn hoa, bụi nhà, hóa chất, mỹ phẩm...?		☒ Không ☐ Có Số lần	
7	Tiền sử cá nhân có bệnh dị ứng nào (viêm mũi dị ứng, hen phế quản...)?		☒ Không ☐ Có Số lần	
8	Tiền sử gia đình có bệnh dị ứng nào (Bố mẹ, con, anh chị em ruột có ai bị các bệnh dị ứng trên không)?		☒ Không ☐ Có Số lần	
9	NB có bị bệnh lý gì về thận, tim, gan hay không?		☒ Không ☐ Có Số lần	
10	NB có bị bệnh lý gì mãn tính khác hay không (tiểu đường, cao huyết áp, basedow)?		☒ Không ☐ Có Số lần	
11	NB đã ăn gì trước khi chụp chưa?		☒ Không ☐ Có Số lần	
12	NB đã từng can thiệp hay phẫu thuật gì trước đây chưa?		☒ Không ☐ Có Số lần	
13	Hiện tại NB đang có thai hay nghi ngờ có thai hay không? **(Phụ nữ)**		☒ Không ☐ Có Số lần	

NGUYỄN ĐẠNG HƯNG

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRUNG TÂM CĐHA & CTĐQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN TIÊM THUỐC CẢN QUANG

Tên tôi là : con: Lê Doãn Thái Bình Năm sinh : 2003

☐ 1.Là người bệnh

☒ 2.Là người nhà của người bệnh LÊ DOÃN CẦN Năm sinh : 1956

Sau khi được BS khai thác thông tin về tiền sử dị ứng và các bệnh khác liên quan của người bệnh và giải thích về yêu cầu cần phải tiêm thuốc cản quang để chẩn đoán bệnh, các tai biến có thể có của thuốc (dị ứng thuốc, sốc phản vệ dẫn đến tử vong...), tôi hiểu tai biến dị ứng thuốc, sốc phản vệ là biến cố ngẫu nhiên về y tế, khách quan ngoài ý muốn của bệnh viện và người bệnh

Tôi đồng ý cho bản thân tôi/Người nhà tôi được tiêm thuốc cản quang

Trong trường hợp xảy ra các tai biến do tiêm thuốc, bản thân tôi/Gia đình chúng tôi xin chấp nhận các rủi ro và cam kết không thắc mắc, khiếu kiện gì.

Nếu người bệnh bị tai biến do thuốc phải nhập viện theo dõi, điều trị thì bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về điều trị chuyên môn còn mọi chi phí điều trị do người bệnh phải chi trả như những người bệnh khác./.

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI CAM ĐOAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Con - LÊ DOÃN Thái Bình
16/10/2026 11:05:22

3. Số điện thoại liên hệ với người cam đoan: 0332482350

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG KIỂM ĐẾM GẠC, DỤNG CỤ SẮC NHỌN, DỤNG CỤ

Phòng mổ: 6 Ngày 16 tháng 10 năm 2026

- Họ và tên bệnh nhân: LÊ DOÃN CẦN Tuổi: 70 Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Tên dich vụ Phẫu thuật nội soi cắt túi mật
- Phương pháp phẫu thuật: .
- Phẫu thuật viên : Nguyễn Đăng Hưng Dụng cụ viên: Ngô Kim Bằng

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Dụng cụ vật tư cần kiểm đếm	Trước khi rạch da	Số lượng cung cấp thêm				Đếm khi đóng khoang rỗng	Khi đóng da
Gạc to							
Meche							
Gạc con	20					20	20
Củ ấu							
Bông sọ não							
Gạc nội soi	12					12	12
Kim	2					2	2
Dao	1					1	1
Bộ dụng cụ ht	32					32	32
ns	44					44	44

Ghi chú: Dụng cụ Bằng

Kết thúc cuộc phẫu thuật: ☒ Kiểm đủ ☐ Không đủ

Mô tả vật dụng mất:

Thông báo cho Phẫu thuật viên: ☐ Không ☐ Có

Kiểm tra XQ: ☐ Không ☐ Có

Kết quả: ☐ Tìm được vật dụng

Không tìm được (ghi rõ)

Xử lý:

PHẪU THUẬT VIÊN	ĐIỀU DƯỠNG VÒNG TRONG	ĐIỀU DƯỠNG VÒNG NGOÀI
(kí ghi rõ họ tên)	(kí ghi rõ họ tên)	(kí ghi rõ họ tên)
BSCKII. Nguyễn Đăng Hưng Ký số bởi: NGUYỄN ĐĂNG HƯNG Ngày ký: 23:26:34 16/10/2026	ĐD. Lương Thị Hiền	ĐD. Lương Thị Hiền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã NB: 2610036327
Mã HS: 2610163961

BẢNG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM CHO NGƯỜI BỆNH

Họ tên NB: **LÊ DOÃN CẦN** Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
Phòng: Phòng 302 Giường: H053

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Thời gian theo dõi	08:00 16/10/2026	15:15 16/10/2026	17:24 16/10/2026	...:... .../.../...	...:... .../.../...
Tuổi	70	70	70	70	70
Nhịp thở (lần/ phút)	16	25	19		
SpO_2 (%)	95	93	93		
Hỗ trợ oxy	☐	☐	☐	☐	☐
Huyết áp tâm thu (mmHg)	152	146	132		
Mạch (lần/ phút)	98	104	91		
Ý thức: - Tỉnh táo **(0 điểm)** - Rối loạn ý thức mới **(3 điểm)** - Đáp ứng với lời nói **(3 điểm)** - Đáp ứng với kích thích đau **(3 điểm)** - Không đáp ứng **(3 điểm)**	 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nhiệt độ (^oC)	36.9	36.6	36.3		
Tổng	2	6	3		
Mức độ theo dõi	Mỗi 6h	Mỗi 1-2h	Mỗi 6h		
Phản ứng lâm sàng	Đánh giá tại giường bởi điều dưỡng	Điều dưỡng thông báo cho Bác sĩ để đánh giá	Đánh giá tại giường bởi điều dưỡng		
Ký(1)	chintk	nttrang	thuyhoai		